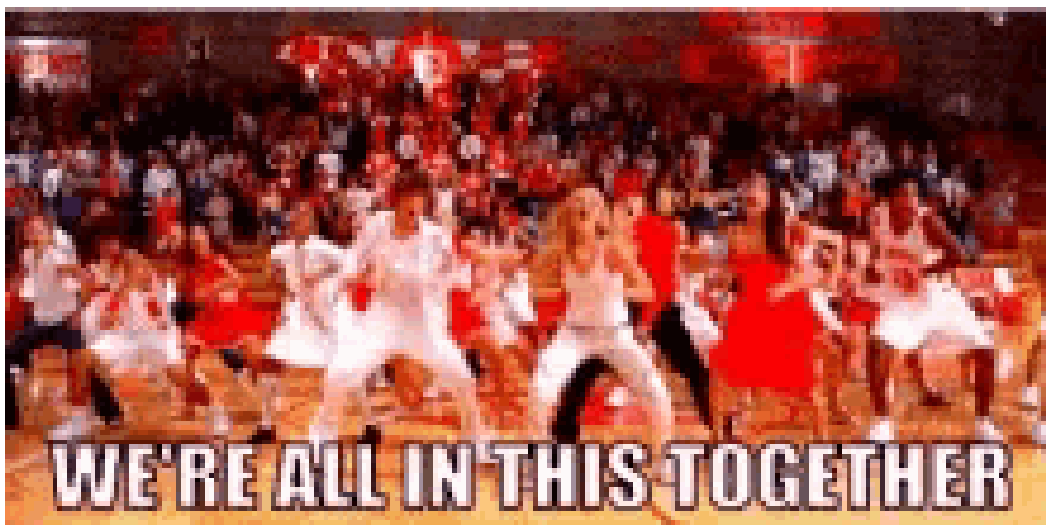


EFU POR TEMAS

DISCLAIMERS:

- Leí los casos muy por arriba y los dividí en base a lo que me pareció que tenía el paciente. Puede ser (y es muy probable) que me haya confundido en más de uno, así que no se basen en la clasificación para pensar en el diagnóstico.
- La sección “TEMAS VARIOS” son casos que, o abarcan más de un tema, o no tenía la más pálida idea de dónde meterlos. A medida que los voy resolviendo los vuelvo a clasificar.
- Hay casos que por el enunciado parece que están repetidos pero después las opciones son distintas. Otros son exactamente iguales y me dio flojera buscarlos y borrarlos.

PD: La vamos a romper



1. NEO

1. Ud. atiende en su consultorio a Pablo un neonato de 14 días de vida que concurre para control. Es un nacido de término, de un embarazo controlado y sin patologías del embarazo. Pesó 2800 grs al nacer y fue dado de alta al 3° día con 2600 grs. Las vacunas están completas. Se alimenta con lactancia materna exclusiva. Presenta deposiciones diarias color amarillo oro y la diuresis está conservada. Al examen físico se encuentra vigoroso, con ictericia en cara, no se auscultan soplos cardíacos, el abdomen es blando y sin visceromegalias. El peso actual es de 2780 grs.

Pregunta: ¿Cuáles son las conductas más adecuadas? (Marque hasta 3 opciones)

- A. Suplementar con fórmula de inicio.
- B. Solicitar orina completa y urocultivo.
- C. Solicitar serologías. (embarazo controlado y sin patologías del embarazo.)
- D. Citar a control de peso.**
- E. Promover la lactancia materna exclusiva**
- F. Suplementar con sulfato ferroso.
- G. Solicitar dosaje de bilirrubina.
- H. Evaluar técnica de amamantamiento**
- I. Solicitar hepatograma, hemograma y Coombs.
- J. Indicar metoclopramida a la madre para aumentar la producción láctea.

2. Ud se encuentra otorgando el alta de lán, un recién nacido de 39 semanas de edad gestacional, que pesó 2500 gr al nacer, peso actual 2400 gr. La familia está formada por madre, padre y dos hermanitos que concurren a la escuela, uno de ellos está con fiebre y cursando una virosis respiratoria.

Pregunta: Además de aconsejar y supervisar la técnica de lactancia, cuáles son las conductas adecuadas en este momento? (Marque hasta 3 opciones)

- A. Verificar que se haya realizado la pesquisa metabólica neonatal**
- B. Postergar la realización de la pesquisa neonatal en virtud del peso del bebe
- C. Verificar la aplicación de vacuna de hepatitis B y demorar la BCG hasta alcanzar los 3000 gr de peso
- D. Verificar la aplicación de la hepatitis B en el momento del nacimiento y aplicar BCG antes del alta.**
- E. Indicar a lán vacuna antigripal antes del alta.
- F. Indicar que incorporen en los primeros días de vida el chupete.
- G. Indicar colocarlo a dormir en posición supina**
- H. Recomendar que duerma inicialmente en otra habitación.
- I. Instruir a la familia cómo retirar e higienizar el prepucio desde los primeros días de vida.
- J. Sugerir que el hermano enfermo permanezca en el domicilio de un familiar hasta el alta.

3. Emilio de 1 mes y 17 días de vida asiste a guardia junto a sus padres, Claudia y Marcos. Refieren que Emilio, único hijo, hace 12 horas está decaído y presentaba vómitos postprandiales desde hace 1 semana. Toma pecho con mayor avidez. En las últimas horas presentó 4 vómitos en chorro. Siempre afebril.

Como antecedentes, Emilio es un recién nacido de término de peso adecuado para la edad gestacional (3100 gr), nacido por parto vaginal en presentación cefálica. Estuvo 4 días internado en neonatología por hiperbilirrubinemia y requerimiento de luminoterapia. Luego fue dado de alta. Caída del cordón umbilical a los 10 días de vida. Pesquisa neonatal: no fue retirada. Se alimenta actualmente solo a pecho a libre demanda.

Peso al mes de vida: 3700 gr.

Al examen físico: se encuentra en regular estado general, presenta fontanela deprimida, leve en cara ictericia. Frecuencia cardíaca 180 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 45 respiraciones por minuto, Sat 98% aire ambiental, T° 36.9 C, mucosas secas, diuresis disminuida en las últimas horas, hemodinámicamente compensado. Buena entrada de aire bilateral, murmullo vesicular conservado, sin ruidos agregados. Abdomen blando, depresible, indoloro, ruidos hidroaéreos positivos. Resto del examen físico s/p.

Peso actual: 3750 gr.

Pregunta: De acuerdo a su hipótesis diagnóstica, ¿cuál es la conducta diagnóstica adecuada? (Marque hasta 3 opciones)

- A. Ecografía abdominal
- B. EAB, ionograma, glucemia, urea, creatinina
- C. Interconsulta con cirugía infantil
- D. Hemograma, PCR, procalcitonina.
- E. 2 hemocultivos.
- F. Orina completa y urocultivo.
- G. Punción lumbar para citoquímica y cultivo
- H. pHmetría de 24 horas.
- I. Ecografía renovesical.
- J. Interconsulta con gastroenterología.

4. Lara es traída a la guardia por haber presentado un registro de temperatura axilar de 38,5°C grados constatada en el domicilio por sus padres. Es la primer hija de la pareja, tiene 21 días de vida. El embarazo cursó sin complicaciones, serologías y pesquisa para estreptococo negativas. Nació a término por cesárea por trabajo de parto prolongado y signos de sufrimiento fetal. Apgar 8/10 7-10. Peso de nacimiento 2940 gramos. Isogrupo, isofactor. Recibió vacuna antihepatitis B y BCG. No presentó complicaciones y fue dada de alta conjunta a las 72 hs de nacida. Alimentada a pecho exclusivo a libre demanda. Catarsis diaria de color amarillenta de consistencia blanda. Refiere la madre que siguió con el ritmo

habitual de alimentación. Pesquisa metabólica neonatal pendiente resultado y auditiva normal.

Al examen físico, se encuentra vigil, tranquila, normocoloreada. Frecuencia cardíaca 120 latidos por minuto 120-180, frecuencia respiratoria 44 por minuto 30 - 50, temperatura axilar 38,5°C grados. Relleno capilar menor a dos segundos.

Auscultación cardíaca y pulmonar normal. Abdomen: se palpa hígado y bazo a 1 cm del reborde costal. Fontanela permeable, se observan latidos en la misma. Resto del examen dentro de límites normales.

Pregunta: ¿Cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? (Marque hasta 4 opciones)

- A. Indicar paracetamol vía oral y control en 1 hora.
- B. Indicar paracetamol vía oral y control en 24 horas
- C. Internar a la sala
- D. Solicitar hemograma, PCR y orina completa
- E. Solicitar hemocultivos, urocultivo
- F. Realizar punción lumbar para físico químico y cultivo
- G. Solicitar panel respiratorio de vía aérea superior.
- H. Solicitar coprocultivo e hisopado anal y nasal.
- I. Solicitar radiografía de tórax.
- J. Solicitar serologías para TORCH.

5. Mónica y su marido concurren muy preocupados a la guardia de Pediatría con su bebé de 30 días de vida. Refieren que la niña se encuentra molesta, que llora mucho y se calma al tomar el pecho. También les preocupa que no sostiene la cabeza. Es su primer bebé y no saben bien qué hacer. Antecedentes:

Recién nacido de 40 semana de edad gestacional, peso al nacer: 3500 gr, G1 P1 Apgar 9/10 7-10. Embarazo controlado. Vacunas recibidas: BCG y hepatitis B.

Serologías (HIV, VDRL, chagas, toxoplasmosis): Negativas. Pesquisa metabólica neonatal: No la retiró. Antecedentes perinatólogicos y familiares: No refiere.

Realizó control en neonatología a los 7 días de vida: Pesó 3200 gr y luego a los 15 días: 3480 gr. Se alimenta a pecho exclusivo, moja entre 6 a 7 pañales/día y posee deposiciones líquidas con grumos Normal. Al examen físico: Peso 3.900 gr.

Se encuentra en buen estado general, sin datos relevantes al examen físico. Reflejos Arcaicos presentes.

Pregunta: De acuerdo a todos los datos aportados, qué recomendaciones daría a la familia? (marque hasta 3 correctas)

- A. Indicar pecho más leche de fórmula.
- B. Explicar a los padres que el llanto de la niña es normal.
- C. Administrar a la bebé gotas antiespasmódicas.
- D. Indicar a la madre que continúe con pecho exclusivo.
- E. Interconsulta con neurología.
- F. Realizar coprocultivo.
- G. Indicar a la madre líquidos y descanso adecuados.
- H. Definir horarios estrictos para alimentarlo.
- I. Indicar que duerma boca abajo para aliviar los cólicos.
- J. Indicar dieta libre de proteína de leche de vaca a la madre.

6. La mamá de Sabrina de 20 días de vida, concurre a la consulta porque "la nota muy amarilla". El embarazo y el parto fueron normales. Nació a término con 3200 gramos, Apgar vigoroso. Grupo sanguíneo de la madre y de Sabrina A +. Alta a las 48 horas sin problemas perinatales. Pesquisa metabólica neonatal pendiente, otoemisiones acústicas normales. Se alimenta a pecho exclusivo.

En el control a los 7 días de vida presentaba leve ictericia en cara, buen aumento de peso. Resto del examen físico es normal, a los 14 días el examen físico es normal, con buen progreso de peso.

Ahora se nota ictericia generalizada. Usted solicita laboratorio: hemoglobina 11 g/dl 14,5-22,5, hematocrito 33% 45-64, bilirrubina total 10 mg/dl 1 , directa 9 mg/dl 0,2.

Pregunta: Ante esta situación Ud cree que la conducta más apropiada es: (Marque hasta 3 opciones).

- A. Tranquilizar a la madre explicándole que la ictericia disminuirá gradualmente durante los próximos días.
- B. Suspender temporalmente la alimentación materna.
- C. Suspender la alimentación materna de modo permanente y continuar alimentando a Sabrina con fórmula maternizada.
- D. Efectuar una prueba de compatibilidad para descartar incompatibilidad ABO.
- E. Efectuar una prueba de compatibilidad para descartar incompatibilidad Rh.
- F. Investigar cambios en la coloración de la orina y la materia fecal.
- G. Solicitar ecografía hepática.
- H. Internar a Sabrina para efectuar luminoterapia.
- I. Internar a Sabrina para efectuar una exanguinotransfusión.
- J. Solicitar una consulta lo antes posible, con el hepatólogo y el cirujano pediatra.

7. En la sala de internación conjunta se encuentra Lucía con su bebé, Tomás, de 18 horas de vida. Es un RNT, 38 semanas, PAEG, PN 2900 g, grupo y factor A +, prueba de coombs directa positiva, Apgar 9/10, G2P2A0C0, con cordón umbilical en período de cicatrización clampeado. Antecedentes de embarazo: fue controlado, con serologías negativas para toxoplasmosis, sífilis, hepatitis B y HIV. Grupo y factor de Lucía 0 +. Tomás tiene un hermano de 3 años que requirió luminoterapia durante dos días a la semana de haber nacido. Usted va a realizar el control de Tomás y lo observa con ligera palidez, leve taquicardia, insuficiencia respiratoria, fontanela anterior permeable, facies conservada, tinte amarillo en conjuntiva y piel hasta el ombligo aproximadamente, diuresis conservada. Peso actual 2800 g. No presenta cefalohematomas. Ha recibido la vacuna contra hepatitis B en sala de parto. Se encuentra con lactancia materna exclusiva

Pregunta: Ante su presunción diagnóstica, Usted: (Marque hasta 3 opciones)

- A. Indica aumentar frecuencia de mamadas.
- B. Solicita hemograma, hepatograma, fosfatasa alcalina y gamma glutamil transpeptidasa.
- C. **Explica a los padres del niño que es necesario realizar tratamiento y repetir controles.**
- D. Indica complemento con leche de fórmula.
- E. **Solicita hematocrito y bilirrubina total y directa.**
- F. **Indica luminoterapia o exanguinotransfusión según curvas de referencia.**
- G. Solicita 2 hemocultivos, urocultivo y cultivo de LCR.
- H. Solicita serologías para CMV y HSV.
- I. Solicita ecografía abdominal.
- J. Indica exposición solar breve diaria.

8. Usted se desempeña en una guardia médica. A las 22 horas atiende la consulta de una pareja que concurre con su hijo, Mateo, de 4 días de vida. Ellos se encuentran muy preocupados por notarlo más amarillo.

En la anamnesis los padres le informan que Mateo nació de parto vaginal y que fue egresado de la maternidad hace 48 horas. La médica que lo egresó realizó un control de bilirrubina y les dijo que por el momento no necesitaba tratamiento. Los citó para el control a consultorio en 24 horas. Los padres ni pudieron concurrir por no tener con quién dejar a los otros niños.

En el resumen del egreso de neonatología consta: gestas 3, partos 3, embarazo controlado, peso al nacer: 3.100 gr, edad gestacional: 38 semanas y egresado a las 48 horas de vida con un peso de 2.900 gr. Determinación de bilirrubina total de 11,5 mg/dl. Grupo y RH de madre e hijo: 0 positivo. Coombs negativa. Alimentado con pecho exclusivo.

Los padres comentan que Mateo se alimenta bien, tiene diuresis y catarsis conservadas, y no han notado otro síntoma que les llame la atención.

Al examen físico Ud. encuentra a Mateo con ictericia que se extiende hasta rodillas. El resto del examen físico se encuentra dentro de parámetros normales.

Ante esta situación, usted, ¿qué decide? Marque 3 opciones

Seleccione una o más de una:

- A. Indicar exposición a la luz solar y nueva consulta a los 7 días de vida.
- B. Solicitar hematocrito
- C. Concurrir a control clínico en 2 días
- D. Explicar a los padres que la ictericia es un proceso fisiológico y que el riesgo depende del valor de bilirrubina que tenga en este momento.
- E. Solicitar un dosaje de bilirrubina total y directa por guardia.
- F. Solicitar un dosaje de bilirrubina total y sedimento urinario por guardia.
- G. Suspender la lactancia materna por 24 horas e indicar fórmulas lácteas
- H. Citar a una nueva consulta para el día siguiente por la mañana para realizar una evaluación de la ictericia con luz de día.

9. La mamá de Sabrina de 14 días de vida concurre a la consulta porque la nota amarilla cada día un poco más” El embarazo y el parto fueron normales. No se había notado ictericia en las primeras 48 horas. El peso de nacimiento fue de 3200 gramos y se alimenta a pecho exclusivo. Actualmente pesa 3.300 gramos.

Ante esta situación, usted, ¿qué conductas adopta? Marque 3 opciones

Seleccione una o más de una:

- A. Efectuarle una prueba de compatibilidad para descartar incompatibilidad ABO.
- B. Efectuarle una prueba de compatibilidad para descartar incompatibilidad Rh.
- C. Indicar luminoterapia dentro de las próximas 48 horas.
- D. Descartar lo antes posible la presencia de colestasis neonatal.
- E. Suspender la alimentación materna e indicar que Sabrina se alimente con fórmula maternizada.
- F. Efectuarle una determinación de bilirrubina total, directa e indirecta.
- G. Investigar la coloración de la orina y la materia fecal de Sabrina.
- H. Tranquilizar a la madre y explicarle que la ictericia que Sabrina presenta disminuirá paulatinamente durante los próximos días.

10. Concorre al consultorio la madre de César, de 4 semanas, por persistencia del color amarillo de la piel, que apareció al cuatro día de vida. No presentó vómitos y las deposiciones desligadas de color amarillo oro son tres al día. En dos oportunidades anteriores consultaron y fue interpretado como fisiológico. Trae un examen de orina completo normal.

Antecedentes personales: embarazo controlado, con serologías para rubéola y toxoplasmosis inmunes, así como para sífilis, hepatitis B y HIV negativas. Parto vaginal con presentación cefálica. Edad gestacional 41 semanas. Peso de nacimiento 3850 gramos. Apgar 9/10. Peso al alta a las 48 horas 3580 gramos, sin ictericia, con lactancia materna exclusiva. Grupo y factor materno A Rh (+) y de César A Rh (-). Cribado hipotiroidismo, fenilcetonuria y FQP negativos.

Antecedentes familiares: ambos padres sanos sin consanguinidad ni antecedentes de hepatopatía crónica.

EXAMEN FÍSICO Peso: 4450 gramos. Talla 51 cm. Perímetro cefálico 36 cm. Signos vitales: FC 140 lpm, FR 34 por minuto 30-50, temperatura axilar 36°C, oximetría con aire ambiental 95%. Buen estado general, ictericia de cara y tronco (zona 4 de Kramer). Cefalohematoma parietal derecho muy pequeño. Se palpa el borde hepático como 2 cm por debajo del reborde costal derecho a nivel de línea medio-clavicular, sin esplenomegalia. Resto sin particularidades.

Laboratorio: bilirrubinemia total 14.4 mg/dl, bilirrubinemia directa 1.8 mg/dl, TGP 15 UI/l, TGO 52 UI/l, glucemia 90 mg/dl, prueba de Coombs directa negativa

¿Cuáles son sus hipótesis y conductas iniciales? Marcar hasta 3 opciones.

Seleccione una o más de una:

- A. Asociar la ictericia de César al cefalohematoma.
- B. Indicar tratamiento antibiótico parental después de obtener urocultivo.
- C. Solicitar ecografía de abdomen urgente.
- D. Indicar fototerapia con cobertura ocular e genital.
- E. Confirmarle a los padres que se trata de una ictericia fisiológica del neonato.
- F. Indicar alimentación con fórmula sin lactosa y proteínas parcialmente hidrolizadas.
- G. Explicar a los padres que este cuadro se resolverá espontáneamente sin complicaciones.
- H. Informar a los padres que se trata de una ictericia por incompatibilidad Rh.
- I. Indicar que se prenda al pecho no menos de 8 veces al día.
- J. Suspender la lactancia materna.

11. Ingresa al Servicio de Obstetricia, María, de 24 años de edad, en trabajo de parto.

Antecedentes: FUM 38 semanas. Gesta 2 para 1. Embarazo controlado. Serologías, realizadas en el últimos trimestre del embarazo: lues, toxoplasmosis, HIV y Chagas, negativas; serología.

Hepatitis B: HBs Ag (antígeno de superficie) y H Be Ag (antígeno E), ambos positivos. Test de detección de Estreptococo beta hemolítico Grupo B vaginal y rectal negativos. No presenta otros antecedentes perinatales patológicos. Nace Mateo, presentación cefálica, parto vaginal. Rotura de membranas de 4 hs. Es un recién nacido de peso adecuado a su edad gestacional. Vigoroso.

¿Cuáles son las conductas más adecuadas para este caso? Marcar hasta 3 opciones.

Seleccione una o más de una:

- A. Solicitar serología para hepatitis B al recién nacido para decidir el momento de vacunación.
- B. Administrar 1 mg de vitamina K intramuscular a las 48 horas de vida.
- C. Indicar la realización de Otoemisiones acústicas como prueba de pesquisa para evaluar el funcionamiento coclear.
- D. Ubicar al neonato al pecho inmediatamente y comenzar la lactancia durante la primera hora de vida.
- E. Realizar el pasaje de sonda oral y rectal para descartar malformaciones.
- F. Solicitar la pesquisa de enfermedades endócrino metabólicas dentro de las 24 horas de vida.
- G. Indicar colirio con Tobramicina para profilaxis de oftalmía gonocócica y por Chlamydia.
- H. Colocar al neonato sobre su madre y realizar la ligadura del cordón umbilical a los 30 segundos de vida.
- I. Indicar vacuna BCG en sala de recepción.
- J. Indicar la aplicación de la vacuna antihepatitis B dentro de las 12 horas de nacido.

12. A la guardia de un hospital de segundo nivel, concurren los padres de Carlos, de 20 días de vida, por vómitos, rechazo a la alimentación e ictericia. No constataron fiebre y las deposiciones son escasas. Embarazo controlado, con serologías maternas negativas, nació por cesárea con 38 semanas de edad gestacional y 3.440 gramos de peso. Apgar 9/9. Lactancia materna exclusiva. Grupo y factor materno y de Carlos: O +. Fue dado de alta 72 horas atrás con diagnóstico de sepsis con cultivos negativos y examen de orina completa normal.

EXAMEN FÍSICO: Peso: 3.550 gramos. Talla 49 cm. Perímetro cefálico 36 cm. Signos vitales: FC 150 por minuto 120-180, FR 34 por minuto 30-50, temperatura axilar 36oC,

oximetría con aire ambiental 95%. Buen estado general, ictericia de cara y tronco, normohidratado y dormido en brazos de su madre. Ausencia bilateral de reflejo rojo pupila. Semiología cardiovascular y respiratoria normales. Abdomen levemente distendido, hígado de 9cm de altura total a nivel de línea medio lactante 4,5-5, >=12 7-8 H/6,5M claviclar, sin esplenomegalia. Resto sin particularidades.

Laboratorio: bilirrubinemia total 14mg/dl, bilirrubinemia directa 10 mg/dl, TGP 48 UI/l, TGO 52 UI/l, fosfatasa alcalina 800 UI/l(95-368), gamma glutamil transpeptidasa 250 UI/l 13-147, glucemia 75 mg/dl, albuminemia 3,6 3,2-5,4 g/dl. Tasa de protrombina 85%, KPTT 38 segundos. Cuerpos reductores en orina positivos. Pesquisa metabólica neonatal pendiente

¿Cuáles son sus conductas iniciales frente a la sospecha diagnóstica? Marcar hasta 3 opciones.

Seleccione una o más de una:

- A. Indicar tratamiento antibiótico parenteral después de obtener urocultivo
- B. Indicar alimentación complementaria con fórmula de inicio
- C. Indicar dosaje de hormonas tiroideas
- D. Solicitar telefónicamente el resultado de la pesquisa neonatal
- E. Indicar exposición al sol
- F. Indicar alimentación con fórmula láctea a base de soja
- G. Solicitar perfil inmunohematológico y haptoglobina
- H. Indicar fórmula de inicio libre de lactosa
- I. Suspender la lactancia materna
- J. Solicitar ecografía de abdomen

13. Concurren a un consultorio en el interior de Santa Fe, los padres de Julio, de 20 días de vida, por ictericia de piel y escleróticas. En dos oportunidades anteriores consultaron por un leve tinte amarillento que fue interpretado como fisiológico.

Nacido por cesárea con 38 semanas de edad gestacional y 3440 gramos de peso. Apgar 9/9. Grupo y factor materno y de Julio. A+. Alimentación con fórmula de inicio.

EXAMEN FÍSICO:

Peso: 3700 gramos. Talla 50 cm. Perímetro cefálico 36 cm.

Signos vitales: FC 140 lpm(120-180), FR 36 por minuto (30-50), temperatura axilar 36 °C, oximetría con aire ambiental 95%

Buen estado general, ictericia de cara y tronco. Se palpa el borde hepático romo 2 cm por debajo del reborde costal derecho a nivel de línea medio-clavicular, sin esplenomegalia. Resto sin particularidades.

LABORATORIO: bilirrubinemia total 15 mg/dl, bilirrubinemia directa 12,3 mg/dl, TGP 15 UI/l, TGO 52 UI/l (37), fosfata alcalina 1.995 UI/l (95-368), gamma glutamil transpeptidasa 790

UI/l (13-147), glucemia 90 mg/dl, albuminemia 3,9 g/dl(3,5 - 5,4). Tasa de protrombina 92%, KPTT 38 segundos.

¿Cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? Marcar hasta 3 opciones.

Seleccione una o más de una:

- A. Solicitar ecografía hepática y de vías biliares
- B. Indicar alimentación con fórmula sin lactosa y proteínas parcialmente hidrolizadas c. Solicitar interconsulta con Cirugía Infantil
- C. Indicar dosaje de hormonas tiroideas
- D. Solicitar telefónicamente el resultado de la pesquisa neonatal
- E. Tranquilizar a los padres e indicar exponer a Julio al sol
- g. Observar las características de las deposiciones
- F. Citar al control con hepatograma en cuatro semanas
- G. Solicitar radiografía de abdomen frente en posición vertical
- H. Indicar tratamiento antibiótico parental después de obtener urocultivo.

14. Concorre a la guardia del hospital con sus padres, Emanuel de 25 días de edad. Ellos refieren que su hijo comenzó con vomitos hace 5 días y con cada día que pasa, los vomitos son más abundantes e intensos. Emanuel se alimenta solo con leche materna, llora mucho, pareciendo que se queda con hambre. La madre intenta calmarlo ofreciéndole el pecho nuevamente, tras lo cual reaparecen los vomitos. 48hs antes concurre a un centro de salud próximo a su domicilio donde le indicaron complementar el pecho con un biberón de 100cc de fórmula espesada con cereal de arroz luego de cada mamada. La mamá comenta que antes del inicio de los vomitos, las deposiciones de Emanuel eran frecuentes, bastante blandas y amarillentas, pero en estos últimos días son mas escasas y algo más oscuras.

Antecedentes perinatales: Parto eutócico en cefálica. Apgar 9/10. Peso al nacer 3500 gramos. Talla 51,0cm. Perímetro cefálico 36,0cm. Alta a las 48 horas con peso de 3220 gramos. Control a los 15 días: 3600 gramos.

Examen físico: Buen estado general, fontanela normotensa, pupilas isocóricas, mucosas rosadas, buen relleno capilar. Normohidratado. Temperatura axilar: 37.1°C. Peso 3650 gramos (aumentó poco el peso). Buena entrada de aire en ambos campos pulmonares. Frecuencia respiratoria 40 respiraciones por minuto. Dos ruidos cardíacos en los cuatro focos. Silencios libres. Frecuencia cardíaca 140 latidos por minuto. Reflejos y tono muscular de acuerdo a la edad. Abdomen blando, depresible, levemente distendido en hemiabdomen superior. Hígado a 2cm del reborde costal en línea mamilar. Bazo no palpable.

Le efectúan a Emanuel exámenes complementarios que indican: Hemograma: Hematocrito 33%. Hemoglobina 11.2g/dl. Globulos blancos: 11.700/mm³. Linfocitos 53%. Neutrófilos 38%. Eosinófilos 4%. Monocitos 5%. Basófilos 0%.No infeccioso Frotis: eritrocitos normocíticos y normocrómicos. Eritrosedimentación: 8 mm/h. Estado Acido-Basico ph 7,63 Alcalosis. Bicarbonato: 39,5; Ionograma: Na 135mEq/L. K: 2,8 mEq/L. 3,5-5 Cl: 90mEq/l 96-108. Coagulograma: concentracion de protrombina 85% . Hepatograma: bilirrubina total: 0.8mg/dl. bilirrubina indirecta: 0.5mg/dl. bilirrubina directa: 0.3mg/dl. TGP: 48UI/L; TGO: 35 UI/L. Orina completa: 1020. Sedimento: escasos cilindros hialinos. También le realizan una ecografía abdominal.

De acuerdo con los datos clínicos y de laboratorio presentados y el informe en curso de la ecografía, que definirá el diagnostico que Ud. Presume.

¿Cuáles son las conductas más apropiadas para la resolución de la afección que presenta Emanuel? Marque hasta 2 opciones.

- A. Enviar a Emanuel a su domicilio y recomendar a los padres que no le ofrezcan biberones cada vez que lllore.
- B. Mantener los biberones de cereales de arroz después de las mamadas y agregar aceite al 1%.
- C. Efectuar cirugía, previa corrección de las alteraciones del medio interno.**
- D. Internar e indicar prueba tolerancia por vía oral con sales de rehidratación oral por cucharitas.
- E. Internar, indicando ayuno, e hidratación parenteral.**
- F. Continuar con la lactancia y ofrecer sales de rehidratación oral por cucharitas luego de cada vómito.
- G. Internar a Emanuel y enviarlo con urgencia a cirugía.
- H. Indicar expansión rápida con solución fisiológica a 20 cc/kg.

15. Darío, de 1 mes de edad, concurre con sus padres a una consulta en salud. Su mamá, Mónica, está preocupada porque, desde hace 6 días 10, no ha presentado deposiciones 10. Refiere que con frecuencia llora y se pone colorado, antes de evacuar materia fecal. La última deposición fue a los 24 días de vida. La materia fecal fue de consistencia blanda, grumosa, color amarillo oro.

Antecedentes de embarazo y parto: primer embarazo, controlado, de término. Parto eutócico en cefálica. Apgar 9/107-10. Alimentación exclusiva con leche materna. Mónica refiere que el cordón umbilical cayó al octavo día de vida, y que eliminó meconio a las 24 horas de haber nacido. La prueba de pesquisa neonatal esta pendiente. Antecedentes personales: Peso al nacer 3400 gramas. Al alta, 48 horas de vida: 3300 gramas. Control a los 7 días de vida: 3100 gramas.

Darío tiene sueño tranquilo. Solo se despierta para tomar el pecho. Succiona con avidez y parece disfrutar el momento de alimentarse. Pocas veces esta algo llorón. Presenta una

regurgitación escasa luego de alguna de las tomas. Examen físico: buen estado general. Peso actual 3850 gramos. El abdomen es globuloso, blando y la palpación no desencadena llanto. El hígado se palpa a 2.5cm del borde costal en la línea axilar media y el polo de bazo se insinúa bajo la parrilla costal izquierda. No se palpan masas fecales.

Cuales son las conductas mas adecuadas a seguir con Darío? Marcar hasta 3 opciones.

- A. Colocar un supositorio de glicerina si Darío no presenta deposiciones en las próximas 24 horas
- B. Comenzar la administración de lactulosa si no constatan dispositivos luego de siete días
- C. Informar a los padres que el ritmo evacuatorio de Darío es normal al estar alimentado exclusivamente con leche materno
- D. Administrar jugo de compota de ciruelas por medio de un gotero durante 48-72 horas
- E. Efectuar la consulta en un servicio de emergencia si luego de siete días Darío no ha presentado deposiciones
- F. Mantener la alimentación materna a libre demanda
- G. Informar a los padres que el llanto y el "ponerse colorado" no indica que Darío esta constipado
- H. Complementar la alimentación con fórmula de inicio

16. Nicolás tiene 42 días de vida. Concorre con sus padres a la consulta debido a que presenta un cuadro febril de 24 horas de evolución. Ellos se encuentran muy preocupados y refieren que Nicolás se alimenta con lactancia materna exclusiva cada 3hrs, viven a 3 cuadras del hospital. Usted realiza la anamnesis completa y el examen físico de Nicolás. No presenta antecedentes del embarazo ni perinatólogicos de importancia. Nació de término, con un peso de 3200gs. Regurgita ocasionalmente. Al momento del examen físico, Nicolás presenta 38.6°C, no presentando otros datos positivos ni foco infeccioso evidente. Se le realiza por guardia un laboratorio inicial con los siguientes resultados. Glóbulos blancos 21.000/mm³, NS 70% (hasta 45 es normal), L 30%, Hb 9.5gr/dl, plaquetas 240000/mm³. Proteína C reactiva 50 mg/l

Sedimento urinario normal Hemocultivos e urocultivos : pendiente resultados.

De acuerdo a su interpretación diagnóstica, cuales de las siguientes son las conductas inmediatas más adecuadas. Marcar hasta 3 opciones

- A. Indica cefalexina vía oral hasta recibir la lectura del urocultivo
- B. Realizar punción lumbar y medicar empíricamente con antibióticos por vía endovenosa
- C. Indicar antitérmicos y antibiótico por vía oral
- D. Solicitar RX de tórax
- E. Internar a Nicolás
- F. Posponer punción lumbar de no mediar signos neurológicos y medicar urgente con antibióticos por vía endovenosa
- G. Dar pautas de alarma y enviar al domicilio regresando a control en 24 horas
- H. Mediar por vía intramuscular con antibióticos y control en 24hrs

17. Mariana de 25 años acude a su centro de salud a un control postparto a los 6 días del nacimiento de Sofía, una RNTPAEG (3.350 gr, Apgar 9/10 7-10) que recibe lactancia materna exclusiva. La madre presenta grietas en ambos pezones. Al no acudir con Sofía, no se puede valorar la técnica alimentaria. Se recomienda para conseguir la cura de las grietas, dejar los pezones al aire libre y de lactancia para conseguir variar los puntos de presión y disminuir el dolor. Se cita en cuatro días para ver su evolución y se recomienda acudir con la recién nacida para valorar la toma.

A los 9 días Mariana sigue presentando grietas en el pezón izquierdo, que no han mejorado a pesar de llevar a cabo las recomendaciones. Refiere un dolor muy intenso como “pinchazos” que le hace dificultoso amamantamiento del pecho izquierdo, el cual la niña hace un día que lo rechaza e no quiere mamar del mismo.

A la palpación, le aprecia una pequeña induración en el cuadrante superior externo de la mama, con dolor, calor y rubor. Fue medicada por su obstetra con Cefalexina vía oral. La grieta del pezón derecho está cicatrizando y ya no le duele al mamar. Se valora la toma: se observa un buen agarre y una succión en el pecho que la lactante acepta.

En esta situación usted, que le aconseja? Marcar hasta 3 opciones.

- A. Indicar tratamiento tópico con mupirocina sobre la mama afectada cada 12 horas por 7 días
- B. Aconsejar amamantar a libre demanda, ofreciendo también el pecho afectado
- C. Rotar tratamiento de la madre a amoxicilina a dosis habituales por 5 a 7 días, según evolución
- D. Suspender la lactancia del lado afectado, de manera transitoria**
- E. Intercalar lactancia materna con fórmula de inicio
- F. Vaciar eficazmente el pecho que rechaza la lactancia durante 20 min a cada 3 horas**
- G. Suspender antibióticos maternos, por el pasaje a través de la leche
- H. Indicar Paracetamol o Ibuprofeno cada 6 u 8 horas a la mama**

18. Concorre a control Johana con su hija Juanita de 10 días de vida. Se trata de una recién nacida de embarazo controlado sin patología. Alta a las 72 hs de vida. Nació a término (40 semanas) y con 3000 gr de peso. Al examen físico actual pesa 2.900 gr y se presenta en buen estado general, vital y reactiva. Se observa tinte icterico hasta las rodillas. Aún no se le ha caído el cordón. No se palpan visceromegalias. Se alimenta con lactancia materna exclusiva.

¿Cuáles de las siguientes son las conductas iniciales correctas? (Marque hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

- A. Tranquilizar a Johana y control ambulatorio en 48 hs.
- B. Solicitar ecografía hepática y de vías biliares.
- C. Indicar luminoterapia y si no funciona exanguinotransfusión.
- D. Solicitar hemograma, hepatograma y orina completa.

E. Solicitar hematocrito, dosaje de bilirrubina total y directa.

F. Solicitar test de Coombs.

G. Indicar a la madre colocar a Juanita al sol a través de la ventana.

H. Solicitar grupo sanguíneo y factor Rh de Johana y de Juanita.

19. Ud. se desempeña como médico generalista de guardia en una clínica, ese día le comunican que el pediatra no puede concurrir porque fue diagnosticado covid +. Entonces Ud. debe realizar el control de Martín, un recién nacido que se encuentra con su madre en internación conjunta y le acaban de dar el alta. Martín nació de parto normal, pesó 3.500 grs.

En la epicrisis de alta Ud. lee, Apgar 9/10 7-10 y que ya recibió vacunas hepatitis B y BCG.

¿Qué pautas le indica a la mamá para el cuidado de su bebé en el hogar? (Marque hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

A. Indica dejar una gasa húmeda con alcohol luego de finalizar la higiene del cordón.

B. Indica dormir con enteritos de algodón y posición supina del bebé.

C. Indica colocarlo al pecho cada tres horas, 5 minutos de cada lado

D. Indica limpieza del cordón con alcohol.

E. Sugiere que es mejor colocar una pequeña almohada para posicionar la cabeza.

F. Indica para el sueño seguro colocarlo en posición ventral.

G. Sugiere dar de mamar a libre demanda.

H. Sugiere que si el recién nacido llora mucho, complementar su alimentación con leche de fórmula.

20. Gemma tiene 9 días de vida y es traída a la consulta por su madre, muy preocupada, ya que manifiesta que “no le baja suficiente cantidad de leche de sus pechos”, y que la niña desde hace 2 días no presenta deposiciones. Antecedentes: embarazo controlado, sin patología gestacional.

Gemma es una RNT, sana, con peso de nacimiento: 3,200 kg, talla: 49,0 cm y perímetro cefálico: 35,0 cm. Se alimenta con lactancia materna exclusiva desde el nacimiento. Peso al alta: 2,900 Kg.

El examen físico es normal. Peso actual: 3,180 kg.

Frente a esta situación Ud. decide: (Puede elegir 3 opciones)

Seleccione una o más de una

A. Observar técnica de amamantamiento.

B. Continuar con lactancia materna exclusiva.

C. Indicar gotas de simeticona.

- D. Indicar a la madre metoclopramida.
- E. **Aconsejar a la madre que ingiera abundantes líquidos.**
- F. Medica a Gemma con lactulosa.
- G. Indicar supositorios de glicerina.
- H. Agregar fórmula para complementar la lactancia materna.

21. Enrique de 7 días de vida es traído a la consulta porque presenta tendencia al sueño, succión débil y un vómito. Al examen físico se observa ictericia y hepatomegalia. Aún persiste cefalohematoma bilateral en cuero cabelludo. Resto del examen físico normal. Se trata de un recién nacido de término con peso adecuado a su edad gestacional (39 semanas / 2950gr). Embarazo controlado sin patología. Alimentado con lactancia materna exclusiva. La bilirrubina total sérica es de 17mg/dl , bilirrubina directa 4mg/dl.

¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales más probables? Marque hasta 3 opciones

- A. Ictericias por déficit de glucosa 6 PD.
- B. Ictericia por lactancia materna.
- C. Ictericias por hemoglobinopatías.
- D. **Ictericia por atresia de vías biliares.**
- E. Ictericia por cefalohematoma.
- F. Ictericia fisiológica.
- G. **Ictericia por infecciones intrauterinas tipo TORCH.**
- H. **Ictericia por sepsis neonatal.**

22. Usted se encuentra de guardia en un hospital materno infantil, y lo llaman a sala de partos, porque Marta, de 25 años de edad, que cursa su primer embarazo, controlado, y de bajo riesgo, se encuentra en periodo expulsivo (dentro de una maternidad segura y centrada en la familia, donde se cumplen las consignas de parto respetado). Nace un varón de término, respira y llora espontáneamente, es vigoroso, con buen tono muscular, líquido amniótico claro.

¿Cuál es su conducta apropiada? Marque hasta 3 opciones

- A. Realizar el clampeo del cordón inmediatamente y trasladar al niño a la sala de recepción.
- B. **Colocar al niño sobre el pecho materno mientras aguarda 1 a 3 minutos para el clampeo del cordón.**
- C. Realizar la identificación en la sala de recepción durante el examen físico completo y sistematizado.
- D. Realizar en la sala de recepción la toma de muestra para la pesquisa neurometabólica
- E. **Realizar la identificación del recién nacido antes de salir de la sala de partos.**
- F. Realizar en la sala de recepción las otoemisiones acústicas.
- G. Luego de realizar las rutinas en la sala de recepción dejar al niño en observación durante 1 hora.

H. Luego de realizar todas las rutinas, el recién nacido inmediatamente regresa junto a su madre al sector de internación conjunta.

23. Carla es una recién nacida de 2 días de vida, se encuentra en internación conjunta con su mamá. La madre le refiere que desde la noche anterior está "lenta para comer" y le notó un pequeño movimiento en las manos y los pies.

Antecedentes perinatales: cesárea a las 38 semanas, extracción dificultosa con procidencia del cordón. Apgar 5-8.7-10 Se recuperó rápidamente con oxígeno libre. Peso 3.420 grs. (Pc50), talla 50.0 cm(Pc 50), Perímetro cefálico: 34.0 cm. (Pc 50). Se aplicó Vitamina k y vacuna anti-hepatitis B. Serologías maternas negativas.

Examen físico: pálida, temperatura axilar 35 grados, hipotonía generalizada, temblores finos espontáneos en miembros. Quejosa por momentos. Fontanela anterior abombada. Frecuencia cardíaca: 130 por minuto . Ruidos cardíacos presentes en cuatro focos. Frecuencia respiratoria: 60 por minuto.. Se auscultan rales diseminados. Abdomen distendido, impresiona doloroso a la palpación. Hígado 2 cm. por debajo del reborde costal, bazo palpable 1 cm por debajo del reborde.

Ud. decide su ingreso a Unidad de Cuidados Intensivos neonatal y realiza los siguientes estudios: Hemograma: hematocrito: 35 %, hemoglobina: 12 g/dl, glóbulos blancos 3000/mm³.(NS: 64 NC: 20 L: 25 /E:2/ B:1 0,6/M:4 5-8), plaquetas: 110.000 mm³. Radiografía: pulmón infiltrado reticular fino bilateral, abdomen irregular distribución de aire, hígado y bazo aumentados. Hemocultivo en proceso. LCR: xantocrómico(amarillento), sin coágulo, glucosa no dosable, proteínas 100 mg/dl, en el directo se observan abundantes diplococos, abundantes leucocitos y hematíes.

De acuerdo al examen físico y el laboratorio. ¿Cuáles de los siguientes diagnósticos son los más probables? (Puede marcar hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

- A. Hemorragia intracraneana.
- B. Hipoglucemia.
- C. Sepsis no bacteriana.
- D. Meningitis bacteriana.
- E. Sepsis bacteriana.
- F. Enfermedad de membrana hialina.
- G. Sepsis neonatal tardía.
- H. Sepsis intrahospitalaria.

24. Vito, de 1 mes de edad es llevado a la consulta por sus padres porque notan en su piel un tono amarillento, no lo había notado claramente los días siguientes al nacimiento pero desde hace varios días parece un poco más intenso. Concorre con algunos estudios que le

han efectuado durante el embarazo y también algunos exámenes solicitados a Vito por un colega anteriormente.

Vito es fruto de un primer embarazo, de término, con control prenatal. Peso adecuado para la edad gestacional. Se constató eliminación de meconio a las 36 horas y la caída del cordón ocurrió al 7o día de vida. Hasta ahora ha sido un bebé activo, con buena disposición para alimentarse. Recibe exclusivamente leche materna.

Examen físico: Piel y conjuntivas ictericas. Peso 4.0 kg, Talla 54.0 cm. Perímetro cefálico 38.0 cm. Temperatura 37°C. Frecuencia respiratoria 40/minuto. Frecuencia cardíaca 120/minuto. Hígado firme con borde romo, a 3 cm del reborde costal. Resultado de los estudios de Vito: Grupo y factor: 0 Rh (-) IgG para hepatitis A (+). Frotis de sangre periférica: glóbulos rojos normocíticos y normocrómicos. Bilirrubina Total 13.6 mg%. Bilirrubina directa: 9.2 mg% GPT: 150 UI/l, GOT 90 UI/l. Test del sudor: 30 mEq/l de cloro. Serología para HBV de Vito aún pendiente.

Estudios de la mamá de Vito: HBsAg (-), IgG anticore (+), antiHBs (+), IgG HAV (+).

Con los datos disponibles, Ud. piensa que: (marque hasta tres opciones)

Seleccione una o más de una:

- A. La mamá de Vito es portadora crónica del virus hepatitis B.
- B. Vito debe ser evaluado con urgencia por un cirujano pediátrico
- C. Los anticuerpos IgG HAV en el suero de Vito, indican pasaje transplacentario de anticuerpos maternos
- D. La ictericia que presenta Vito se relaciona con la alimentación con leche materna.
- E. Vito ha adquirido hepatitis A probablemente por transmisión vertical
- F. La serología materna refleja una infección por HBV pasada y curada.
- G. Los datos de la serología materna para Hepatitis B indican que la ictericia de Vito se debe probablemente a hepatitis B adquirida por transmisión vertical.
- H. Los valores del test del sudor son compatibles con fibrosis quística del páncreas.

25. Llega a la consulta Vanesa de 35 años con su bebe, Ema de 27 días de vida. Es la primera hija de Vanesa, producto de un embarazo controlado y deseado, nacida por cesárea con peso adecuado para la edad gestacional.

Vanesa refiere que la bebe llora de forma muy intensa, no duerme más de 2 hs. seguidas durante la noche. Se alimenta solo de pecho materno, lo cual es dificultoso por el dolor que le causa amamantar y el cansancio por no dormir bien. Le comenta que está pensando en dejar de amamantarla. Usted nota a Vanesa angustiada, irritable, cansada y triste. Durante la consulta Ema se pone a llorar en el cochecito, su mamá no la mira ni intenta cargarla.

Al examen físico, la bebe se encuentra irritable, con dificultades para succionar y evidencia un progreso de peso de 10 gr/ día.

De acuerdo a lo previamente mencionado, cuáles serían las conductas iniciales más apropiadas? (Puede marcar hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

- A. Solicitar ecografía abdominal.
- B. Solicitar ecografía cerebral.
- C. Solicitar radiografía de huesos largos.
- D. Citar a control a la brevedad conjuntamente con el papa y algún miembro de la familia ampliada.**
- E. Indicar simeticona reglada.
- F. Solicitar fondo de ojo.
- G. Dar pautas de hidratación, alimentación y sueño materno. Complementar con leche de formula.**
- H. Evaluar posible depresión puerperal conjuntamente con salud mental.**

26. Marcela ingresa a la maternidad en trabajo de parto. Embarazo controlado de 35 semanas de edad gestacional por fecha de última menstruación. No se constatan antecedentes perinatales patológicos. Nace Juan Cruz por parto normal, presentación cefálica, Apgar 7/8. Por método de Capurro se determina que la EG es de 37 semanas. Peso 2500 gramos (Percentilo 10) Talla 47 cm (percentilo 25). Perimetro cefálico 33 cm (Percentilo 25). Presenta una mancha color azulado en zona sacrolumbar y otra de características similares en el brazo derecho, se observan también lesiones pustulosas diseminadas. Ambos párpados superiores tienen una coloración rojiza que es más intensa cuando llora. Frecuencia cardíaca 140 por minuto Frecuencia respiratoria 58 por minuto. Presenta flexión de miembros superiores e inferiores, ángulo popliteo de 100 grados, inclusión del pulgar y el reflejo de ojos de muñeca está presente. Maniobra de Ortolani positiva. A los 3 días de vida desaparecieron las lesiones pustulosas dejando una pigmentación residual. algunas con un collarate de escamas.

De acuerdo a los datos obtenidos, ¿cuáles de las siguientes conductas son las más adecuadas? (Marque hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una

- A. Solicitar urgente ecografía de ambas caderas.
- B. Solicitar ecografía cerebral e interconsulta con neurologo infantil
- C. Afirmar que las máculas de los párpados involucionarán espontáneamente
- D. Informar que se trata de un recién nacido término de peso adecuado para su edad gestacional**
- E. Comunicar que las lesiones pustulosas tendrán una remision espontánea.**
- F. Informar que se trata de un distress transitorio del recién nacido,
- G. Solicitar hemograma y coagulograma por la lesión de zona sacrolumbar y del brazo derecho.
- H. Informar que se trata de un eritema toxico del recién nacido.

27. Renzo, de 1 mes y 20 días de edad es traído a su consultorio por presentar irritabilidad y llanto persistente. Nació de 38 semanas, sin complicaciones perinatales y fue dado de alta a

las 48 hs postparto, Peso de nacimiento: 3.300 gramos. Alimentación: lactancia materna exclusiva hasta hace una semana.

La madre refiere que su hijo duerme bastante y es difícil despertarlo para darle de mamar, se prende al pecho y sólo succiona unos pocos minutos y vuelve a dormirse. Por esta razón, ella se extrae leche manualmente y ha comenzado a complementar la alimentación con leche de fórmula de inicio. El padre anima a la madre a amamantar a su bebé, y trata de tranquilizarla, pero ella siente que está fracasando en su intento. Renzo ha comenzado a estar muy fastidioso, encoge sus piernas, se pone colorado, llora intensamente, y elimina gases en horario vespertino. Examen físico: Peso actual 4.500 gramos. Longitud corporal: 55.0 cm. Perímetro cefálico: 36,5 cm. Temperatura: 36,6 °C. Frecuencia cardíaca 100 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria. 35 respiraciones por minuto. Auscultación cardiopulmonar normal Abdomen blando, depresible, sin visceromegalias. El pañal se encuentra húmedo luego de la última emisión de orina y se observa una deposición de características normales. Resto del examen físico sin datos a destacar.

Ante esta situación. ¿cuáles son las conductas más adecuadas? (marque hasta 3 opciones):

Seleccione una o más de una.

- A. Solicita seriada esofagoduodenal
- B. Derivar al servicio de emergencias del centro de salud mas cercano.
- C. Evaluar la técnica de amamantamiento.
- D. Suspender las tomas complementarias de fórmula
- E. Indicar simeticona de modo reglado, por la tarde.
- F. Explicar a los padres que estos eventos suelen resolverse espontáneamente
- G. Eliminar lácteos y derivados de la dieta materna.
- H. Solicitar pHmetría esofágica..

28. Usted se desempeña como asistente en la Guardia Externa del hospital. A las 2:00 AM concurre Daniela con su hijo, Pedro, de 42 días de vida. El motivo de la consulta es haberle notado "la frente caliente". Pedro no estaba sobre abrigado y acababa de alimentarse como lo hace habitualmente. Pedro es fruto de un embarazo controlado, con serologías del tercer trimestre negativas e hisopado anal materno negativo para estreptococo β hemolítico grupo B. Es un nacido a término, peso adecuado a la edad gestacional, alta conjunta a las 48 horas, y recibió vacuna anti HBV y BCG. Se alimenta con pecho materno exclusivo. Daniela no nota cambios en el comportamiento de su hijo, en la actitud alimentaria ni en el patrón de sueño. En el día de ayer presentó 5 deposiciones amarillentas que no le llamaron la atención.

En la guardia Ud. constata temperatura axilar de 38°C, y valora a un niño en buen estado general con sensorio conservado. Al examen físico no se encuentra ningún foco infeccioso que pueda justificar la fiebre.

De acuerdo a sus hipótesis ¿Cuáles son las conductas iniciales más adecuadas ? (Puede marcar hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

- A. Solicitar examen fresco en materia fecal y coprocultivo.
- B. Solicitar radiografía de tórax.
- C. Indicar paracetamol 10 mg/kg vía oral.
- D. Internación en UTI y tratamiento empírico inicial.
- E. Solicitar aspirado nasofaríngeo para virus respiratorios.
- F. Observación por guardia para realizar estudios y eventual tratamiento.
- G. Solicitar hemograma, reactantes de fase aguda, dos hemocultivos, orina completa y urocultivo.
- H. Solicitar hemograma y eritrosedimentación, y control ambulatorio en 24 horas con el resultado.

2. CRECIMIENTO

1. Milo tiene 1 año y 3 meses de vida, es sano, se alimenta con dieta general (comidas saludables y seguras) más pecho por la mañana y por la tarde, la madre suspendió la administración de vitaminas ADC y de sulfato ferroso hace un mes.

Actualmente Milo se encuentra en percentilo 10 de peso y talla, el control del año también tenía los mismos percentilos, habiendo aumentado 300 gramos los últimos 3 meses. La mamá mide 1,55 M y el papá 1,67 M. En el último tiempo no tuvo problemas de salud. Presenta carnet de vacunas completo hasta el año de vida.

Pregunta: Le consulta a usted sobre los cuidados de Milo y las conductas a seguir. Ud. Sugiere y explica: **(Marque hasta 4 opciones)**

- A. Enriquecer las comidas con crema de leche, manteca y queso untado.
- B. Solicitar hemograma, determinación de IgA e IgA antitransglutaminasa.
- C. Indicar nuevamente vitaminas y hierro hasta los 18 meses.
- D. Interconsulta con nutrición infantil.
- E. Explicar que el crecimiento de Milo es normal para su edad.
- F. Reducir la lactancia dado que probablemente interfiera con la correcta alimentación.
- G. Refuerza pautas de alimentación saludable y mantener pecho materno.
- H. Indica vacuna anti varicela y antimeningococcica.
- I. Da pautas de prevención sobre lesiones no intencionales.
- J. Solicitar radiografía de muñeca izquierda para evaluar edad ósea.

2. Jacinto es un paciente de 12 años y 10 meses, que concurre al pediatra con su madre porque nota que en el último año sus compañeros lo han superado en altura. Refiere estar muy preocupado por su talla y se compara constantemente con sus compañeros, aunque no lo molestan ni le hacen bullying. A su vez la madre refiere que los hermanos mayores a su misma edad habían alcanzado mayor talla.

Antecedentes: parto cesárea, Apgar 9/10 7-10; PN 3200 grs, longitud: 50 cm. Epilepsia tratada desde los 4 años con ácido valproico, sin crisis epilépticas en el último tiempo. Desde pequeño era selectivo con la comida y siempre fue delgado, aunque ahora come abundante y ha aumentado de peso. El último peso y talla es de hace un año donde se encontraba en Peso y Talla en Pc 10-25.

El niño no consume drogas, ni alcohol. Su padre es sano y mide 170 cm tuvo desarrollo puberal normal, la madre es sana y mide 165 cm, tuvo su menarca a los 14 años. Los 2 hermanos mayores de 15 y 17 años, ambos con talla normal (Pc 50) sin retraso puberal.

Pregunta: Además del examen físico completo, con los datos obtenidos cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? (Marque hasta 3 opciones)

- A. Calcular la Talla Objetivo Genético
- B. Indicar dieta suplementaria hiperproteica y deportes de alto impacto
- C. Valoración de talla y estadio de desarrollo puberal
- D. Valorar la edad ósea.
- E. Solicitar estudios parasitológicos en materia fecal.
- F. Interconsulta con endocrinología.
- G. Solicitar determinación de IgA sérica e IgA antitransglutaminasa.
- H. Solicitar TSH y T4 libre.
- I. Realizar curva de velocidad de crecimiento
- J. Suspendir el ácido valproico.

5. José, de 6 años y 3 meses de edad llega a la consulta con su madre. Ella está preocupada por la altura de José, ya que lo nota más bajo que sus compañeros. Antecedentes: nacido a término con peso adecuado para la edad gestacional. Sin antecedentes patológicos de importancia. Vive con su madre, su padre ha fallecido en un accidente y no hay antecedentes patológicos familiares de importancia.

La libreta sanitaria de José muestra una curva de talla que a partir de los 2 años de vida ha crecido entre los percentiles 10-25 hasta los 5 años. A partir de esta edad, la curva empieza a descender, ubicándose actualmente debajo del percentil 3, con un puntaje Z de -3,4 y velocidad de crecimiento menor a percentil 3.

Con respecto al cuadro clínico del paciente, ¿cuáles de las siguientes conductas son las más adecuadas? Marcar hasta 3 opciones.

Seleccione una o más de una:

- A. Explicar a la madre que se trata de un madurador lento.

- B. Internar al paciente
- C. Citar ambulatoriamente en 6 meses.
- D. Solicitar interconsulta con endocrinología
- E. Explicar a la madre que se trata de baja talla familiar.
- F. Explicar a la mamá que su niño tiene un retardo constitucional del crecimiento
- G. Solicitar resonancia magnética de cerebro con gadolinio
- H. Solicitar radiografía de silla turca
- I. Solicitar laboratorio con panel celíaco y hormonas tiroideas, y radiografía de mano izquierda
- J. Solicitar tomografía computada de silla turca e hipofisis

6. Florencia, de 12 años y 3 meses, concurre a la consulta con sus padres quienes se encuentran muy preocupados porque su hija parece muy baja en comparación con otras amigas de su misma edad y aún no ha tenido su menarca. Revisando los controles en salud efectuados hasta ahora. Florencia ha mantenido siempre el crecimiento de su talla en pc 3.

Antecedentes personales. La madre de Florencia cursó embarazo gemelar de 38 semanas. Nacimiento de Florencia por cesárea. Peso al nacer 2150 gramos. Los padres refieren que su hija cursa el último grado de la escuela primaria y es una excelente alumna.

Examen físico: peso 22.6kg (Pc<3) PZ-2.7. Mamas. Estadio I; Vello pubiano: II-III. Talla materna: 159cm (Pc-50-25). Talla paterna: 176cm (Pc75-50)

Con los datos disponibles, ¿cuales son los más adecuados para comenzar la valoración de Florencia? Marcar hasta 3 opciones.

- A. Radiografía de muñeca con foco en 3er metacarpiano
- B. Centellogramas de tiroides con I131
- C. Interconsulta con endocrinología
- D. Función renal TSH, T4L
- E. Determinación de los niveles de las hormonas de crecimiento
- F. Radiografía de silla turca
- G. Determinación de IgA antitransglutaminasa
- H. Cariotipo

7. Florencia, es una niña de 6 años de edad que concurre a un control de salud. No tiene antecedentes de importancia. Usted encuentra que según la curva de crecimiento su talla se encuentra en percentilo 75 y creció 2.5cm en este último año, y durante este mismo periodo, su peso se mantuvo en percentilo 50.

Cómo interpreta estos resultados? Marcar hasta 2 opciones

- A. Presenta una estatura normal para la edad con una velocidad de crecimiento normal.

- B. Presente peso en percentio 50, esto refleja el promedio de su peso en los últimos meses.
- C. Presenta una estatura normal para edad con una velocidad de crecimiento anormalmente alta para su edad.
- D. Presenta una estatura anormal con una velocidad de crecimiento anormalmente alta.
- E. Presenta un peso en el límite inferior a lo normal.
- F. Presenta una estatura normal para la edad con una velocidad de crecimiento anormalmente baja.
- G. Presenta peso normal para la edad.
- H. Presenta una estatura anormal para la edad con una velocidad de crecimiento anormalmente.

8. Lucía es una niña de 8 años de edad que concurre a la consulta. No presenta antecedentes de importancia. Su peso de nacimiento fue de 3.500 g. Con talla de nacimiento de 52,0 cm. No tenemos datos antropométricos de sus controles. Se alimenta con dieta variada. Tiene un desarrollo normal. Cursa tercer grado en modalidad presencial y virtual con buen rendimiento .

Como antecedentes familiares: su mamá es sana, profesional, mide 162,0 cm (pc 50-75) y tuvo su menarca a los 11 años. Su papá es sano, comerciante, mide 175,0 cm (pc 50-75). Blanco genético familiar=162,25 (pc 50-75), rango genético= entre 153,75 (pc 10) y 170,75cm (pc 90 – 97).

Al examen físico constata una niña en buen estado general, frecuencia respiratoria 20 por minuto, frecuencia cardíaca 80 por minuto, 2 ruidos en 4 focos, silencios libres. Abdomen blando. No visceromegalias. Reactiva, vital. Buen estado nutricional. Se observa nódulo mamario bilateral. No se observa vello pubiano. Talla 134,0 (pc 97).

**Ante este examen físico y esta curva ¿Cuáles son las opciones más adecuadas?
(Marque hasta 3 opciones)**

Seleccione una o más de una:

- A. El estadio de maduración puberal de Lucía corresponde al desarrollo de mama estadio de Tanner 3.
- B. Lucía se encuentra en un estadio prepuberal.
- C. Lucía se encuentra fuera del rango genético familiar.
- D. Asume que se encuentra dentro de la variante de la normalidad de crecimiento por lo que nos solicita estudios.
- E. Considerar realizar la consulta inmediata con endocrinología infantil.
- F. Lucía se encuentra dentro del rango genético familiar.
- G. Solicita radiografía de mano y muñeca izquierda con informe de edad ósea.
- H. Lucía comenzó con su desarrollo puberal.

10. Juan, de 6 años y 3 meses de edad es traído a la consulta por su madre porque está preocupada por su altura, ya que lo nota más bajo que sus compañeros. Antecedentes: nacido a término con peso adecuado para la edad gestacional. Sin antecedentes patológicos de importancia. Vive con su madre, su padre ha fallecido en un accidente y no hay antecedentes patológicos familiares de importancia. La libreta sanitaria de Juan muestra una curva de talla que a partir de los 2 años de vida se ubica a -2.3 DE hasta la actualidad. La velocidad de crecimiento está en percentilo 25.

La talla materna es de 150.0 cm y según lo que refieren el padre medía alrededor de 160 cm. Trae una radiografía de edad ósea 5 años.

Con respecto al cuadro clínico del paciente, ¿Cuáles de las siguientes conductas son las más adecuadas? (marque hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

- A. Explicar que alcanzará talla en percentilo 50 luego del empuje puberal.
- B. Explicar que la talla final estaría alrededor de 160.0 cm (+/- 8cm).
- C. Explicar a la madre que se trata de un madurador lento.
- D. Citar a control ambulatorio en 6 meses.
- E. Explicar a la madre que se trata de baja talla familiar.
- F. Explicar a la mamá que su niño tiene un retardo constitucional del crecimiento.
- G. Solicitar interconsulta con endocrinología
- H. Solicitar laboratorio con panel celiaco y hormonas tiroideas.

3. DESARROLLO

1. Horacio y Ana traen a su consultorio por primera vez a su hijo Mario, de 3 años y medio de edad, para control. Mario es el primer hijo de un embarazo controlado. Nació a las 40 semanas de edad gestacional con 3500 gramos por parto vaginal con presentación cefálica. Lloró enseguida. Alta conjunta a las 48 horas con lactancia materna. Fue internado a la semana por mal progreso de peso y succión débil. Completó 10 días de tratamiento antibiótico parenteral con hemocultivos, urocultivo y cultivo de LCR negativos. Egresó a los 21 días de internación con alimentación enteral por sonda nasogástrica, que mantuvo durante tres meses.

Mario sostuvo la cabeza al 3° mes, se sentó a los 8 meses, no gateó y caminó a los 17 meses. No controla esfínteres.

Actualmente asiste a una sala de 3 años; los padres fueron citados porque hace muchos berrinches y habla muy poco.

Inmunizaciones: 1 dosis vacuna hepatitis B, 1 dosis vacuna BCG, 2 dosis vacuna inactivada para la polio, 2 dosis vacuna oral para la polio, 4 dosis vacuna DPT-HB-Hib, 3 dosis vacuna

neumococo, 3 dosis vacuna meningococo, 1 dosis vacuna triple viral, 1 dosis hepatitis A y 1 dosis vacuna para la varicela.

Entre los antecedentes familiares: Horacio 41 años con aorta bicúspide, Ana 27 años con hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto diagnosticada después del nacimiento de Mario. Antropométricamente: Peso 20 kilos (>pc 97), talla 104 cm (pc 97), IMC mayor a pc 97 obesidad, perímetro cefálico 51 cm (pc 50). Signos vitales: Frecuencia cardíaca 120 por minuto, TA 90/60 mm/Hg, frecuencia respiratoria 16 por minuto, oximetría 97 % a aire ambiental.

Al examen físico: Buen estado general, pálido, muy poco colaborador. Abundante tejido celular subcutáneo con distribución central, sin acantosis. Boca con numerosas caries. Cifosis dorsal alta leve. No cicatriz de BCG. Cúbito valgo bilateral, lesiones por rascado en dorso antebrazo izquierdo, manos y pies pequeños. Pene 4 cm de longitud, ambos testículos pequeños en bolsas. Examen neurológico: pares craneales sin particularidades; trofismo, tono y fuerza muscular conservada en los cuatro miembros; reflejos osteo-tendinosos presentes; sin signos de foco ni meníngeos.

Pregunta: ¿Cuáles son sus conductas iniciales con este paciente? (Marque hasta 3 opciones).

- A. Indicar la BCG.
- B. Indicar primer dosis de vacuna oral atenuada contra rotavirus.
- C. Tranquilizar a los padres porque asume que el retraso madurativo está relacionado con la reciente mudanza e incorporación al jardín.
- D. Solicitar glucemia, perfil lipídico**
- E. Profundizar la anamnesis sobre el sueño de Mario**
- F. Solicitar una resonancia magnética de encéfalo
- G. Solicitar interconsulta con servicio de Genética
- H. Interconsulta a dermatología
- I. Interconsulta con ortopedia
- J. Indicar 100mg de metformina por vía oral cada 12hs

2. Julián, de 19 meses de edad, concurre con su madre y su abuela materna a su consultorio. Están preocupadas por su maduración. Nació de un embarazo controlado, a las 39 semanas de edad gestacional por parto por vía vaginal con presentación cefálica. Tuvo sufrimiento fetal agudo por circular de cordón y fue deprimido grave, y recibió reanimación en la sala de partos. Estuvo internado tres semanas en unidad de cuidados intensivos neonatales, con buena evolución. También fue internado por bronquiolitis por 5 días a los 6 meses. Inmunizaciones completas para la edad. Antropométricamente . peso pc 25, talla pc 25-50, perímetro cefálico pc 50. Examen físico sin particularidades.

En este caso, la ausencia de pautas madurativas son signos de alarma? Marcar hasta 3 opciones:

- A. Usar triciclo
- B. Saltarse en un pie

- C. Pararse en un pie
- D. Lanzar una pelota con ambas manos
- E. Hacer talón con punta hacia adelante
- F. Dar cinco pasos sin agarrarse
- G. Patear una pelota
- H. Agacharse y levantarse sin caerse

3. Milo de 3 años y 4 meses de edad concurre para realizar su control de salud para ingreso a jardín de infantes. No usa pañales durante el día pero por la noche moja la cama por lo que persiste con pañales para dormir. En la familia comen mirando televisión y la madre le da de comer en la boca porque de otro modo come poco. Usa chupeta para dormir a la noche. Usa el vaso para tomar líquidos. Duerme en la habitación con su hermana de once años y ven televisión hasta que se duerme.

Cuales son las recomendaciones de puericultura más adecuado? Marcar hasta 3 opciones

- A. Indicar sacar los pañales a la noche
- B. Evitar que vea TV mientras come y sacar el televisor de la habitación
- C. Indicar sistema de alarma nocturna
- D. Limitar el uso de televisor en la habitación a dos horas por día
- E. Permitir el uso del chupete para favorecer el sueño
- F. Sugerir suspender el uso de chupete
- G. Permitir que coma solo
- H. Sugerir que el niño coma antes que el resto de la familia

4. Concorre a su consultorio Victoria con su hija Chiara de 5 meses para realizar el control de salud mensual. Ud observa al evaluar su desarrollo psicomotor los siguientes datos: realiza trípode inestable, rola, pasa objetos de una mano a otra y los lleva a la boca, vocaliza y modula recíprocamente, sonrío y se ríe a carcajadas, y sigue con la mirada. No se sienta sola, no hace saltarín, no usa pinza radial inferior y no usa consonantes. No emite sílabas (balbuceo)

Chiara nació de parto vaginal y requirió maniobras de reanimación mínimas, sin otros datos perinatólogicos de relevancia. Pesquisa metabólica neonatal, otoemisiones acústicas y reflejo rojo normales. Presenta reflejo plantar. Es alimentada con pecho exclusivo con buen progreso pondero estatural. Efectúa los controles periódicos pautados por Ud. Con buena adherencia a las pautas de puericultura. Victoria le pregunta se ya puede comenzar a brindar semisólidos a Chiara.

De acuerdo a la evaluación realizada indique las conductas más adecuadas. Marca hasta 3 opciones:

- A. Informar a la madre que en el próximo mes comenzará con alimentos semisólidos
- B. Solicitar tomografía cerebral

- C. Indicare estimulación temprana y control en un mes
- D. Retrasar la incorporación de semisólidos por su retraso psicomotriz
- E. Continuar con los controles pediátricos habituales
- F. Aconsejar a la madre sobre prevención de caídas
- G. Solicitar interconsulta con neurología infantil
- H. Solicitar interconsulta con un especialista de desarrollo infantil

5. Los padres de Esteban, de 22 meses (1 año 10 meses), acuden a su consultorio. Están preocupados por su maduración. De un embarazo controlado, nació a las 37 semanas de edad gestacional por cesárea de urgencia por desprendimiento de placenta. Tuvo sufrimiento fetal agudo y fue deprimido grave, recibiendo reanimación en la sala de partos. Estuvo internado un mes en la unidad de cuidados intensivos neonatales, con muy buena evolución. Inmunizaciones completas para la edad. Antropometría: Peso pc10-25, talla pc 25, perímetro cefálico pc 25-50. Examen físico sin particularidades.

¿La ausencia de cuáles pautas madurativas es signo de alarma para usted? (Marque hasta 3 opciones).

Seleccione una o más de una

- A. Señalar las figuras de su papá y mamá en un dibujo.
- B. Decir mamá y papá.
- C. Entonar una canción infantil sencilla.
- D. Hacer una torre de 12 cubos.
- E. Decir oraciones de dos palabras.
- F. Introducir pequeños objetos dentro de un recipiente.
- G. Subir escaleras alternando pies.
- H. Patear una pelota.

6. Los padres de Elena de 2 meses de edad están preocupados porque, la niña, si bien fija la mirada en una cara y la sigue brevemente, no sigue objetos hasta la línea media. La preocupación de los padres se centra en que su hijo de 4 años tiene un trastorno del desarrollo no especificado. Elena es una niña nacida de un embarazo controlado, con 32 semanas de edad gestacional. Al examen físico se encuentra en buen estado general, vital reactiva, presenta un buen tono muscular. En suficiencia cardiorrespiratoria. Presenta reflejo de moro completo, reflejo cocolopalpebral presente.

Con respecto al desarrollo de esta niña y a la preocupación de los padres, ¿Cuáles son las opciones más correctas? (Marque hasta 3 opciones):

- A. Durante la evaluación del desarrollo se debe separar a Elena de sus padres para que el examen sea más objetivo.
- B. Elena presenta un trastorno transitorio del desarrollo.
- C. Elena es muy pequeña para poder detectar un trastorno del desarrollo.
- D. Se debe conocer las edades de adquisición de las pautas madurativas.

- E. Para darle una respuesta a los padres debe evaluar todas las áreas de desarrollo.
- F. Es muy poco probable que Elena tenga un trastorno del desarrollo.
- G. Se debe tener en cuenta la edad corregida por edad gestacional.
- H. La edad gestacional de Elena es un factor protector para los trastornos del desarrollo.

7. Concorre a la consulta Marcela de 25 años con su hijo Juan de 18 meses. Viven en una localidad del Gran Buenos Aires junto a Pablo, el papá de Juan, y su hermano de 4 años. Marcela es peluquera y Pablo trabaja en un supermercado. Ambos terminaron el colegio primario. Marcela fue alérgica al polen durante su niñez y Pablo fuma un atado de cigarrillos por día. Al ingresar a su consultorio Juan entró de la mano de su madre y traía un auto en su otra mano. Durante el examen físico, colabora levantando las manos cuando la mamá lo desviste pero cuando ella se aleja comienza a llorar.

Presenta examen físico normal, pesa 9,950 kg (PC 25) y mide 80,5 cm (PC 25-50). Mientras dialoga con Marcela, Juan se mete abajo del escritorio para jugar con el auto y unos bloques. Marcela le pide que salga pero el niño no quiere y se larga a llorar. Ella le entrega el celular y logra calmarlo. Refiere que se comporta de esta manera en casa y que siempre la sigue, ayudando con las tareas del hogar. Marcela le pregunta si Juan tiene un desarrollo esperable para su edad y si está creciendo bien.

Teniendo en cuenta el motivo de consulta, ¿cuáles son las respuestas más adecuadas? (Puede marcar hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

- A. Solicitar interconsulta a psicología infantil por aparición temprana de berrinches.
- B. Recomendar que le compre lápices porque ya debería dibujar líneas.
- C. Explicar a la madre que es normal que comience con berrinches.
- D. Desaconsejar el uso de pantallas.
- E. Comunicar a la madre que Pedro cumple con las pautas de un niño de 18 meses.
- F. Citar para control de pautas madurativas dentro de 2 meses.
- G. Indicar alimentación hipercalórica porque Pedro está con bajo peso.
- H. Indicar interconsulta con neurología porque no cumple pautas madurativas para su edad.

8. Antonio es un niño de 6 meses de edad, que concorre acompañado por su madre de 16 años y su padre de 18 años a la consulta del control del 6to mes. Conviven con abuelos paternos. Sin antecedentes perinatólogicos de importancia, Peso de nacimiento: 3,500 Kg , Talla : 49 cm y Perímetro cefálico : 35 cm. Al examen físico presenta un peso de 8500 grs (Pc 50-75) , mide 68 cm (Pc 25- 50) y el perímetro cefálico de 43 cm (Pc 25-50).

Pregunta: En este paciente ¿qué pautas del neurodesarrollo debe haber logrado? (Marque hasta 3 opciones)

- A. Intenta dar pasos con sostén.
- B. Presencia de tónico cervical asimétrico.
- C. Puede sentarse solo por medio de la posición de trípode.
- D. Lleva objetos a la boca
- E. Rola
- F. Repite sílabas ma ma, da da.
- G. Pinza radial inferior.
- H. Saluda con la mano.
- I. Gatea.
- J. Señala con el dedo.

9. Marcela de 17 años, concurre con su hijo Santiago de 8 meses a una consulta programada de 1ra vez. Marcela es madre soltera. Su embarazo fue controlado en 5 oportunidades en los últimos meses. Santiago realizó consultas quincenales con el pediatra durante el 1er mes y luego mensuales. Hasta ahora, según Marcela, los médicos le decían “que estaba todo bien”.

Marcela está preocupada, porque Santiago, no gatea como el hijo de su amiga de misma edad y desde hace 1 semana se despierta de noche, con un llanto que lo siente como “desgarrador”.

En este control en salud Ud. observa que Santiago se sienta de forma segura, toma objetos y los arroja al piso, se para con apoyo, toma objetos voluntariamente que se encuentran sobre la camilla, y comienza a llorar cuando intenta revisarlo.

Tenido en cuenta todos los datos mencionados, ¿qué información le aporta a la mamá acerca de Santiago? Marque 3

Seleccione una o más de una:

- A. La ausencia de gateo no constituye en sí misma un marcador de retraso del desarrollo
- B. Necesita comenzar estimulación temprana
- C. Tiene un desarrollo acorde a su edad
- D. Requiere diversas interconsultas para evaluación del neurodesarrollo
- E. A esta edad debería tomar la cuchara y comer solo
- F. Probablemente se encuentre transitando angustia por separación
- G. Los síntomas que presenta corresponden a la ausencia de la figura paterna
- H. Deberá realizar una seriada esófago-gastroduodenal para descartar reflujo

10. Elsa, vive con su esposo, en un barrio de clase media desde hace 10 años. Hoy concurre con Daniel, su hijo de 18 meses de edad, para control.

Al examinarlo, ¿cuáles son los parámetros de desarrollo madurativo que debe identificar en Daniel? Marque 3 opciones

Seleccione una o más de una:

- A. Realizar gabaratos con un lápiz
- B. Decir 2 palabras juntas con significado
- C. Iniciar el control de esfínteres diurno
- D. Realizar una torre de 4 cubos
- E. Reconocer 3 colores
- F. Señalar 2 figuras
- G. Correr ligero
- H. Dibujar un círculo

11. Matías, de 12 meses de edad, concurre a la consulta con su madre para un control de salud. Se trata de un RNTPAEG sin antecedentes de importancia. La madre le comenta que recién ha comenzado a dar sus primeros pasos solo. Usted decide evaluar el desarrollo de Matías. Para ello, le coloca sobre el escritorio unas pasas de uva, unos cubos de colores, un papel y un lápiz.

Que espera que realice Matías? Marcar hasta 3 opciones.

- A. Agarrar la pasa de uva con un movimiento de barrido con el lado cubital de la mano
- B. Agarrar la pasa de uva con toda la mano realizando un movimiento un de rastrillo
- C. Se toma la pasa de uva y se la lleva a la boca, usted le dirá que NO, y Matías se pondrá serio y lo obedecerá
- D. Amar un puente con los cubos
- E. Agarrar la pasa de uva con una pinza entre el dedo índice y el pulgar
- F. Con el papel y el lápiz, dibujar un garabato
- G. Armar una torre de 3 cubos
- H. Con el papel y el lápiz, dibujar una figura humana de 3 partes

15. Gastón de 4 años y 10 meses concurre a la consulta con sus padres porque no habla bien. Según refieren el aún no arma oraciones y parece, a veces, no entender lo que se dice.

Antecedentes personales: Gastón fue producto de un embarazo término, controlado que cursó sin complicaciones. Parto eutócico. Peso de nacimiento 3440 gramos. No se presentaron complicaciones perinatales. Desde el punto de vida madurativo, presento un desarrollo motor grueso adecuado: sostén cefálico a los 3 meses, sedestación a los 6 meses, gateo a los 9 y marcha independiente al año y un mes. A los dos años utilizaba correctamente la cuchara y el tenedor. Dijo sus primeras palabras alrededor de los 2 años y cerca de los 3 algunas frases rudimentares como “dame eso”, “guaguau no está”. Sus padres perciben que, si bien habla más que el año anterior, aun no habla con la claridad de los niños de su edad.

Gastón es un chico hiperactivo y no suele hacer caso cuando se le solicita algo. Hace muchos berrinches sobre todo cuando se lo contradice.

Concurre a jardín desde salita de 3 años desde entonces las maestras alertaron acerca de

su escaso lenguaje. Actualmente, concurre a sala de 4 en el mismo establecimiento y las maestras comentan que le cuesta adaptarse al grupo y que presenta una actitud solitaria.

Arma varios rompecabezas, junto a su prima de 9 años. Reconoce la mayoría de las letras y números. No presenta antecedentes familiares ni patológicos de importancia.

Examen físico: fue dificultoso debido a su constante movimiento y falta de colaboración.

Dentro de límites normales para su sexo y edad. Buen estado general, examen neurológico normal.

Ante esta situación, ¿cuáles son las conductas más adecuadas para abordar el motivo de consulta? Marcar hasta 3 opciones

- A. Involucrar estrecha y obligadamente a los padres en el tratamiento
- B. Suspender transitoriamente la concurrencia de Gastón al jardín
- C. Indicar lo antes posible una evaluación con psiquiatra infantil
- D. Considerar que Gastón presente un trastorno generalizado e inespecífico del desarrollo
- E. Informar a los padres que Gastón presenta un retardo habitual en la maduración del lenguaje
- F. Informar a los padres que Gastón presenta signos inequívocos de autismo
- G. Realizar una evaluación audiológica
- H. Solicitar una consulta inicial con genética

4. LACTANCIA + ALIMENTACIÓN + SUPLEMENTOS + DESNUTRICIÓN

1. Anahí es una niña de 6 meses de vida, primera hija de Sandra (32 años, docente) y Julio (32 años, docente). Fue una RNTPAEG y no presentó hasta el momento ningún problema de salud. Tiene aplicadas vacunas completas para la edad. La familia vive en el conurbano bonaerense y los padres trabajan en una escuela en el partido en el que viven. Anahí queda al cuidado de su abuela materna durante el tiempo que ellos están trabajando. Anahí sigue tomando el pecho y también toma biberones con fórmula de inicio.

Al examen físico anahi se sienta, toma objetos y los lleva a la boca, y no se observa reflejo de extrusión lingual. Peso: 7kg (pc 25) y talla 64cm (pc 25) En la consulta los padres preguntan acerca de comenzar con la alimentación con semisólidos.

Ante esta consulta usted, qué considera informarles? Marcar hasta 3 opciones.

- A. Indica que comience con sucedaneos lácteos inicialmente

- B. Se debería aguardar a que alcanzara un peso y una talla en percentilo 50 para comenzar con semisólidos
- C. Alienta la ingesta de agua y desalienta la de jugos industriales y gaseosas
- D. Aclara que pueden añadir sal, azúcar y/o miel a las comidas
- E. Indica que comiencen con vegetales inicialmente y más tarde incorporar otros grupos de alimentos (carne, cereales y frutas)
- F. Estimula el agregado de grasas a las comidas que se le ofrezcan
- G. Es un buen momento para comenzar con semisólidos
- H. Indica alimentos variados, pero limitando carnes y algunas frutas

2. Agustín, de 1 año de edad, consulta para el control de salud.

Usted ha realizado los controles previos, desde el nacimiento. Agustín es un niño nacido a término, con peso adecuado para la edad gestacional, sin complicaciones perinatales. Es hijo de Vanina de 23 años y Alejandro, de 28, ambos sanos.

El niño ha tenido un crecimiento adecuado, neurodesarrollo acorde a edad. Recibió lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, y actualmente, tiene una dieta variada. Recibe suplemento de hierro y vitaminas desde los 2 meses de vida. Su carnet de vacunas se encuentra completo según calendario.

Cuales son las indicaciones más adecuadas en esta consulta? Marcar hasta 3 opciones

- A. Suspender la profilaxis con hierro y vitaminas A,C, D
- B. Indicar ubicar al niño en el auto en el asiento trasero en brazos de la madre
- C. Aconsejar la higiene dental del niño con cepillo y pasta dental abundante
- D. Aconsejar sobre prevención de accidentes en el hogar y cuidado bucal
- E. Indicar compartir la comida familiar
- F. Aconsejar entretenimiento con dibujos animados o videos, en dispositivos móviles o a través de pantallas, con un máximo de una hora diaria
- G. Aconsejar el juego con pares
- H. Indicar el destete

3. Gemma tiene 9 días de vida y es traída a la consulta por su madre, muy preocupada, ya que manifiesta que “no le baja suficiente cantidad de leche de sus pechos”, y que la niña desde hace 2 días no presenta deposiciones. Antecedentes: embarazo controlado, sin patología gestacional.

Gemma es una RNT, sana, con peso de nacimiento: 3,200 kg, talla: 49,0 cm y perímetro cefálico: 35,0 cm. Se alimenta con lactancia materna exclusiva desde el nacimiento. Peso al alta: 2,900 Kg.

El examen físico es normal. Peso actual: 3,180 kg.

Frente a esta situación Ud. decide: (Puede elegir 3 opciones)

- A. Observar técnica de amamantamiento.
- B. Continuar con lactancia materna exclusiva.
- C. Indicar gotas de simeticona.
- D. Indicar a la madre metoclopramida.
- E. Aconsejar a la madre que ingiera abundantes líquidos.
- F. Medicar a Gemma con lactulosa.
- G. Indicar supositorios de glicerina. No, la niña no se encuentra constipada esta
- H. Agregar fórmula para complementar la lactancia materna.

4. Antonio concurre a control de salud. Es un niño de 3 años al que le diagnosticaron desnutrición leve en un centro de salud y por haberse mudado de ciudad, realizará seguimiento en su hospital. Examen físico: buen estado general, con peso y talla por debajo del percentilo 3. Ambos en -2,5DE. La madre mide 1,6 (pc 50) y el padre 1,75 (pc 75) metros.

Trae los siguientes registros de peso y talla:

Peso y talla a los 2 meses en percentilo 50
 Peso y talla a los 6 meses en percentilo 50
 Peso a los 12 meses en percentilo 25
 Peso a los 18 meses en percentilo 10 y talla en percentilo 25
 Peso a los 24 meses en percentilo 3 y talla en percentilo 10

La familia no manifiesta tener problemas socio económicos y le comentan que realizan 4 a 5 comidas por día, en muchas de las cuales el niño se niega a ingerir alimentos.

Con los datos recolectados hasta el momento, ¿qué conducta considera las más adecuada? Marcar hasta 4 opciones.

Seleccione una o más de una:

- A. Indicar internación
- B. Interpretar la desnutrición como crónica
- C. Explicar a la familia que el primer año de vida el niño tuvo una velocidad de crecimiento normal.
- D. Considerar la enfermedad celíaca como diagnóstico diferencial
- E. Indicar tratamiento de renutrición y control ambulatorio en un mes.
- F. Indicar hierro y vitaminas parental
- G. Explicar a los padres que se trata de una baja talla familiar.
- H. Interpretar que la velocidad de crecimiento entre los 18 y 24 meses de vida es normal.
- I. Interpretar que la relación peso / talla del paciente es normal
- J. Interpretar como desnutrición aguda

6. Los padres de Mariano de 24 meses, consultan preocupados por el crecimiento de su hijo. Su último control fue a los 8 meses de edad y refieren que no lo trajeron a nuevos controles porque la salita de su barrio estuvo cerrada y no les alcanzaba el dinero para acercarse al hospital. La madre comenta preocupada que desde que nació el hermanito hace 6 meses notaron que no crece y lo ven cada vez más delgado.

El niño recibió lactancia exclusiva hasta los 6 meses, luego de lo cual incorporó alimentación complementaria y continuó con pecho materno hasta los 16 meses. El padre refiere graves problemas económicos y falta de ayuda de su familia, por lo cual, en ocasiones el niño no realiza más de una comida por día. La dieta del niño se basa principalmente en hidratos de carbono como arroz y polenta. La madre trae consigo una libreta con los siguientes datos:

Peso al nacer: 3.100g

Peso a los 2 meses en percentilo 50

Peso a los 4 meses en percentilo 25/50

Peso a los 8 meses en percentilo 50

EXAMEN FÍSICO: paciente emaciado, con ligero edema en ambos pies, con abdomen distendido y pelo quebradizo. Peso por debajo de los -3DE

¿Cuáles son las conductas más adecuadas que deben adoptarse? Marcar hasta 4 opciones.

Seleccione una o más de una:

- A. Internar al paciente para ampliar estudios y comenzar tratamiento.
- B. Iniciar aportes de hierro a dosis tratamiento lo antes posible.
- C. Solicitar interconsulta a gastroenterología para descartar enfermedad celíaca.
- D. Priorizar la valoración y tratamiento de la hipotermia, deshidratación e hipoglucemia.
- E. Calcular el aporte energético que requiere el niño e indicar alimentación administrando 1.5 veces el valor calculado.
- F. Solicitar interconsulta con Psicopatología para que la familia trate los celos entre hermanos.
- G. Indicar no superar las 4 comidas diarias.
- H. Interpretar como desnutrición secundaria, solicitar orina completa y citar a control con el resultado.
- I. Indicar pesar diariamente al paciente.
- J. Administrar suplementos de potasio y magnesio en caso de desequilibrios electrolíticos.

5. PUBERTAD Y ADOLESCENCIA

1. Beatriz, de 13 años, consulta en un hospital de tercer nivel de complejidad, derivada por su pediatra de cabecera, por presentar baja talla y retraso puberal.

Antecedentes personales: Edad gestacional 39 semanas, peso al nacer 2.900 gramos, talla 46 cm, sin antecedentes perinatológicos. Ha presentado episodios de diarrea esporádica y constipación durante el último año. Al interrogatorio la madre cuenta que se alimenta en forma adecuada y no presenta vómitos. Comentan que no tiene buen desempeño escolar y repitió dos años de colegio. Es la única hija de una pareja no consanguínea, sin patología familiar.

La madre mide 159,5 cm con menarca a los 15 años y el padre mide 177 cm.

Auxología: Peso 36,4 kilos (Z -1.36), talla 130 cm (Z -3.08). Estadios de Tanner: mamas 1 y vello púbico 2. Signos vitales: frecuencia cardíaca 68 por minuto 70-100, TA en miembro superior derecho 90/65 mmHg 90 - 140/ 69 - 95, frecuencia respiratoria 14 por minuto 13-15.

Examen físico: Niña de aspecto agradable. Piel es seca, fría y áspera al tacto. Implantación baja de orejas, párpados caídos, micro y retrognatía, cuello corto y ancho, cúbito valgo, manos y pies cortos. Pecho ancho y plano, precordio calmo, 2 ruidos en 4 focos, sin soplos, pulsos femorales presentes y levemente disminuidos.

Pregunta: De acuerdo a su hipótesis diagnóstica inicial, cuáles son las conductas más adecuadas? (Marque hasta 3 opciones).

- A. Citar a control en 6 meses
- B. Solicitar radiografía de muñeca y mano para determinar edad ósea**
- C. Solicitar interconsulta con endocrinológica
- D. Comentar a la madre que Beatriz ha comenzado su pubertad
- E. Solicitar determinación de hormona de crecimiento
- F. Solicitar interconsulta genética**
- G. Solicitar espinograma
- H. Solicitar interconsulta a cardiología**
- I. Solicitar radiografía de cráneo de perfil
- J. Solicitar resonancia magnética de cerebro y electroencefalograma

2. Juana de 8 años, sin antecedentes de relevancia, concurre para control de salud. Su mamá está preocupada por "su desarrollo".

Al examen físico presenta botón mamario unilateral derecho, vello pubiano Tanner 1, peso y talla acordes a edad (Pc 25). El resto del examen físico sin particularidades.

¿Cuáles de las siguientes son las conductas más apropiadas? Marcar hasta 3 opciones.

Seleccione una o más de una:

- A. Solicitar laboratorio con LH, FSH y estradiol.
- B. Solicitar radiografía de mano y muñeca izquierda con foco en tercer metacarpiano.
- C. Solicitar RMN de silla turca.

- D. Tranquilizar a la mamá y explicarle la normalidad de los hallazgos para la edad.
- E. Sugerir excluir el pollo y la soja de la dieta.
- F. Citar control en 4 a 6 meses para evaluar el crecimiento y progresión de la pubertad.
- G. Solicitar interconsulta con endocrinología.
- H. Anticipar a Juana y su madre los próximos cambios puberales esperables.
- I. Solicitar ecografía mamaria.
- J. Solicitar interconsulta con ginecología infanto-juvenil.

Mónica de 6 años y 3 meses de edad, sin antecedentes de relevancia, concurre para control de salud. Su mamá está preocupada por “su desarrollo”.

Al examen físico presenta botón mamario unilateral derecho, vello pubiano Tanner 1, peso y talla acordes a edad (Pc 10). El resto del examen físico sin particularidades.

¿Cuáles de las siguientes son las conductas más apropiadas? (Marque hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

- A. Solicitar ecografía mamaria.
- B. Solicitar radiografía de mano con foco en tercer metacarpiano
- C. Citar a control en 4 a 6 meses para evaluar el crecimiento y progresión de la pubertad
- D. Tranquilizar a la mamá y le explica la normalidad de los hallazgos para la edad.
- E. Interconsulta con endocrinología.
- F. Anticipar a Juana y su madre los próximos cambios puberales esperables.
- G. Solicitar RMN de silla turca
- H. Investigar el consumo y/o uso de sustancia con disruptores endocrinos.

3. Concurren por primera vez a su consulta Mariana de 14 años y su madre. La adolescente muestra actitud indiferente, cabeza inclinada mirando siempre a su celular. Al preguntarle a la niña el motivo de su consulta, la madre responde expresando que su hija debe obtener el apto para realizar educación física no competitiva. y además quiere que Ud. le explique a su hija que a esa edad no puede aplicarse piercing, no debería tatuarse ni asistir los fines de semana a locales bailables.

Mariana no realizó controles en salud desde hace tres años.

Es la mayor de tres hermanos, hijos de una pareja anterior de la madre. La señora comenta que se embarazó de Mariana a los 14 años.

La adolescente asiste al primer año de la escuela secundaria con buen desempeño.

Pregunta: Ante esta situación, señale entre las siguientes las conductas más adecuadas: (Marque hasta tres opciones).

- A. Le expresa a Mariana que le sugerirá algunas ideas como si se tratara de su propia hija.
- B. Proponer que Mariana exprese sus propias opiniones sin interrupciones de su madre
- C. En esta primera entrevista se debe consensuar con Mariana la presencia o no de la madre durante la entrevista.
- D. Le asegura a Mariana que a excepción de situaciones de riesgos asegura la confidencialidad de la entrevista.
- E. La explicación explica a Mariana que es necesario que ella se comprometa a aceptar las recomendaciones que usted le proponga.
- F. Prohíbe la adolescente ingerir alcohol y fumar por las consecuencias que ello trae a su salud.
- G. Informa a la adolescente que puede ingerir alcohol a dosis pequeñas.
- H. Explica que en la primera entrevista es necesaria la presencia de la madre durante toda la consulta.
- I. Realiza el examen físico incluyendo el examen ginecológico.
- J. Indica anticonceptivos orales por considerarla una paciente de riesgo

4. Ud. recibe en la consulta a Ulises de 12 años acompañado de su madre para realizar el apto físico, el último control con su pediatra fue hace un año y medio. Cursa 7mo grado, no repitió ningún año. Practica fútbol 2 veces por semana en el club, y actividad física de la escuela. Vacunas con carnet al día. Niega antecedentes de relevancia

Al examen físico, eucárdico, eupneico, presenta 1 mancha café con leche en muslo pequeña, Talla: 146.0 cm (talla objetivo genética de 1710 cm), peso: 40.0 kg y se encuentra en estadio de desarrollo puberal (tanner 2 para genitales y vello pubiano) y testículos 5 ml Maniobra de Adams: abombamiento y asimetría en región dorsal izquierda no dolorosa. Con los datos obtenidos hasta el momento.

¿Cuál de las siguientes opciones son las más adecuadas? (Marque hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una.

- A. Control ambulatorio en 1 año.
- B. Indicar corset TLSO 16 horas al día.
- C. Solicitar espinograma frente y perfil
- D. Contraindicar deporte de alto impacto en el club.
- E. Indicar tratamiento kinésico y reeducación postural global (RPG).
- F. Interconsulta a Ortopedia.
- G. Solicitar RMN de columna.
- H. Interconsulta a Dermatología.

6. VACUNAS

1. Tomy, de 17 meses y medio, concurre a control en salud en el mes de octubre. Es un RNT, 40 semanas de edad gestacional, hijo de madre diabética. No presenta otros antecedentes perinatólogicos de importancia. Peso y talla al nacer en percentilo 97. Ambos padres son sanos. El padre fuma, según referencia materna, “solamente fuera de casa”. Tomy inició jardín maternal a los 11 meses de vida con buena adaptación.

Al examen físico el niño presenta rinorrea anterior y posterior, fauces eritematosas, sin presencia de exudado, adenomegalias latero-cervicales móviles no dolorosas. Se encuentra afebril y refiere la madre que “vive resfriado desde que empezó el jardín”. El resto del examen físico es normal. No presenta nódulo de BCG.

Según consta en la historia clínica, se controló en este hospital una única vez a los 8 meses de vida. Los controles previos a los 8 meses los hizo en un centro de salud de su barrio.

A los 8 meses completó el esquema de vacunación que tenía atrasado y luego de esa ocasión no volvió a ser evaluado por un pediatra y no recibió nuevas vacunas. Al interrogar a la madre por qué no concurrió a los controles, ella le explica que no contaba con los medios para pagar el viaje al hospital y que en la salita de su barrio “no están dando turnos”.

Pregunta: ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta? (Marque hasta 3 opciones)

- A. BCG Contraindicada la vacunación hasta superar el cuadro respiratorio
- B. Interconsulta con inmunología.
- C. Sabin y Triple bacteriana acelular.
- D. Triple viral, Hepatitis A, Anti Neumococcica conjugada.
- E. Reiniciar el plan de vacunación dado el tiempo transcurrido.
- F. Antivaricela y antimeningococcica conjugada.
- G. Hepatitis B y antigripal.
- H. Sabin y Cuadruple – Pentavalente
- I. Difiere la vacunación con Antivaricela y Triple viral por 4 semanas.

2. Concorre a control Pamela de 5 años y 6 meses de edad. Es una niña con diagnóstico de asma moderada tratada con corticoides inhalados dos veces por día desde hace un año y salbutamol de rescate durante las crisis. En este momento se encuentra sin interurrencias, la última crisis la presentó hace 1 semana, pero resolvió sin requerir internación. Su desarrollo es adecuado para su edad, está por ingresar a primer grado. Las últimas dosis de vacunas las recibió al año de edad. Su madre se encuentra cursando un embarazo de 20 semanas. (Carnet vacunación)

¿Cuál es su conducta con respecto a las inmunizaciones? (Marque hasta 3 opciones).

Seleccione una o más de una:

- A. Pamela debe recibir Salk, DPT, vacuna antimeningocócica tetravalente, pero no puede recibir triple viral ni vacuna de varicela porque su madre está embarazada.
- B. Pamela no puede vacunarse porque está recibiendo tratamiento prolongado con corticoides.
- C. Pamela debe recibir Salk, DPT y Triple Viral, por su edad no está indicada la vacuna de varicela ni la antimeningocócica.
- D. Pamela debe recibir Sabin, DPT, Triple Viral, vacuna antimeningocócica tetravalente y vacuna de varicela.
- E. Pamela debe recibir Salk, DPT, Triple viral, vacuna antimeningocócica tetravalente y vacuna de varicela.
- F. Indicar a la madre vacuna DPT acelular y Hepatitis B, si no la tiene aplicada y vacuna antigripal estacional.
- G. Pamela debe recibir vacuna antigripal estacional y una dosis de Neumo 23 valente.
- H. Debe esperar 15 días luego de una crisis asmática para poder vacunar a Pamela.

4. Mariana concurre con sus hijos Margarita de 5 años y su hermano Félix de 18 meses al control de salud con su pediatra de cabecera. Margarita presenta asma, recibe tratamiento controlador con budesonide desde hace 3 años. Su último episodio bronco obstructivo fue hace 1 mes, recibió tratamiento ambulatorio con salbutamol y corticoides orales por 5 días. Hace 4 meses permaneció internada por presentar enfermedad de Kawasaki y recibió infusión de gammaglobulina endovenosa. Félix no presenta antecedentes relevantes, pero actualmente se encuentra cursando un cuadro de gastroenteritis aguda leve en resolución.

¿Qué vacunas son necesarias indicar en estos casos según el calendario oficial de vacunación? (Marque hasta tres opciones):

Seleccione una o más de una.

- A. Margarita debe recibir IPV y triple bacteriana.
- B. Margarita debe recibir IPV y triple viral
- C. Félix debe recibir quíntuple.
- D. Margarita tiene contraindicada la vacuna triple viral.
- E. Margarita debe recibir OPV, triple bacteriana y triple viral
- F. Félix debe recibir IPV y quíntuple.
- G. Margarita debe recibir IPV, triple bacteriana y triple viral

H. Félix debe recibir las vacunas una vez resuelto el cuadro gastrointestinal.

5. En el mes de marzo, concurre a su consultorio Matías de 8 años para realizar el control en salud y confeccionar el apto físico para realizar actividad deportiva no competitiva. El niño carece de antecedentes perinatólogicos de importancia. A partir de los 5 años de vida padeció 4 episodios broncoobstructivos que se resolvieron ambulatoriamente. Por tal motivo en la actualidad recibe tratamiento preventivo con budesonide. La mamá le comenta que la familia está pasando por un momento muy difícil ya que hace unos meses le han diagnosticado leucemia al hermanito de Matías y comenzó a recibir tratamiento quimioterápico. Por ese motivo se atrasaron los controles en salud de Matías. Cuando Ud analiza el carnet de inmunizaciones de Matías constata que el paciente recibió las siguientes vacunas:

BCG: una dosis Hepatitis: B una dosis Pentavalente: 4 dosis Salk: dos dosis Sabin: dos dosis Rotavirus: dos dosis Neumococo: tres dosis Meningococo: tres dosis Triple viral: una dosis Hepatitis A: una dosis

Al realizar el examen físico Ud constata ausencia de cicatriz por nódulo de vacuna BCG. El paciente presenta abundantes secreciones nasales aunque el estado general es bueno. El resto del examen físico no presenta particularidades.

Pregunta: Con respecto al registro de vacunas que presenta el paciente, Ud. piensa que: (Marque hasta 3 opciones)

- A. Está contraindicado indicar a Matías ningún tipo de vacunas hasta finalizar la inducción de su hermano.
- B. Está contraindicado que Matías reciba ningún tipo de vacuna a virus vivo atenuado.
- C. Matías tiene vacunas completas para su edad
- D. Matías debe recibir una dosis de Salk
- E. Matías debe recibir una dosis de vacuna Sabin
- F. Matías debe recibir una dosis de vacuna Triple bacteriana celular
- G. Matías debe recibir una dosis de vacuna Triple bacteriana acelular**
- H. Matías debe recibir una dosis vacuna Triple Viral y antivariola**
- I. Matías debe reiniciar el esquema de vacunación completo
- J. El tratamiento actual con Budesonide inhalatorio contraindica la aplicación de vacunas a virus vivos atenuado.

6. Juan de 11 años y 9 meses de edad concurre a la Guardia acompañado por su madre, por quemadura de segundo grado en ambos miembros superiores secundario a un accidente doméstico.

Completó el plan nacional de vacunas hasta las de ingreso escolar a los 6 años, donde recibió triple bacteriana, triple viral y Salk.

Teniendo en cuenta los datos aportados, ¿cuáles son las conductas más adecuadas? Marque 3 opciones

Seleccione una o más de una:

- A. Aplicar vacuna antimeningocócica
- B. Aplicar HPV tetravalente
- C. Aplicar gammaglobulina antitetánica + vacuna Triple bacteriana acelular (dTpa)
- D. Aplicar vacuna doble adultos
- E. Reiniciar esquema completo de vacunación antitetánica
- F. No aplicar ninguna vacuna
- G. Aplicar Triple bacteriana (DTP)
- H. Aplicar vacuna Triple bacteriana acelular (dTPa)

7. Usted atiende por primera vez a Santino, un paciente de 18 meses procedente de Neuquén. La familia vivió siempre en esa provincia en un pueblo de la cordillera. El niño es sano, sólo tuvo fiebre en una oportunidad durante tres días luego de lo cual tuvo un exantema que tardó 72 hs en desaparecer. En esa oportunidad el médico general le diagnosticó sarampión con buena evolución. Se encuentra en percentilos 50 para talla y peso y presenta el siguiente esquema de vacunación:

BCG a los dos días de vida

Hepatitis B el día del nacimiento

Sextuple, antineumocócica trecevalente y antirotavirus a los 2 y 4 meses

Antimeningocócica tetravalente a los 3 y 7 meses.

Sextuple a los 7 meses.

Hepatitis A y antineumocócica trecevalente a los 14 meses.

En relación con la vacunación, ¿cuáles de las siguientes vacunas están indicadas en este niño en este momento? Marcar hasta 3 opciones.

Seleccione una o más de una:

- A. DPT, Hib + Salk
- B. Triple viral (sarampión, paperas y rubéola)
- C. Sabin
- D. Antimeningocócica tetravalente
- E. Antineumocócica trecevalente
- F. DPT, Hib
- G. Sextuple
- H. Antorotavirus
- I. Antivaricela
- J. Doble viral (paperas y rubéola)

8. La mamá de Félix de 7 años de edad, le consulta acerca de los efectos de la administración de las vacunas que su hijo ha recibido o que recibirá más adelante.

Con relación a las preguntas que ella le formula, Ud. le informa lo siguiente: (marque hasta tres opciones).

- A. Puede demostrarse la efectividad de la vacuna anti hepatitis B si se le extrae a Félix una muestra de sangre y se detecta el antígeno de superficie HBsAg.
- B. Al ingreso escolar era necesario que recibiera un refuerzo de vacuna antineumocócica conjugada.
- c. Al haber recibido la vacuna anti hepatitis A a los 12 meses, puede determinarse en suero el anticuerpo denominado IgM HAV.
- D. Al ingreso escolar debería haber recibido el refuerzo para hepatitis A.
- E. **Habiendo recibido la vacuna contra la varicela, si la contrajera nuevamente, la infección transcurrirá más leve y con pocas lesiones.**
- F. **Respecto a la inmunización para tétanos, pertussis y difteria, a partir de ahora sólo podrá recibir vacunas acelulares.**
- G. La aplicación de la vacuna BCG que Félix recibió al momento del nacimiento, impide la posibilidad de que adquiera tuberculosis a edades posteriores.
- H. **Si bien la parotiditis es una enfermedad relativamente benigna, al haber recibido la vacuna, se evita en gran medida la meningoencefalitis y la anacusia.**

Concurre a la consulta Sergio, de 6 años de edad, con su mamá, Eugenia. Ella le pregunta acerca de los efectos de las vacunas.

Con relación a la vacunación Ud. le informa... Marque 3 opciones.

Seleccione una o más de una:

- A. **A partir de este momento se le administrará a Sergio la vacuna triple bacteriana acelular porque presenta menos efectos secundarios para el componente pertussis que la vacunas celulares tradicionales.**
- B. Al ingreso escolar Sergio debe recibir un refuerzo de la vacuna antineumocócica.
- C. **A pesar de que la parotiditis es una enfermedad relativamente benigna, al haber recibido la vacuna, se evita en gran medida la meningoencefalitis y la sordera.**
- D. La vacuna antigripal que Sergio ya recibió reduce la incidencia de resfriados estacionales
- E. La aplicación de la vacuna BCG al nacer impide la posibilidad de adquirir tuberculosis a edades posteriores.
- F. **La vacuna contra la varicela evita las formas graves, en caso de contraerla, la infección transcurre más leve y con pocas lesiones.**
- G. La vacuna antisarampínosa es una vacuna a virus vivos atenuados que Sergio recibió al cumplir los 12 meses de edad la cual no requiere una dosis adicional de refuerzo.

- H. Al ingreso escolar es necesario que Sergio reciba un refuerzo de vacuna antineumocócica conjugada.

7. ITU

1. Concurren a la consulta Juan y Marcela con su hija Camila de 6 años de edad. Refieren con preocupación que la niña presentó en el corriente año, dos episodios afebriles de “ardor al orinar”, acompañados de micciones frecuentes y, en forma esporádica, incontinencia urinaria.

Recibió tratamiento con distintos antibióticos con involución de los síntomas mencionados. El tratamiento siempre fue precedido por toma de urocultivo y en forma recurrente cultivó + de 10⁵ UFC/ml de Escherichia Coli.

Camila presenta examen físico dentro de límites normales, eutrófica con Peso en Pc 50 y Talla Pc 75. Diuresis: retención y 2-3 micciones diarias. Catarsis: cada 2-3 días, con escóbalos.

¿Qué conductas iniciales considera las más adecuadas? Marcar hasta 3 opciones.

Seleccione una o más de una:

- A. Indicar profilaxis antibiótica con cefalexina durante 6 meses
- B. Derivar al urólogo por incontinencia urinaria
- C. Recomendar vaciado vesical frecuente 9 (6-8 micciones por día)
- D. Indicar ecografía renovesical
- E. Realizar pielografía
- F. Indicar enemas evacuantes de Murphy
- G. Indicar microenemas
- H. Incrementar la ingesta de líquidos, dieta rica en fibras y adecuada higiene genital
- I. Indicar cistouretrografía miccional
- J. Indicar profilaxis antibiótica con nitrofuratoína durante 6 meses

3. Lorena asiste al consultorio con su hijo Lautaro, de 5 meses de edad, quien no presente antecedentes de relevancia. Es el quinto hijo de la familia. Viven en Flores.

Laura refiere que notó a Lautaro más decaído durante los últimos días. Lo alimenta con pecho materno exclusivo a libre demanda y comenta que, desde hace 72 horas, presenta mala actitud alimentaria con diuresis conservada y catarsis negativa.

Antecedentes personales: nacido de término (39 semanas) peso de nacimiento 3165 gr. Alta conjunta a las 48 horas con un peso de 2.985g (descenso de 5.7%), pesquisa metabólica neonatal normal. Presentó falta de seguimiento clínico presencial desde los 3 meses de

vida, debido a la pandemia por Covid-19. Último registro de peso a los 3 meses: 4.900gr (Pc 50).

Se constata en el examen físico: paciente adelgazado con mal progreso de peso, peso actual de 5.100gr (Pc 3.). se observa a Lautaro aletargado con regular estado general, mucosas semi húmedas.

Se lo deriva a la guardia para solicitar estudios y se informan los siguientes resultados. Hto 35%, Hb, 11.1gr/dl, G blancos 18000/mm³, neutrófilos 60%, linfocitos 25%, eosinófilos 3%, basófilos 1%, monocitos 6%, plaquetas 420.000/mm³ 200-400, proteína C reactiva ultrasensible 35mg/l. Orina completa turbia, densidad 1015, pH7, sedimento con abundantes leucocitos (30-40), hematíes 3-5, nitritos positivos con campo cubierto de piocitos. Hepatograma y función renal normal. Hemocultivo y urocultivo pendientes.

De acuerdo a su hipótesis diagnóstica, cuáles son las conductas más adecuadas en el abordaje de este paciente?

Marcar hasta 2 opciones.

- A. Indicar antibiótico vía oral, realizar manejo ambulatorio y controlar en 48 horas
- B. Dar pautas nutricionales y citar al paciente con los resultados pendientes en 1 semana
- C. Si presenta urocultivo patológico solicitar ecografía y cistouretrografía miccional
- D. Si presenta urocultivo patológico realizar ecografía renal y de vías urinarias sin indicar otros estudios complementarios .**
- E. Realizar centellograma renal una vez completado el tratamiento
- F. Internar y tomar conducta antibiótica expectante hasta el resultado del urocultivo
- G. Internar e indicar tratamiento antibiótico parenteral**
- H. Realizar interconsulta con nefrología y nutrición

4. Consulta a la guardia Mariela con su hija Sofía de 20 meses de edad, previamente sana. Sofía comenzó con fiebre hace 72 horas con 3 registros de 38,5 grados por día que mejoran con antitérmicos. Durante las primeras 48 horas hizo seguimiento telefónico con su pediatra de cabecera y en el día de hoy al persistir la fiebre y tener dos episodios de vómitos le indicó consultar a la guardia donde usted la recibe.

Al examen físico Sofía se encuentra febril, decaída, con 38 grados, dolor a la palpación abdominal periumbilical, sin defensa. Resto del examen físico normal.

Administra dosis de Ibuprofeno y al ceder la fiebre Sofía se encuentra en buen estado general. Se realiza orina completa: pH 6, densidad 1020, nitritos positivos, leucocitos 20 a 30 por campo (normal es 5- 10). Resto normal.

¿Qué conductas se consideran más adecuadas en este momento? (Marque hasta 3 opciones).

Seleccione una o más de una

- A. Indicar tratamiento con antibiótico vía oral.**
- B. Controlar en forma ambulatoria en 24-48 horas.**

- C. Solicitar urocultivo por punción suprapúbica, recuento de colonias y antibiograma.
- D. Indicar tratamiento con antibiótico parenteral.
- E. Solicitar hemograma, eritrosedimentación, PCR.
- F. Solicitar urocultivo al aseo y recuento de colonias con antibiograma.
- G. Internar a Sofía.
- H. Diferir inicio de antibiótico hasta recibir los resultados pendientes.

5. Ramiro tiene 50 días de vida, RNT PAEG, producto de un embarazo controlado, sin antecedentes perinatológicos relevantes. Vacunación completa. Acorde a la edad. Se alimenta con lactancia materna exclusiva. Es traído a la guardia por su madre, quien refiere que Ramiro presentó un pico febril de 38.4°C la noche anterior, por lo que administró paracetamol. En la mañana del día de la consulta constató un registro térmico de 37.8°C y acude a la consulta. La madre manifiesta que el paciente se alimenta con avidez cada 2 horas, que no presentó vómitos, que no modificó la coloración de la piel ni se mostró irritable.

Al momento del examen físico: vigil, reactivo. Temperatura axilar: 37°C. fontanela anterior normotensa. Normocolorado. Normohidratado. Frecuencia respiratoria: 36/min. Buena entrada bilateral de aire sin ruidos agregados. Frecuencia cardíaca: 135/ min. Soplo sistólico 2/6 (Soplo inocente) que modifica su intensidad con los cambios de decubito, sin irradiación. Hemodinamicamente compensado. Buen relleno capilar. Resto del examen físico sin características a destacar.

Ud. Solicita exámenes complementarios que informan: Hemograma: Leucocitos: 13.900/mm³, neutrofilos segmentados: 35%. Neutrofilos en cayado 4%. Linfocitos 61%. Hemoglobina: 12.9g/dl; Plaquetas: 235000/mm³. ERS: 19mm a la 1era hora, PCR: 4.10. Radiografía de torax: normal. Silueta cardíaca sin características a destacar. Orina: pH 5.8; densidad: 1010. Leucocitos: 20-25/cpo. Hematíes 2-5/cpo. Uratos amorfos.

Además de indicar antitermicos, Cuales son las conductas más adecuadas? (Marque hasta 3 opciones)

- A. Mediar con antibióticos parenterales una vez tenido los resultados de cultivos.
- B. Solicitar ecografía abdominal, renal y de vías urinarias.
- C. Dar pautas de alarma y controlar en 24 horas.
- D. Mediar con ceftriaxona de inmediato.
- E. Realizar hemocultivos y urocultivo.
- F. Mediar con cefalexina.
- G. Indicar la internación.
- H. Solicitar ECG y evaluación cardiológica.

6. Concurren a su consultorio Juan y Marcela con su hija Camila de 6 de edad por fiebre y vómitos de 48 hs de evolución. Refieren con preocupación que la niña presentó en el corriente año, dos episodios afebriles de "ardor al orinar", acompañados de micciones frecuentes y en forma esporádica incontinencia urinaria. Recibió tratamiento con distintos

antibióticos con remisión de los síntomas mencionados. El tratamiento siempre fue precedido por toma de urocultivo y en forma recurrente cultivó mayor de 105 UFC/ml de *Escherichia Coli*.

Actualmente Camila presenta fiebre de 38,5-39°C. Examen físico: regular estado general, febril, reactiva, mucosas semihúmedas, pulsos periféricos presentes y simétricos, relleno capilar menor a 2 segundos. Frecuencia cardíaca: 135 latidos/ min, Presión arterial: 90/60 mm/Hg. Abdomen blando, doloroso a la palpación, RHA presentes, no se palpan visceromegalias.

¿Cuáles de las siguientes conductas iniciales considera más adecuadas? (Puede marcar hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

- A. indicar antibióticos por vía oral.
- B. Solicitar hemograma, PCR, orina completa, urocultivo, 2 hemocultivos.
- C. Dar pautas de hidratación, antitérmicos y control ambulatorio con los resultados de los estudios solicitados.
- D. Radiografía de abdomen de pie.
- E. Interconsulta con cirugía infantil.
- F. Indicar antibiótico por vía endovenosa.
- G. Solicitar cistouretrografía con placa miccional y postmiccional.
- H. Colocar plan de hidratación parenteral e internación

8. DIARREA Y DHT

1. Concorre a la consulta Sabrina de 9 años acompañada por su mamá, Elisa de 29 años. Se trata de una niña previamente sana hasta los 6 años en el que registra su último control en salud. Refiere como Motivo de consulta un dolor abdominal de varios meses de evolución.

Si bien no puede precisar con exactitud el comienzo de los dolores, lo sitúa aproximadamente a principios de año (4 meses atrás) coincidiendo con el inicio de las clases. Elisa los atribuyó a que el cambio de turno (ahora concurre a la mañana) la obligaba a desayunar más rápido o no hacerlo. Comenzó a acostarse y despertarse más temprano y así “desayunaba mejor” (una infusión con leche y un pan con mermelada).

Al poco tiempo los dolores reaparecieron y la madre comenzó a administrarle gotas de antiespasmódico y analgésico con escasa respuesta. Los dolores continuaron hasta cuatro

días a la semana y en estas últimas con mayor intensidad, llegando incluso a tener que retirarla de la escuela y despertarse por la noche.

Relata que el dolor se localiza a veces en el flanco izquierdo y a veces no lo puede precisar. Muchas veces el dolor también le producía falta de apetito, pero sin dolor “come muy bien” afirma Elisa. El ritmo evacuatorio variaba entre episodios de constipación con diarreas desligadas y explosivas. Estos cambios no se relacionaban con la ingesta de alimentos determinados ni con fiebre.

En alguna oportunidad presentó sangre en las deposiciones y en algunas ocasiones tenía náuseas y vómitos como pródromos de los dolores.

Tiene antecedentes de tratamiento familiar con Mebendazol + Tinidazol hace 3 semanas por prurito anal asociado, sin examen parasitológico previo.

Al examen físico presenta un peso en Pc 25/50, talla en Pc 50, IMC en Pc 25. Mucosas húmedas, conjuntivas discretamente pálidas.

Frecuencia cardíaca: 98 latidos por minuto, sin soplos. Frecuencia respiratoria 22 por minuto 15-20, entrada de aire conservada, sin ruidos agregados.

Abdomen blando, ligeramente distendido, indoloro a la palpación superficial, sin defensa, con dolor a la palpación profunda en región periumbilical, sin visceromegalias, ruidos hidroaéreos presentes, marco colónico timpánico.

Pregunta: De acuerdo a la sospecha diagnóstica inicial, cuáles son las conductas diagnósticas iniciales más apropiadas? (Marque hasta 4 opciones).

- A. Hemograma, hepatograma, urea, creatinina y glucemia
- B. IgA antitransglutaminasa y determinación de IgA sérica
- C. Orina completa y urocultivo
- D. Radiografía de abdomen de pie
- E. Coproparasitológico
- F. Videocolonoscopia
- G. Ecografía abdominal
- H. Tomografía abdominal computada con contraste de abdomen y pelvis.
- I. Endoscopía digestiva alta.
- J. Test cutáneo para determinación de alergia a la proteína de leche de vaca.

2. Hace 1 mes y medio, Mariel de 5 años concurrió a la consulta con sus padres por presentar diarrea intermitente. Presentaba fiebre y deposiciones líquidas sin sangre. Sus dos hermanos comenzaron al mismo tiempo y resolvieron el cuadro en una semana. Mariel continuó con episodios repetidos de diarrea. Desde el comienzo de los síntomas realizó dieta hipofermentativa irregularmente. Actualmente, al examen físico Ud. la encuentra en buen estado general, afebril. Abdomen globoso, depreciable e indoloro. No palpa visceromegalias. En el resto del examen físico se encuentra dentro de parámetros normales.

Constata un descenso de peso de casi 300 gramos en este período.

¿Cuáles son las conductas más adecuadas? Marque 3 opciones

Seleccione una o más de una:

- A. Indicar leche con contenido reducido en lactosa
- B. Indicar dieta hipercalórica
- C. Solicitar coprocultivo
- D. Indicar dieta con bajo aporte de azúcares simples
- E. Indicar tratamiento con mebendazol para el paciente y el grupo familiar
- F. Solicitar parasitológico de materia fecal
- G. Solicitar anticuerpos para enfermedad celíaca, hemograma, eritrosedimentación y hepatograma
- H. Indicar dieta libre de gluten

3. Julián, de 18 meses de edad, presenta episodios reiterados de diarrea y notario “muy flaquito”. Llega a la consulta con su madre quien refiere que desde hace 3 meses presenta episodios de diarrea, con 4 a 6 deposiciones grumosas, malolientes, que no mejoran con la dieta que le recomendaron varias veces en la guardia.

No presenta antecedentes personales ni familiares de interés. Julián vive con sus padres y los abuelos maternos en una vivienda precaria en el tercer cordón del conurbano. La vivienda tiene un dormitorio común, cocina, agua de pozo y letrina.

Julián tomó el pecho hasta los 6 meses y luego leche de vaca y papillas, recibió hierro y vitaminas durante 2 meses. Actualmente come con sus padres preferentemente guisos y sopas. Vacunas completas con carnet.

EXAMEN FÍSICO: impresiona algo pálido, con mirada vivaz, hidratado, abdomen globuloso y timpánico a la percusión. Miembros inferiores algo adelgazados . Peso 9100 plo 3-10, talla 82 cm plo 25. Dermatitis de pañal.

Recientemente le hicieron algunos análisis: Hto 29%, Hb. 10.1 gr/dl, G. blancos 8500/mm³ neutrófilos 37%, Linfocitos 51%, eosinófilos 3%, basófilos 1%, monocitos 8%. Orina completa densidad 1012, pH 7 , sedimento escasos leucocitos, y hematíes, algunos piocitos, resto normal, inmunoglobulinas normales, anticuerpos antitransglutaminasa negativo, parasitológico pendiente.

Con respecto a las causas de la diarrea, ¿cuáles son, al momento, sus hipótesis diagnósticas? Marcar hasta 2 opciones.

Seleccione una o más de una:

- A. Alergia a la proteína de la leche de vaca.
- B. Diarrea por malabsorción de lactosa .
- C. Diarrea por mala absorción de grasas
- D. Diarrea perdedora de proteínas
- E. Probable enfermedad inflamatoria intestinal
- F. Probable giardiasis intestinal
- G. Diarrea por rotavirus

4. Concorre a la consulta Ana con sus dos hijas mellizas de 2 años de edad previamente sanas. Ana refiere que ambas han comenzado con diarrea hace 48 horas, pero se encuentra más preocupada por María que se encuentra molesta, llora sin lágrimas, ha vomitado 6 veces en las últimas 2 horas a pesar de ofrecer líquidos fraccionados con cucharas y no ha orinado en las últimas 12 horas.

Al examen físico María presenta frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto, buen relleno capilar, ojos hundidos, signo del pliegue y mucosas secas.

La otra niña, Carmela, no ha presentado vómitos, y al examen físico se observa mucosas semihúmedas, frecuencia cardíaca 100 latidos por minuto, esbozo de signo de pliegue, resto sin particularidades .

Ante esta situación ¿cuáles opciones son las más adecuadas? (Marque hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

- A. Indica a Carmela sales de rehidratación oral y reevalúa en una hora.
- B. Internar a María.
- C. Indica probar tolerancia oral a Carmela con solución isotónica en su domicilio.
- D. Usted decide internar a ambas hermanas, e indica hidratación convencional por vía enteral.
- E. Rehidrata a María por sonda nasogástrica con sales de rehidratación oral.
- F. Rehidrata a María en forma endovenosa.
- G. Usted decide internar a ambas hermanas, e indicar a ambas niñas soluciones polielectrolíticas.
- H. Decide internar a ambas hermanas, solicita laboratorio e indica hidratación convencional por vía parenteral.

5. Julián de 18 meses consulta con su madre que refiere que desde hace aproximadamente 3 meses presenta episodios de diarrea, con 4 a 6 deposiciones grumosas, malolientes, que no mejoran con la dieta que le recomendaron varias veces en la guardia. No presenta antecedentes personales ni familiares de interés. Viven en una vivienda precaria en el tercer cordón del conurbano, con su pareja y abuelos maternos, con un dormitorio común, cocina, agua de pozo y letrina. Julián tomó el pecho hasta los 6 meses y luego leche de vaca y papillas, recibió hierro y vitaminas durante 2 meses. Actualmente come con sus padres preferentemente guisos y sopas. Vacunas completas con carnet.

Al examen físico impresiona pálido, con mirada vivaz, hidratado, abdomen globuloso y timpánico a la percusión. Miembros inferiores algo adelgazados. Peso 9.100 Kg (Pc 3-10), talla 82.0 cm (Pc 25). Dermatitis del pañal.

En relación a lo previamente mencionado, cuáles de las siguientes conductas diagnósticas iniciales son las más adecuadas? (Puede marcar hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

- A. Clearence de alfa 1 antitripsina.
- B. Test de Van de Kamer**
- C. Búsqueda de Adenovirus y Rotavirus en materia fecal.
- D. Radiografía de abdomen de pie.
- E. Ecografía abdominal.
- F. Hemograma con fórmula y proteinograma.**
- G. Coprocultivo con antibiograma.
- H. Parasitológico en fresco y seriado.**

6. Benicio, de 9 meses de edad es llevado a consulta al servicio de emergencias por sus padres. Refieren que su hijo presenta deposiciones líquidas abundantes y frecuentes desde hace 6 horas. No han notado signos compatibles con cólicos ni dolor abdominal.

Examen físico: niño en buen estado general. Temperatura: 37,2°C. Peso: 8.900 gramos. Conjuntivas pálidas. Mucosas semihúmedas. Fontanela normotensa. Llanto sin lágrimas. Frecuencia cardíaca: 100 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria: 40 respiraciones por minuto. Relleno capilar: menos de 2 segundos. Abdomen blando, con borborignos.

**Respecto al problema de Benicio, las conductas más adecuadas a seguir son:
(marque hasta tres opciones):**

Seleccione una o más de una:

- A. Indicar SRO 20 ml/kg cada 20-30 minutos.**
- B. No indicar antibióticos.**
- C. Indicar hidratación parenteral.
- D. Acortar el curso de la diarrea administrando antibióticos precozmente.
- E. Indicar la colocación de sonda nasogástrica.
- F. Solicitar coprocultivo y administrar antibióticos según la sensibilidad informada.
- G. Continuar con su alimentación habitual y ofrecerle SRO luego de cada vomito y/o deposición líquida.
- H. Solicitar ionograma sérico y si los valores son normales, enviarlo a su domicilio.**

7. Felicitas es una niña de 11 meses, sin antecedentes patológicos relevantes, con desarrollo neuromadurativo acorde a edad y esquema de vacunación completo. Su peso actual es de 10.0 kg, su talla de 73,4 cm y su perímetro cefálico de 46.0 cm. Se alimenta con lactancia materna y semisólidos. Es traída a la consulta por presentar diarrea sin moco, pus ni sangre de 4 días de evolución. No presentó registros febriles. Se encuentra normohidratada, la diuresis está conservada y su estado general es adecuado.

En relación a su alimentación en el contexto de su cuadro diarreico actual, que indicaciones le daría a su mamá? (Marque hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

- A. Continuar con lactancia materna.
- B. Indicar manzana rallada y banana pisada.
- C. Agregar una toma de leche de soja.
- D. Agregar fórmula sin lactosa.
- E. Indicar harina de maíz, fideos con aceite y carnes magras bien cocidas.
- F. Suspender transitoriamente la alimentación e indicarle sales de rehidratación oral
- G. Indicar compota de pera con edulcorante.
- H. Alternar lactancia materna con leche diluida al 1/2 con agua.

9. Pedro es un niño de 9 meses que es llevado a la guardia de un hospital del conurbano bonaerense por presentar vómitos. La madre relata que comenzó hace 48 horas con deposiciones líquidas, sin contenido hemático, moco o pus, frecuentes y que posteriormente presentó vómitos inicialmente de tipo alimentarios y escasos, incrementando en frecuencia y magnitud. En el día de hoy lo nota molesto, pálido e irritable.

Antecedentes: nacido de término, de un embarazo controlado, parto vaginal, Apgar 9/10, peso de nacimiento 3.200 grs, sus vacunas están completas. Alimentado con pecho desde el nacimiento, incorporó semisólidos a partir del 6o mes. En casa de su madrina probó unas hamburguesas caseras los días previos y su madre piensa que no le han caído muy bien considerando que tal vez estaban muy condimentadas. Al examen físico ud constata palidez cutáneo-mucosa generalizada, mucosas secas, pliegue ++, buena entrada de aire bilateral sin rales agregados, R1 R2 en 4 focos, leve soplo sistólico en mesocardio, enoftalmos, relleno capilar de 2 segundos, frecuencia cardíaca 150 latidos/min, frecuencia respiratoria 44 respiraciones/min, pulsos periféricos presentes, llora sin lágrimas, peso actual 7.900 gr para un peso anterior de 8.400 kg(=6%), abdomen tenso, ruidos hidroaéreos disminuidos, no se palpan visceromegalias, deposiciones escasas con estrías de sangre y oliguria.

Pregunta: De acuerdo a lo expuesto hasta el momento, cual es su impresión diagnóstica? (Marque hasta 3 opciones)

- A. Shock séptico
- B. Deshidratación grave
- C. Deshidratación moderada
- D. Enfermedad celíaca
- E. Enfermedad inflamatoria intestinal
- F. Invaginación intestinal
- G. Sme urémico hemolítico
- H. Parasitosis intestinal
- I. Insuficiencia cardíaca
- J. Giardiasis intestinal.

10. Aytor, de 9 meses de vida, concurre a la consulta con su mamá y papá, porque lo observan, desde hace dos horas, muy decaído y con mucho sueño.

Refieren que durante las últimas 48 horas presentó deposiciones líquidas que sobrepasaron el pañal. Al examen físico se observan: ojeras marcadas, somnoliento, polipneico. Presenta

pliegue cutáneo persistente, mucosas secas, relleno capilar de 5 segundos y extremidades frías.

Ante este cuadro clínico, cuáles son sus conducta iniciales? Marcar hasta 2 opciones.

- A. Rehidratación mediante sonda nasogástrica
- B. Prueba tolerancia oral y rehidratación en guardia
- C. Indicar expansión con solución fisiológica**
- D. Indicar radiografía de tórax
- E. Internación, realizar hemocultivos y coprocultivo
- F. Prueba de tolerancia oral y continuar con dieta en su casa con control ambulatorio en 24hrs
- G. Administrar loperamida
- H. Colocar oxígeno por mascara.**

11. Ud. está atendiendo en el consultorio a Gabriel de 2 años de edad. Su madre, Malena, consultó oportunamente porque su hijo, presentaba desde hacía aproximadamente tres meses, deposiciones más blandas y abundantes que las que acostumbraba tener antes. Junto con la valoración clínica de Gabriel, se le investigaron en la última consulta los anticuerpos IgA antitransglutaminasa que resultaron positivos, la biopsia confirma la sospecha diagnóstica.

¿Cuál es la información más adecuada para comunicar a Malena respecto de la afección de Gabriel? (Marque hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

- A. El crecimiento pondoestatural será subóptimo, aunque el tratamiento se cumpla dentro de las pautas previstas.
- B. Gabriel tendrá un crecimiento pondoestatural normal, si cumple con las indicaciones y los controles regulares.**
- C. Debe efectuar dieta libre de gluten hasta completar el cierre de los cartílagos de crecimiento.
- D. Gabriel requiere estudios adicionales para comenzar una dieta libre de gluten
- E. Es muy probable que Gabriel pueda consumir gluten sin inconvenientes, durante el transcurso de su vida adulta.
- F. **Debe efectuar régimen libre de gluten de por vida.**
- G. Si se mantiene sin síntomas clínicos, después de 1 año de no recibir gluten, podría incorporar el mismo de modo paulatino, bajo estricta supervisión médica.
- H. Es necesario investigar la posible presencia de enfermedad celíaca en el grupo familiar.**

12. Celeste, de 1 año y 3 meses de edad, es llevada por sus padres al servicio de emergencias del hospital cercano a su domicilio. Ellos refieren que su hija comenzó con fiebre, vómitos y dolor abdominal hace poco más de 72 horas, período en el cual, luego de la consulta con su pediatra de cabecera, le habían administrado antitérmicos y líquidos fraccionados en cucharitas. En las últimas horas del día de ayer comenzó a presentar deposiciones diarreicas sanguinolentas.

Examen físico: Peso 10,0 kg. Talla: 77,0 cm. Regular estado general. Acentuada palidez, decaimiento e irritabilidad. Se observa rash petequial difuso y algunos hematomas en miembros. Se le solicitan a Celeste distintos estudios complementarios para efectuar el diagnóstico.

De acuerdo a su hipótesis diagnóstica, en el laboratorio de Celeste ¿qué es lo más probable que se observe? (Marque hasta tres opciones)

Seleccione una o más de una:

- A. Hipocromía y microcitosis en el frotis.
- B. Hematocrito: 31%.
- C. Leucocitos: 15000/dl.
- D. Urea: 35 mg/dl.
- E. Hemoglobina: 7.5 gr/dl.
- F. Plaquetas: 250000/mm³.
- G. Natremia: 125 mEq/l.
- H. Hematíes en orina: 30 por campo.

13. Malena, de 3 años de edad, concurre con sus padres al centro de Salud próximo a su domicilio. Relata que hace 15 días, fue examinada por otro profesional por estar cursando un episodio de deposiciones malolientes e inapetencia. Constató un leve descenso de peso respecto de controles previos, motivo por el cual le solicitó un examen coproparasitológico. Malena concurre al jardín maternal. En la actual consulta, Ud. verifica el informe, en el que se revela la presencia de quistes de Giardia lamblia. Los convivientes no refieren síntomas gastrointestinales.

¿Cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? (Puede marcar hasta tres opciones)

Seleccione una o más de una:

- A. Recomendar que Malena no deambule sin calzado en pisos con tierra.
- B. Suspender 7 días la concurrencia de Malena al Jardín Maternal.
- C. Evaluar las condiciones medioambientales en las que se desarrolla Malena.
- D. Indicar mebendazol a Malena.
- E. Indicar un estimulante del apetito a Malena.
- F. Indicar tratamiento empírico antiparasitario a los padres.
- G. Si los padres fueran portadores no es necesario que reciban antiparasitarios.
- H. Indicar metronidazol a Malena.

14. Silvina, de 10 años de edad, es traída a la consulta por sus padres, quienes comentan que su hija presenta desde hace meses dolor abdominal. Presenta deposiciones desligadas en forma intermitente y en ocasiones acompañadas de mucosidad con estrías sanguinolentas. Efectuó consultas en otras oportunidades, durante las cuales se asoció el dolor con dificultades escolares y otras veces a transgresiones alimentarias. Debido a ello, fue tratada ocasionalmente con cambios en la dieta, además de la sugerencia de tener una entrevista con su maestra de grado. Los padres de Silvina han notado que últimamente se despierta por la noche al presentar dolor abdominal y deseos de evacuar. La madre está preocupada porque la nota inapetente, decaída y bastante más delgada, sin poder precisar cuánto ha bajado de peso.

Examen físico: Niña en regular estado general, afebril, decaída, adelgazada, con facies dolorosas. Peso: 24 Kg. (Pc 3-10) Talla 122 cm (Pc 3). Percentilos previos (Pc 25-50). Conjuntivas pálidas. Mucosas húmedas. Uñas en "vidrio de reloj". Abdomen plano, levemente tenso, dolor difuso e intenso, a predominio en flanco e hipocondrio izquierdo.

Se le efectuaron a Silvina los siguientes exámenes complementarios: Polimorfonucleares en materia fecal (+), parasitológico: Entamoeba coli, huevos de oxiurus vermicularis. Hemograma: Hematíes: 4.250.000/dl; hemoglobinemias: 10,3 gr/d, hematocrito: 32%, leucocitos: 7.500/mm³, neutrófilos 60%, linfocitos 35%, monocitos 4%, eosinófilos 1%, basófilos 0%. Plaquetas: 580.000/dl. Eritrosedimentación: 40 mm/1a hora. Proteínas totales: 5,5 gr/dl 5,9-8. Albúmina: 2,5 gr/dl, α_1 : 0,20 gr/dl α_2 : 0,80 gr/dl, β : 0,60 gr/dl, γ : 1,40 gr/dl.

Con los datos mencionados, ¿Cuáles son las conductas más apropiadas a seguir? (Puede marcar hasta tres opciones)

Seleccione una o más de una:

- A. Considerar que Silvina deberá efectuarse una endoscopia.
- B. Internar a Silvina.
- C. Realizar tratamiento antiparasitario antes de continuar con otras medidas de seguimiento.
- D. Comenzar administración de hierro por vía oral.
- E. Indicar dieta hiperproteica, en particular con alto contenido en albúmina.
- F. Solicitar coprocultivo.
- G. Indicar dieta astringente y reevaluar luego de valorar su eficacia.
- H. Solicitar una interconsulta con psicología.

16. Lautaro, de 2 años de edad, es llevado a la consulta por sus padres. Ellos refieren que su hijo presenta desde hace aproximadamente 2 meses, deposiciones blandas, a veces semilíquidas, muy frecuentes, y que en ocasiones sobrepasan el pañal. La primera deposición de la mañana es muy abundante y las subsiguientes un poco menos. Siempre son diurnas y a veces tienen restos de alimentos sin digerir. Hasta ahora no ha visto sangre o moco en la materia fecal y no parece que Lautaro se queje de dolor abdominal. Es un niño sano que sólo ha presentado dos episodios catarrales resueltos favorablemente. Tiene

buena predisposición para alimentarse. Cuando tiene sed, le ofrecen agua y jugo de naranja o manzana, que suele tomar en cantidad.

Examen físico: Niño en buen estado general, afebril. Lautaro está asustado y llora durante la entrevista. Peso 12.0 kg (Pc 25-50). Talla 86.0 cm (Pc 25-50), manteniendo sus percentilos habituales. Normohidratado. Mucosas rosadas y húmedas. Frecuencia respiratoria 25 por minuto. Frecuencia cardíaca: 90 por minuto. Buena entrada de aire en ambos campos pulmonares, sin ruidos agregados. Auscultación cardíaca: se escuchan dos ruidos en los cuatro focos. Silencios libres. Abdomen blando, depresible, levemente globuloso, indoloro a la palpación. Se palpa hígado a 1.5 cm bajo el reborde costal derecho.

De acuerdo a su hipótesis diagnóstica, cuáles son las conductas más adecuadas? (marque hasta tres opciones)

Seleccione una o más de una:

- A. Informar a los padres que se trata de un proceso benigno y autolimitado.
- B. Efectuar interconsulta con gastroenterología infantil.
- C. Investigar funcionalidad de hígado y vesícula biliar.
- D. Indicar dieta de prueba sin gluten.
- E. Efectuar tratamiento empírico para Giardia lamblia.
- F. Suspender las bebidas con carbohidratos.
- G. Suprimir los alimentos que se observan sin digerir en las deposiciones.
- H. Indicar dieta variada con aumento del contenido graso.

17. Sofía es una niña de 3 años que es llevada a consulta por sus padres por presentar desde hace 3 meses, deposiciones blandas, fétidas, acompañadas de dolor abdominal intermitente. Los padres refieren que su hija está desde hace un tiempo quejosa, irritable, y no tiene el apetito acostumbrado. Destacan, asimismo, que le notan el abdomen distendido y que está más delgada. Examen físico: Niña en regular estado general. Mucosas levemente pálidas, húmedas. Cabello que se desprende con cierta facilidad, piel seca, uñas con estrías. Peso: 10.0 kg (percentilo 10). Talla 93.0 cm (percentilo 25). Frecuencia cardíaca: 110 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria: 25 respiraciones por minuto. Abdomen globuloso, timpánico en hemiabdomen superior y mate en hemiabdomen inferior. Ruidos hidroaéreos presentes.

Ud. presume que Sofía puede padecer enfermedad celíaca. Ante esta situación, cuáles son las acciones más adecuadas ? (marque hasta tres opciones).

Seleccione una o más de una:

- A. Indicar sin demora régimen libre de gluten.
- B. Indicar biopsia de intestino delgado aún si no se cuenta con el informe de la serología.
- C. Determinar niveles plasmáticos de las vitaminas liposolubles antes de iniciar el régimen libre de gluten.

- D. Indicar régimen libre de gluten solo después de conocer el informe de la biopsia del intestino delgado
- E. Solicitar IgA antitransglutaminasa
- F. Corregir el deterioro nutricional antes de indicar la biopsia del intestino delgado.
- G. Confirmar diagnóstico si se observa mejoría al haber iniciado precozmente el régimen libre de gluten.
- H. Demorar la biopsia de intestino delgado si no es posible determinar previamente IgA antitransglutaminasa.

18. Ud está evaluando a Marco, de 6 años de edad. Sus padres lo consultaron oportunamente por baja talla y episodios ocasionales de dolor abdominal y deposiciones abundantes. Frente a la posibilidad que Marco pueda padecer enfermedad celíaca.

¿Cuáles son las conductas o afirmaciones correctas? (marque Hasta tres opciones):

Seleccione una o más de una

- A. Si se comprueba que Marco tiene enfermedad celiaca, debe descartarse su presencia únicamente en sus hermanos
- B. Es indispensable determinar los antígenos HLA para certificar el diagnóstico.
- C. Comenzar una dieta sin gluten y verificar una mejoría clínica hace innecesarios otros estudios para confirmar el diagnóstico.
- D. La biopsia de intestino delgado sólo se indica si no hay mejoría clínica con la dieta sin gluten
- E. La positividad de IgA antitransglutaminasa es suficiente para confirmar el diagnóstico.
- F. De confirmarse el diagnóstico, podrían requerirse estudios para descartar enfermedades autoinmunes.
- G. No debería comenzar la dieta libre de gluten hasta no conocer el resultado de la biopsia.
- H. Podría ser necesario realizar un catastro a todo el grupo familiar si se comprueba el diagnóstico

19. Tamara, de 3 años de edad es traída a la consulta por sus padres por presentar desde hace 48 horas dolor abdominal de tipo cólico y deposiciones líquidas frecuentes. No presentó vómitos. Es una niña sana, con buen desarrollo ponderoestatural y sin antecedentes patológicos destacables. Al examen físico, Tamara no presenta signos de deshidratación por lo que Ud. decide enviarla a su domicilio con pautas de alarma y volver a controlarla posteriormente.

Cuáles son las recomendaciones más apropiadas respecto a las pautas alimentarias que debe seguir Tamara? (marque hasta tres opciones)

- A. Indicar crema de bismuto.
- B. Indicar leche deslactosada hasta que se normalicen las deposiciones.
- C. Indicar té negro azucarado cuando tenga sed.

- D. Permitir que coma polenta y arroz.
- E. Evitar que coma pan y galletitas de agua.
- F. Permitir que coma carne de vaca y de pollo.
- G. Administrar abundantes líquidos luego de cada deposición.
- H. Indicar gaseosas tipo "Seven Up" sin gas por cucharitas.

21. Jacinto de 8 meses de edad es traído por sus padres al servicio de emergencias por haber presentado vómitos alimentarios y lo ha notado muy decaído en las últimas horas. Se despertó a las 4 de la madrugada llorando, a los pocos minutos se durmió, y en las horas siguientes se despertó varias veces llorando. Intentó alimentarlo, pero no quiso comer y solo tomó algo de leche. Parece tranquilizarse hasta que repentinamente, vuelve a despertar llorando y encogiéndose las piernas. La última deposición, antes de que se iniciaran los vómitos, había sido de características normales. En las últimas 2 horas Jacinto vomitó tres o cuatro veces, el último era verdoso. La última emisión de orina fue hace 4 horas. Examen físico: Temperatura: 36,6 °C. Frecuencia cardíaca: 130 por minuto, Frecuencia respiratoria: 24 por minuto; Tensión arterial 85/55 mmHG. Está irritable durante el examen con sensorio alternante. Auscultación pulmonar: Buena entrada de aire en ambos campos pulmonares, sin ruidos agregados. Saturación de oxígeno: 98% con aire ambiental. Abdomen blando, depresible, más tenso en flanco derecho. No se perciben ruidos en fosa ilíaca derecha. Resto del examen físico sin particularidades.

Teniendo en cuenta los datos presentados, ¿cuáles son las conductas más adecuadas? (Marque hasta tres opciones)

Seleccione una o más de una:

- A. Realizar punción lumbar.
- B. Indicar hidratación oral y citar para control en 6 horas.
- C. Solicitar ecografía abdominal.
- D. Indicar ceftriaxona por vía endovenosa.
- E. Indicar metoclopramida.
- F. Internar a Jacinto y colocar acceso venoso.
- G. Solicitar interconsulta con Neurología infantil.
- H. Solicitar evaluación por cirugía pediátrica.

22. Hace 15 días, Joaquín de 1 año y 10 meses concurre con su mamá a la consulta con su médico de cabecera por presentar dolor abdominal y deposiciones desligadas desde hacía un tiempo atrás.

Con los resultados del laboratorio y ante la ausencia del médico de cabecera, lo consultan. Laboratorio: Leucócitos 8500/dl. N35 L60 M4 E1 B0 Frotis de sangre periférica: glóbulos rojos pequeños, hipopigmentados. Conteo de reticulocitos disminuido.

Coprocultivo: Escherichia coli no enteropatógena.

Test de Graham: se observan huevos de oxiuros y quistes de guardía lamblia.

Proteinograma electroforético: albúmina 2,9 gr%, a1: 0,30gr%, a2: 0,60 gr%, b: 0,70 gr%, g

0.8 gr%. Anticuerpo antitransglutaminasa: 1/400.

Rx de carpo mano izquierda: informa edad ósea 1

- A. El valor del anticuerpo antitransglutaminasa es normal
- B. Joaquín debe recibir tratamiento para oxiurus vermicularis con mebendazol
- C. La descripción del frotis de sangre periférico es típica de una anemia ferropénica
- D. El informe de la Rx de carpo podría indicar retraso de la maduración ósea.
- E. Joaquín debe recibir tratamiento para guardia lamblia con metronidazol
- F. Los valores de las inmunoglobulinas se encuentran en valores anormales
- G. Los valores de la albúmina se encuentran en valores normales.
- H. La presencia de Escherichia coli no enteropatógena se asocia a trastornos digestivos y requiere medicación antibiótica.

23. Ciro de 3 años de edad, sin antecedentes patológicos de importancia, con vacunas completas para la edad, residente en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, vivienda familiar precaria de un solo ambiente con agua de pozo y baño con descarga. Es el 6to hijo de 7 hermanos, el padre, cartonero recoge desechos de los barrios lindantes y a veces Ciro lo acompaña. En el último mes Ciro comienza con un cuadro clínico de distensión y dolor abdominal asociado a geofagia con vómitos alimentarios esporádicos y tos.

Al momento de su ingreso, el paciente presentaba los siguientes signos vitales: presión arterial 96/71 mm Hg; frecuencia cardíaca 110 latidos/minuto; frecuencia respiratoria 25 respiraciones/ minuto; temperatura 36,2°C; SpO2 95% AA. Peso 13 kg, talla 95 cm. Palidez mucocutánea, buena entrada de aire bilateral, se auscultan rales subcrepitantes bibasales, abdomen globuloso, doloroso a la palpación profunda, a predominio de la región peri umbilical, sin reacción peritoneal, ruidos hidroaéreos normales.

**¿Cuáles de las siguientes conductas diagnósticas iniciales son las más adecuadas?
(Marque hasta 3 opciones)**

Seleccione una o más de una:

- A. Solicitar coproparasitológico seriado, en fresco y test de graham.
- B. Realizar endoscopia digestiva con toma de biopsias.
- C. Solicitar sangre oculta en materia fecal.
- D. Solicitar ecografía de abdomen.
- E. Solicitar radiografía de abdomen de pie y tórax.
- F. Solicita anticuerpos Ig A transglutaminasa y determinación de IgA sérica.
- G. Solicitar hemograma completo.
- H. Indicar colon por enema.

24. Los padres de Vicente, de 18 meses de edad, lo consultan porque desde hace más de 3 meses presenta deposiciones diarreicas. En el último mes, lo nota decaído, adelgazado y con el abdomen distendido. Se alimenta habitualmente con leche entera y dieta mixta

variada. Su apetito ha disminuido bastante y llora con frecuencia. Había consultado antes por igual motivo en un centro de salud donde le indicaron dieta baja en carbohidratos a la que respondió parcialmente. Examen físico. Niño en regular estado general, decaído, pálido. Peso 9.200 gramos (Pc 3-10). Talla: 80.0 cm (Pc 25). Temperatura axilar: 37°C. Abdomen globuloso, depresible e indoloro a la palpación. En posición erecta, se percibe matidez a la percusión en su mitad inferior. Tejido celular subcutáneo disminuido. Resto del examen físico sin datos anormales.

En relación a los datos mencionados, ¿cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? (marque hasta tres opciones)

Seleccione una o más de una:

- A. Solicitar radiografía de muñeca para edad ósea.
- B. Solicitar parasitológico seriado y test de Graham.**
- C. Solicitar coprocultivo y antibiograma.
- D. Indicar sulfato ferroso por vía oral y hemograma de control en un mes.
- E. Efectuar registra alimentario y aporte calórico.
- F. Solicitar proteinograma electroforético e Inmunoglobulinas**
- G. Solicitar hemograma y frotis.**
- H. Indicar dieta libre de gluten y evaluar respuesta en 1 mes

9. DIGESTIVO/QX + URO

1. Kiara de 14 años de edad , refiere dolor en hemiabdomen derecho de características cólicas, de 16 horas de evolución, se encuentra inapetente, presentó 2 deposiciones desligadas, escasas en el día de la consulta, refiere disuria y tuvo 3 vómitos en la última hora. En el momento del examen físico, refiere un dolor moderado.

La paciente se encuentra en regular estado general, temperatura 38,3oC. La palpación abdominal muestra un abdomen levemente distendido, dolor generalizado a predominio en fosa ilíaca derecha con compresión dolorosa. Puño percusión lumbar bilateral negativa. El resto de la exploración física es normal. Antecedentes: menarca a los 12 años, ciclos irregulares, FUM hace 2 semanas aproximadamente. inicio de relaciones sexuales hace 1 año, refiere cuidarse casi siempre con preservativo.

Pregunta: De acuerdo a su diagnóstico presuntivo ¿cuáles son las conductas iniciales más apropiadas? (Marque hasta 4 opciones)

- A. Realizar prueba de tolerancia oral.
- B. Ecografía abdominal y ginecológica**
- C. Indicar metoclopramida

- D. Examen ginecológico
- E. Orina completa y urocultivo
- F. Hemograma, PCR, 2 hemocultivos, urea, creatinina.
- G. Hemograma, PCR, coagulograma, BHCG
- H. Solicitar cultivo de flujo vaginal.
- I. Coprocultivo y parasitológico en fresco y seriado de materia fecal.
- J. Tomografía abdomino-pélvica.

2. Concorre al control en salud, Ignacio de 1 mes de edad. La madre le pregunta a Ud. sobre la importancia de la hernia en el ombligo y el aumento de tamaño de la bolsa escrotal. Al examinar a Ignacio Ud constata: Hernia umbilical con anillo amplio. Bolsa escrotal con mayor tamaño del lado derecho, mientras el izquierdo impresiona normal. No se observa tumefacción compatible con hernia inguinal. La transiluminación de la bolsa escrotal derecha es positiva.

Ante estos hallazgos ¿Qué le informa a la mamá de Ignacio (Marque hasta 3 opciones)

- A. Es preferible no corregir quirúrgicamente la hernia umbilical porque es alto el riesgo de recurrencia postoperatoria.
- B. Es necesario realizar una consulta urgente con Cirugía infantil.
- C. El hidrocele podría ser un factor condicionante de torsión testicular.
- D. El hidrocele se reducirá de modo progresivo durante el transcurso del primer año.
- E. Es común que el hidrocele comunicante varíe de tamaño durante el día.
- F. Es conveniente efectuar la corrección quirúrgica del hidrocele antes de los dos años de edad.
- G. La hernia umbilical que presenta Ignacio, podría requerir corrección quirúrgica sólo por razones estéticas.
- H. Es útil ocluir precozmente la hernia umbilical de Ignacio con moneda y tela adhesiva.

5. Concurren a la guardia de un hospital del conurbano bonaerense Rocío con su hijo, Jonas, de 5 meses de edad, por presentar vómitos copiosos y reiterados de 12 horas de evolución, sin fiebre ni diarrea. No refiere antecedentes personales de importancia.

Vacunación completa para la edad.

Al examen físico, el niño se encuentra en regular estado general, con mucosas semihúmedas, llanto sin lágrimas, relleno capilar menor de 2 segundos, buena turgencia de la piel y diuresis disminuida. Presenta buena entrada de aire bilateral, sin ruidos agregados, frecuencia respiratoria 30/min, soplo sistólico efectivo en mesocardio, frecuencia cardíaca 140/min. Abdomen globoso, con dolor a la palpación profunda, escasos ruidos hidro-aéreos. Tumorción en región inguino-escrotal derecha.

Usted decide solicitar exámenes de laboratorio y realizar observación en guardia.

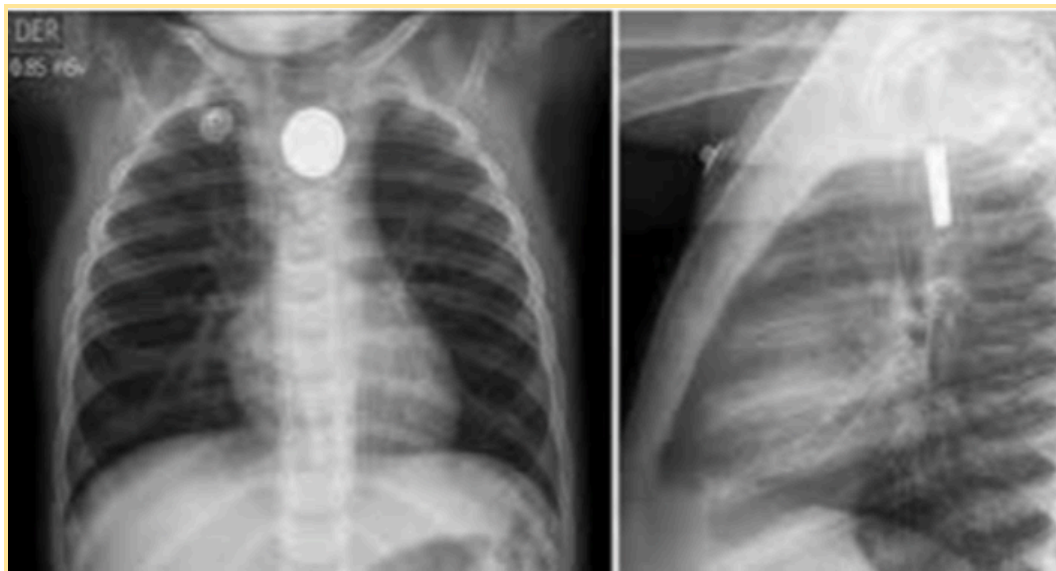
Resultados: Glóbulos blancos 7000/mm³, 75% de PMN, urea 42mg %, glucemia 80 mg%, ionograma: Na 138 mEq/l y K 4,2 mEq/l.

Con los datos obtenidos, ¿cuáles son las conductas más adecuadas para el abordaje de este caso? Marque 3 opciones

- A. Expansión con solución fisiológica.
- B. Solicitar radiografía de abdomen de pie y ecografía abdominal.
- C. Realizar TAC abdominal
- D. Indicar internación e hidratación parenteral
- E. Solicitar interconsulta con Cirugía
- F. Solicitar Rx de tórax
- G. Indicar sales de rehidratación oral y control en 6 horas
- H. Solicitar interconsulta con cardiología.

6. Joaquín de 2 años que concurre a la salita cercana a su domicilio donde Ud. trabaja junto a su madre, quien refiere que el niño ha ingerido “algo” que estaba en el suelo. La madre comenta que Joaquín es un niño muy inquieto.

Joaquín no tiene antecedentes de enfermedades previas, al examen físico, se ausculta buena entrada de aire bilateral y presenta semiología abdominal normal. Ud. decide realizar estas radiografías y verifica la existencia de un cuerpo extraño radiopaco.



Luego de la interpretación de la imagen radiológica, ¿cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? Marcar hasta 3 opciones.

Seleccione una o más de una:

- A. Indicar dieta blanda
- B. Realizar seguimiento ambulatorio y control radiológico en 24hs
- C. Indicar internación y aguardar la progresión espontánea del cuerpo extraño
- D. Solicitar interconsulta urgente con endoscopia digestiva infantil
- E. Realizar seguimiento ambulatorio con pediatra de cabecera
- F. Deriva de manera urgente a centro de alta complejidad
- G. Solicitar fibroendoscopia respiratoria de urgencia
- H. Solicitar evaluación por gastroenterología infantil
- I. Realizar maniobra de Heimlich
- J. Indicar ayuno e hidratación parenteral

7. Se presenta en la guardia Fausto, de 12 años de edad, sin antecedentes patológicos de importancia, refiriendo dolor de 1 hora de evolución en la región escrotal derecha. En la exploración física se observa tumefacción dolorosa del escroto y testículo derecho, con reflejo cremastérico negativo. El examen físico es muy dificultoso debido al dolor referido por el paciente.

Dado el cuadro clínico de Fausto, qué conductas decide adoptar? Marcar hasta 2 opciones.

- A. Solicitar centellograma testicular
- B. Solicitar ecografía Doppler testicular diferida
- C. Realizar ecografía testicular con Doppler vascular urgente
- D. Indicar reposo y analgésicos por vía oral
- E. Solicitar orina completa y tratamiento con cefalexina
- F. Interconsulta inmediata a cirugía pediátrica
- G. Observación en guardia durante 6 horas
- H. Control ambulatorio en 24 horas

9. Los padres de Tomás, de 8 meses de edad, concurren al servicio de emergencias refiriendo que su hijo comenzó con dolor abdominal intermitente y vómitos, desde hace aproximadamente 6 horas. Se realizan estudios que incluyen una ecografía abdominal en la que se evidencia imagen en escarapela en región de fosa ilíaca derecha.

Al revisar la historia clínica de Tomás, ¿cuáles de los siguientes datos clínicos es más probable que se hayan registrado? (Marque hasta tres opciones).

- A. Las deposiciones fueron desligadas con presencia de moco y sangre.
- B. La madre refiere que por momentos lo ha notado mas somnoliento.
- C. Ha presentado vómitos biliosos.
- D. En la radiografía no se visualizaba claramente la sombra del psoas derecho.
- E. Presentó un episodio de hematemesis.
- F. Ha tenido fiebre mayor a 39°C.
- G. Al palpar el abdomen de Tomás se percibía una tumoración en epigastrio.
- H. Padeció una infección reciente de vías aéreas superiores.

10. Romina, de 4 años de edad es traída por su madre a la guardia por presentar intenso dolor abdominal, que comenzó 24 horas antes como una molestia leve pero que fue aumentando en intensidad. No había presentado anteriormente episodios de dolor abdominal y durante el interrogatorio no hay evidencia de transgresiones alimentarias. Un mes atrás recibió mebendazol por haber presentado oxiuriasis. Examen físico: regular estado general, quejosa, irritable, se resiste a ser examinada. Peso y talla en percentilos 50. T°C: 37,80 Frecuencia cardíaca 140 por minuto. Frecuencia respiratoria 28 por minuto. Mucosas semihúmedas. Abdomen doloroso con aumento de la tensión, principalmente en hemiabdomen derecho, discretamente distendido,

descompresión dolorosa. No se palpa visceromegalias. Resto del examen sin particularidades.

Durante el examen físico tuvo una deposición diarreica escasa y una micción de poca cantidad dolorosa. Con los datos hasta aquí mencionados Ud.

¿Cuál es la conducta inicial más adecuada? (marque hasta tres opciones):

- A. Solicitar tomografía de abdomen
- B. Indicar nuevo esquema de tratamiento antiparasitario.
- C. Indicar antiespasmódico inyectable y dieta blanda por 72 horas.
- D. Indicar dieta líquida fraccionada.
- E. Controlar la evolución a las 12 horas.
- F. Internar a Romina.
- G. Solicitar ecografía abdominal.
- H. Solicitar evaluación por cirugía infantil

11. Alejo de 8 meses de edad es traído por sus padres al servicio de emergencias por haber presentado vómitos alimentarios y lo ha notado muy decaído en las últimas horas. Se despertó a las 4 de la madrugada llorando, a los pocos minutos se durmió, y en las horas siguientes se despertó varias veces llorando. Intentó alimentarlo, pero no quiso comer y solo tomó algo de leche. Parece tranquilizarse hasta que repentinamente, vuelve a despertar llorando y encogiendo las piernas. La última deposición, antes de que se iniciaran los vómitos, había sido de características normales. En las últimas 2 horas Alejo vomitó tres o cuatro veces, el último era verdoso. La última emisión de orina fue hace 4 horas. Examen físico: Temperatura: 36,6 °C Frecuencia cardíaca: 130 por minuto, Frecuencia respiratoria: 24 por minuto; Tensión arterial 85/55 mmHG. Está irritable durante el examen con sensorio alternante. Auscultación pulmonar: Buena entrada de aire en ambos campos pulmonares, sin ruidos agregados. Saturación de oxígeno: 98% con aire ambiental Abdomen blando, depresible, más tenso en flanco derecho. No se perciben ruidos en fosa iliaca derecha. Resto del examen físico sin particularidades.

Teniendo en cuenta los datos presentados, ¿cuáles son las conductas más adecuadas? (Marque hasta tres opciones)

Seleccione una o más de una

- A. Indicar hidratación oral y citar para control en 6 horas.
- B. Indicar ceftriaxona por vía endovenosa.
- C. Internar a Alejo y colocar acceso venoso.
- D. Indicar metoclopramida
- E. Solicitar ecografía abdominal
- F. Solicitar evaluación por cirugía pediátrica.
- G. Realizar punción lumbar.
- H. Solicitar interconsulta con Neurología infantil

10. ENDOCRINO + DBT + OBESIDAD

1. Licia de 12 años de edad es llevada por sus padres al servicio de emergencias por presentar decaimiento general y vómitos en las últimas 48 horas. Los padres refieren que hace 20 días consultaron a su pediatra porque Licia se despertaba a la noche a orinar. Refieren que su hija, tiene más sed de lo habitual y tiene más apetito.

Examen físico: Niña en regular estado general. Piel y mucosas secas, enoftalmos, sensorio alternante. Temperatura: 37,5°C. Presión arterial 100/60 mmHg. Frecuencia cardíaca: 120 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria 30 por minuto.

Se le efectúan los siguientes exámenes complementarios: Glucemia 480 mg/dl. pH 7,20. pCO₂ 25 mMol/l, Bicarbonato: 6,7 mMol/l, Na: 131 mEq/l, K: 3,7 mEq/l. Cetonuria y glucosuria +++.

Con los datos presentados, ¿cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? (marque hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

- A. Indicar bicarbonato de sodio.
- B. Administrar corrección con cloruro de sodio.
- C. Indicar expansión con dextrosa al 5%.
- D. Administrar insulina NPH por vía intramuscular.
- E. Indicar expansión con solución fisiológica.
- F. Internar a Licia.
- G. Observar y tratar a Licia en la guardia.
- H. Administrar insulina corriente en infusión continua endovenosa.

2. En la consulta de control en salud de Rafael, un adolescente de 14 años de edad, usted registra los siguientes datos: Talla 165 cm (Pc 75-90), Peso 75 kg (Pc mayor a 97), IMC: 27 (+ 2 Puntaje Z), Tensión Arterial 115/70 mm/Hg (menor al Pc 90).

De la anamnesis surge que el padre de 42 años de edad y una tía paterna presentaron, hace un año, en un laboratorio de rutina, valores elevados de colesterol. Al examen físico: tejido celular subcutáneo aumentado, acantosis nigricans en cuello y axilas, se palpa borde hepático de consistencia firme, a 2,5cm por debajo del reborde costal.

¿Qué estudios indica? Marque 3 opciones

- A. ECG y ergometría
- B. En ayunas hepatograma, colesterolemia, trigliceridemia y glucemia.

- C. Monitoreo ambulatorio de la presión arterial durante 24 hs
- D. Uremia y creatininemia
- E. Interconsulta con Nutrición
- F. Ecografía abdominal
- G. Insulinemia y prueba de tolerancia oral a la glucosa
- H. Dosaje de hormonas tiroideas

11. RENAL

1. Lisandro, de 5 años de edad, es dado de alta, luego de haber estado internado una semana en el hospital con diagnóstico de glomerulonefritis aguda postestreptocócica. Los padres de Lisandro quieren conversar con usted acerca del pronóstico y los controles posteriores que deben realizarle a su hijo.

¿Cuáles de los siguientes enunciados considera que son los más correctos? (Puede marcar hasta tres opciones)

- A. Es conveniente que al menos durante el primer mes, se restrinja la actividad física.
- B. Debe continuar con profilaxis antibiótica por al menos 6 semanas.
- C. Dentro de las 8 semanas, se tomarán muestras de sangre para controlar los niveles de C3.
- D. Es probable que en pocos días su presión arterial sea la normal para la edad.
- E. Debe recibir diuréticos hasta que desaparezcan por completo los edemas.
- F. La pérdida de sangre por la orina es uno de los parámetros que se han considerado para otorgar el alta.
- G. La recuperación posterior al episodio es habitualmente completa.
- H. Dentro de los tres primeros meses luego del alta, requerirá una biopsia renal.

SANGRE + ONCO

1. Fiorella, de 6 años, es llevada por sus padres a control luego de haber efectuado una consulta previa un mes atrás. En dicha oportunidad, el motivo de consulta había sido el poco apetito y la ingesta reducida de alimentos, mayormente fideos, pan y galletitas. Por esta razón se le habían efectuado una serie de estudios, en los que se informaba que Fiorella estaba levemente anémica (tenía una hemoglobina de 11.3 gr/dl), por lo que se decidió indicarle hierro por vía oral y regresar en 3 meses para evaluar la respuesta al tratamiento. La madre refiere que actualmente su dieta es mas variada. Ello ocurre hace

una semana, momento en que se solicitan nuevos exámenes complementarios, cuyos resultados se detallan más abajo.

Antecedentes personales: Fiorella es una niña por lo general sana, concurre a primer grado con buen rendimiento escolar.

Examen físico: Fiorella se encuentra en buen estado general. Peso: 17,0 kg. (Pc 25), Talla 114,0 cm (Pc.25-50), mucosas húmedas y coloreadas. Aparato cardiovascular: se auscultan dos ruidos en los cuatro focos. Silencios libres. TA: 90/55 mmHg. Frecuencia cardíaca: 90 latidos por minuto. Abdomen blando, depresible, no se palpan visceromegalias. Resto del examen físico sin particularidades.

Los nuevos estudios que se le han solicitado a Fiorella muestran: Hb 11.8 gr/dl hay que subir 1g/mes., Hematocrito 36%. Volumen Corpuscular Medio 60 femtolitros; Hemoglobina Corpuscular Media 24 picogramos. Reticulocitos 1.2%. Bilirrubina total: 1.2 mg/dl., Bilirrubina indirecta: 0.9 mg/dl. Bilirrubina directa: 0.3 mg/ dl.

Con los datos disponibles, ¿Cuáles son las conductas más adecuadas a seguir? (marque hasta tres opciones)

- A. Solicitar sangre oculta en materia fecal.
- B. Solicitar ferremia, ferritina séricas y saturación de transferrina.**
- C. Continuar tratamiento con hierro por vía oral y controlar nuevamente en un mes.
- D. Suspender tratamiento con hierro por vía oral y administrar por vía parenteral.
- E. Considerar adecuada la respuesta al tratamiento con hierro y evaluar nuevamente en seis meses.
- F. Investigar antecedentes de anemia en el grupo familiar.**
- G. Solicitar electroforesis de hemoglobina.**
- H. Complementar la dieta con alimentos ricos en hierro.

2. Se encuentra evaluando por primera vez a Mateo de 4 años de edad, que concurre para control en salud. La madre refiere que es un niño sano, aunque le llama la atención que en el último tiempo se cansa con facilidad cuando corre, lo cual le dificulta el juego con el resto de los niños de su edad. No surgen otros antecedentes familiares ni personales de relevancia.

Mateo es un niño eutrófico, con peso y talla en percentilo 25 para su edad. Al examen físico se encuentra algo pálido, taquicárdico, taquipneico, con precordio activo y pulsos saltones. Se ausculta un soplo sistólico continuo, con máxima intensidad en sístole y disminución en la telediástole, audible preferentemente en la región infraclavicular izquierda y en el borde paraesternal superior izquierdo. A nivel abdominal se palpa ligera hepatomegalia. El resto del examen físico no presenta otras particularidades.

Pregunta: En base a su diagnóstico presuntivo ¿qué estudios complementarios iniciales son de mayor utilidad? (Marque hasta 3 opciones).

- A. Ionograma y estado ácido-base.
- B. Hemograma.
- C. Ecocardiograma.

- D. Teleradiografía de tórax.
- E. Espirometría.
- F. Angiotomografía de tórax.
- G. Ecografía abdominal.
- H. Electrocardiograma.
- I. No es necesario solicitar estudios de imágenes.
- J. Hepatograma, urea, creatinina y ácido úrico.

3. Ariel de 4 años de edad concurre con su madre a la consulta, por aparición reciente de lesiones puntiformes eritematosas que no desaparecen a la presión y lesiones violáceas planas en cara, tronco y extremidades

No refiere antecedentes de traumatismos, (aunque su madre dice que habitualmente es muy inquieto), no tiene antecedentes patológicos, ni ingesta reciente de medicamentos.

De sus antecedentes personales: nació de término con peso adecuado para la edad gestacional, parto vaginal sin complicaciones.

Vacunas refiere que recibió hasta el año de edad, no trae carnet. Padres separados, tiene una hermana adolescente con sobrepeso. Tiene mascotas: dos gatos.

EXAMEN FÍSICO: se encuentra afebril (temperatura de 36 grados C), con decaimiento general. Se constatan petequias y hematomas en cara, tronco y extremidades. Presenta petequias en paladar duro sin objetivarse signos de sangrado activo.

Se decide realizar Hemograma que informa: hemoglobinemia 12,4 g/dl , Leucocitos 6.700/mm³, (con fórmula a predominio linfocitario) y plaquetas 45.000/mm³.

En función del diagnóstico presuntivo, ¿cuáles son las conductas más apropiadas? Marque hasta 3 opciones.

- A. Solicitar TAC de cerebro urgente.
- B. Solicitar punción de médula ósea.**
- C. Asumir por el momento como diagnóstico presuntivo Púrpura Trombocitopenia inmune.
- D. Internar al paciente.**
- E. Solicitar coagulograma, sedimento urinario, serología para EBV, CMV, parvovirus B19, Hepatitis B, C y HIV.**
- F. Solicitar coagulograma, determinación de IgA y ASTO.
- G. Asumir por el momento como diagnóstico presuntivo Púrpura de Schonlein Henoch.
- H. Solicitar consulta con Servicio Social.
- I. Solicitar serología para Bartonella Henselae.
- J. Control ambulatorio en 24 horas.

4. Lorenzo de 4 años de edad es traído por la madre a la consulta, por aparición reciente de lesiones eritematosas en cara, tronco y extremidades. No refiere antecedentes de traumatismos, (aunque su madre dice que habitualmente él es muy inquieto), no tiene

antecedentes patológicos, ni ingesta reciente de medicamentos. No recibió vacunas recientemente.

Examen físico: se encuentra afebril (temperatura de 36 grados C), con decaimiento general. Se constatan lesiones eritematosas en cara, paladar, tronco y extremidades que no desaparecen a la vitropresión. No se constata visceromegalias. Se realiza hemograma que informa: hemoglobinemia 12,4 g/dl, Leucocitos 6.700/ mm³, (con fórmula a predominio linfocitario) y plaquetas 10.000/mm³. Frotis sin blastos. Tiempo de protrombina 80%, APTT 35 segundos. Prueba de Coombs negativa y serologías virales pendientes.

Además de internar al paciente y en función de su diagnóstico elija las opciones que son más adecuadas. (Marque hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

- A. Solicitar consulta con el Servicio Social.
- B. Indicar transfusión de plaquetas.
- C. Solicita interconsulta con hematología.**
- D. Explicar que la enfermedad tiene baja chance de responder al tratamiento inicial.
- E. Indicar gammaglobulina humana o pulsos de corticoides EV
- F. Solicitar interconsulta a cirugía para esplenectomía de urgencia.
- G. Solicitar punción de médula ósea.**
- H. Explicar que la enfermedad tiene alta chance de responder al tratamiento inicial.**

12. TRAUMATO

1. Concorre a la guardia José de 12 años de edad que consulta por dolor exquisito y puntual en una zona ubicada en el 1/ 3 inferior del muslo derecho e impotencia funcional y fiebre durante las últimas 48 horas. Como antecedente refiere haber sufrido un traumatismo hace 7 días jugando al fútbol. En el examen físico se observa área de tumefacción con una lesión en piel del 1/3 inferior del muslo derecho, cubierta actualmente por una costra hemática, evaluación de la articulación de la rodilla normal. Laboratorio: Hemograma: 16800/mm³ leucocitos (80% NS 35-60, 3% NC 0-5%, 10% L, 7% M), hemoglobina 12,4 gr/dl, plaquetas 550.000/mm³, eritrosedimentación 80 mm/h, PCR 60 mg/l. Radiografía de ambos miembros inferiores comparativa sin lesiones óseas.

Pregunta: Además de indicar analgesia, de acuerdo a su diagnóstico presuntivo, cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? (Marque hasta 3 opciones)

- A. Intención, 2 hemocultivos y tratamiento antibiótico endovenoso**
- B. Control ambulatorio en 48 hs y tratamiento con cefalexina, vía oral
- C. Inmovilización, analgesia y control ambulatorio en 48 horas
- D. Solicitar resonancia magnética de miembro.**

- E. Solicitar ecografía de partes blandas.
- F. Solicitar tomografía computada del miembro.
- G. Toma de cultivo por piel sana de la costra.
- H. Solicitar centellograma corporal total.
- I. Exploración quirúrgica de urgencia.
- J. Solicitar CPK y Aldolasa

2. Dana, de 20 meses es llevada por sus padres, al servicio de Urgencias por cojera de 6 días de evolución. En las últimas 48 horas presenta fiebre de 38oC y tumefacción de rodilla derecha que se acompaña de dolor con el apoyo. Examen físico: Buen estado general, normohidratada. Peso: 11.700 gramos. Temperatura axilar 38oC. Se observa tumefacción y calor en rodilla derecha, dolor a la palpación y a la movilización articular, choque rotuliano presente. Limitación a la flexo-extensión, abducción, aducción, rotación interna y externa de la rodilla derecha. Cadera derecha con movilidad activa y pasiva conservadas.

**Ante este cuadro clínico, ¿cuáles son las conductas inmediatas más apropiadas?
(Marque hasta 3 opciones)**

Seleccione una o más de una

- A. Solicitar ecografía de rodilla derecha.
- B. Realizar toma de muestras para hemocultivo e iniciar tratamiento antibiótico luego de conocer germen y sensibilidad.
- C. Solicitar resonancia magnética de rodilla derecha.
- D. Indicar tracción de partes blandas.
- E. Solicitar radiografía frente y perfil de rodilla.
- F. Realizar toma de muestras para hemocultivo e iniciar tratamiento antibiótico empírico.
- G. Indicar inmovilización articular con férula de yeso.
- H. Efectuar artrocentesis y cultivo del líquido articular.

3. Valeria de 2 años de edad, es traída por sus padres al servicio de emergencias. La madre relata que, volviendo del jardín maternal, Valeria tropieza y ella para evitar que se caiga, la toma y levanta fuertemente del brazo izquierdo logrando mantenerla en pie. A partir de allí, la niña se encuentra molesta, llora por momentos y no mueve el brazo.

Examen físico: Niña en buen estado general. Lloro ante el intento de ser examinada. Brazo izquierdo en pronación, pegado al cuerpo, sin movilidad. No se observan hematomas ni crepitaciones a la palpación.

Ante esta situación, las conductas más adecuadas relacionadas con el problema de Valeria son: (Puede marcar hasta tres opciones)

- A. Verificar la movilidad del codo 15 minutos después de haber solucionado el trastorno.

- B. Citar a Valeria para control radiológico en una semana.
- C. Es conveniente evitar la movilización del brazo en las siguientes 24-48 horas.
- D. Sujetar la cabeza del radio con el pulgar y con el codo a 90 grados, supinar la muñeca y flexionar el codo hasta escuchar un crujido.**
- E. Colocar férula que inmovilice la articulación del codo.
- F. Colocar compresas de hielo en el codo durante 15 minutos las primeras 24-48 horas
- G. Informar a los padres que a veces puede repetirse.**
- H. Solicitar radiografía del brazo izquierdo.

5. Consultan los padres de Carla de 3 años de edad porque desde hace 24 horas notan que renguea al caminar, y le duele el miembro inferior derecho al caminar. Refieren que el dolor parece haber aumentado en las últimas horas. No ha tenido fiebre, ni otros síntomas. No refieren antecedentes patológicos de importancia y ha recibido todas las vacunas del calendario oficial.

Examen físico: niña eutrófica, peso y talla en percentilos 50 para edad y sexo. Temperatura axilar 36,5 grados. No se observan lesiones en la piel. Se evidencia limitación a la movilidad de la cadera derecha, con resistencia a los movimientos pasivos. No hay signos de flogosis. Resto del examen sin particularidades.

Usted solicita: radiografía de caderas que fue normal y ecografía que demuestra escasa cantidad de líquido en la articulación de la cadera derecha.

Pregunta: ¿Cuáles de las siguientes conductas son las más adecuadas? (Marque hasta 3 opciones)

- A. Solicitar resonancia magnética de caderas
- B. Solicitar centellograma corporal total
- C. Indicar internación
- D. Indicar analgesia y reposo**
- E. Indicar cefalexina
- F. Citar a control en 24 horas
- G. Solicitar punción de cadera para cultivo y fisicoquímico
- H. Solicitar hemocultivos, hemograma y PCR**
- I. Explicar a los padres que es un proceso infeccioso que requiere intervención inmediata
- J. Explicar que es un probablemente un proceso benigno que requiere observación**

6. Federico, de 2 años y 6 meses de edad, concurre a la consulta con su mamá por padecer cojera de su pierna derecha y dificultad en la marcha.

La mamá comenta que su hijo estaba saltando sobre los charcos de agua de la vereda poco antes de entrar al jardín. Al efectuar el examen físico, Ud. comprueba lo siguiente:

Niño en buen estado general, afebril, pierna derecha en semiflexión, en el intento de abducción, la maniobra ocasiona dolor, en cual no reaparece al extender los miembros inferiores.

¿Cuáles son sus hipótesis iniciales respecto del diagnóstico probable y de las conductas más adecuadas para abordar el problema de Federico? Marque 3 opciones

- A. Indicar inmovilización con yeso durante 4-8 semanas
- B. Luxación de rótula
- C. Indicar Rx de tobillo y rodilla
- D. Indicar Rx comparativa de ambas caderas**
- E. Esguince tobillo
- F. Sinovitis transitoria de cadera**
- G. Indicar reposo y analgésicos por vía oral**
- H. Epifisiolisis proximal del fémur

7. Rodrigo, de 4 años, consulta porque desde hace 6 días presenta hematomas inicialmente eran 2-3 lesiones, pero han aumentado en número y tamaño.

Es un niño de buen carácter y algo travieso, pero no refiere traumatismos especiales en los últimos 6 días. EXAMEN FÍSICO

Rodrigo se encuentra en aceptable estado general, afebril y con desarrollo pondoestatural normal. Presenta discreta palidez cutánea, aunque las mucosas están bien coloreadas. En la piel presenta manchas que tienen el aspecto de hematomas, de tamaño variable, en piernas, caderas y codo derecho, en distinto estadio de evolución, así como petequias puntiformes a lo largo de todo el tronco y algunas en extremidades. La auscultación cardiopulmonar es normal. El abdomen es blando depresible e indoloro sin visceromegalias. No se palpan adenomegalias y el examen neurológico es normal.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

Hematies: 4.100.000/mm³. Hb: 12,4 gr%. Htc 37% Leucocitos: 7200, N 60 (35-60) ; N en cayado 4 (0 - 5); L 28 (25 - 50); M 6; E 2 B 0. Plaquetas: 18.000/mm³

ERS: 14 mm/h

Quick: 80% KPTT: 36 seg.

En relación con el diagnóstico presuntivo de Rodrigo, Ud. responde a diversas inquietudes formuladas por sus padres.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sería la información más adecuada que Ud. les brindaría? Marcar hasta 3 opciones

- B. La posibilidad de que se transforme en una condición crónica es excepcional.
- C. La posibilidad de un desenlace fatal para Rodrigo es excepcional.
- D. Antes de comenzar el tratamiento es imprescindible efectuarle a Rodrigo una punción de médula ósea.**
- E. En general casos como los de Rodrigo reversionen antes de los 6 meses.**
- F. Es frecuente el antecedente de infección viral previa.**

- G. La esplenectomía es una eventualidad probable a la edad de Rodrigo.
- H. Habitualmente el problema de Rodrigo suele presentar antecedentes familiares.
- I. El pronóstico definitivo no depende de la edad de presentación.
- J. Deben realizar interconsulta urgente con oncología infantil.
- K. Superado el cuadro, Rodrigo puede realizar actividad física de contacto con valores normales de hemoglobina.

8. Simón de 7 años concurre con su madre a la salita cercana a su domicilio por presentar dolor puntual en la tibia distal derecha. Consultó hace 1 semana por el mismo problema, le solicitaron radiografía de miembros inferiores que no evidenciaron lesiones óseas. Le indicaron reposo y analgesia, sin mejoría. Durante la anamnesis refiere haber recibido un golpe durante un partido de fútbol hace una semana, que no le impidió continuar jugando.

En el examen físico se observa renguera de su miembro inferior derecho, ligera tumefacción y aumento de la temperatura comparado con el lado contralateral.

Solicita estudios y recibe los siguientes resultados: glóbulos blancos 15.700/mm³, VSG 80 mm/h, PCR 80 mg% . Ecografía de tobillo derecho: con colección subperióstica metafisaria distal de tibia.

En función a su sospecha diagnóstica, cuáles son las conductas iniciales más correctas? (Puede marcar hasta 3 opciones)

- A. Solicitar tomografía de miembros inferiores.
- B. Indicar tratamiento antibiótico parenteral previa toma de muestra para cultivos.**
- C. Derivar a centro de mayor complejidad que cuente con especialista en oncología infantil.
- D. Indicar tratamiento antibiótico vía oral y control ambulatorio.
- E. Solicitar centellograma óseo corporal total.
- F. Solicitar hemograma, coagulograma y ECG.**
- G. Indicar analgesia reglada, frío local y evitar deportes de impacto.
- H. Derivar a centro de mayor complejidad que cuente con especialista en traumatología infantil.**

13. OFTALMO

1. Santino, de 19 meses de vida, concurre a la guardia acompañado por sus padres por presentar el ojo izquierdo hinchado y fiebre (38,4°C) de 1 día de evolución. Refieren haber concurrido por la mañana a otro centro donde le indicaron difenhidramina vía oral y no tuvo mejoría. Según relatan los padres Santino no ha sufrido ningún traumatismo ni le ha picado ningún insecto en la cara recientemente. Notan que come menos y está menos activo. Hace

dos horas le suministraron antitérmicos. La semana anterior tuvo rinorrea, estornudos y tos leve

Antecedentes: crisis de broncoespasmos.

Al examen físicos, se encuentra decaído, febril(38,9°C), frecuencia cardíaca 120 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 24 respiraciones por minuto y tensión arterial 90/50 mmHg. Presenta tumefacción de los párpados superior e inferior izquierdos, eritema y dolor al tacto. No hay quemosis ni exoftalmos evidentes (ver imagen). Los movimientos extraoculares y la agudeza visual se pueden evaluar sólo parcialmente a causa del dolor.

¿Cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? Marque hasta 3 opciones

- A. Solicita hemograma, PCR y 2 hemocultivos
- B. RX de órbita y senos paranasales
- C. Internar e inicia tratamiento EV con ATB y analgésicos
- D. TAC de órbita y senos paranasales
- E. Control ambulatorio en 24h
- F. Amoxicilina por 10 días y control

2. Carlos, de 10 años, es traído a la guardia por sus padres, porque presenta enrojecimiento y tumefacción en ambos párpados del ojo derecho, a predominio del superior, de 48 horas de evolución.

Antecedentes personales: Rinosinusitis alérgica tratada con mometasona en spray nasal hace dos años. Vacunación completa.

Al examen físico: Frecuencia cardíaca: 100 latidos por minuto. Presión arterial 105/68 mm Hg. Frecuencia respiratoria: 16 por minuto. Temperatura axilar 38,8 °C. Luce en buen estado general, colaborador durante la entrevista. Presencia de edema y enrojecimiento palpebral con disminución mayor al 50 % de la hendidura palpebral derecha, afectación conjuntival con hiperemia, edema y secreción, dolor intenso en los movimientos horizontales del ojo derecho. No es posible evaluar la agudeza visual del ojo derecho, la del izquierdo es normal. No se observan otras lesiones en piel.

¿Cuáles son las conductas iniciales en función de su hipótesis diagnóstica? (Puede marcar hasta tres opciones).

Seleccione una o más de una:

- A. Solicitar tomografía de órbita y senos paranasales.
- B. Indicar amoxicilina-clavulánico por vía oral durante 7-10 días.
- C. Indicar prednisona 1 mg/kg/día por vía oral durante 5 días.
- D. Indicar ceftriaxona y clindamicina por vía parenteral.
- E. Internar a Carlos y obtener dos hemocultivos.
- F. Indicar tratamiento ambulatorio por oftalmología en 48 horas.
- G. Indicar colirio oftálmico con tobramicina.

14. ORL + VAS + VAI

1. Concurren a consultorios externos de un hospital general María con su hijo Federico de 6 años de edad por presentar fiebre de 38°C de 48 horas de evolución y dolor de garganta, sin tos, ni rinitis. Ud. completa la anamnesis donde surge que convive con: el padre de 34 años, albañil, la madre de 30 años, ama de casa, una hermana de 2 años cursando un cuadro catarral y los abuelos maternos, ambos hipertensos. La vivienda se encuentra en el conurbano bonaerense, es de material con 2 habitaciones, cohabitación con los padres y hermana, la otra habitación es utilizada por los abuelos maternos. Servicios: pozo ciego, agua de bomba y gas de garrafa. La zona de residencia es anegadiza, las calles son de tierra y dista 5 cuadras de una avenida asfaltada. Federico cursa primer grado con buen rendimiento y adecuada integración con sus nuevos compañeros. Vacunación acorde a la edad por referencia materna. Alimentación completa y variada. Presenta como datos positivos al examen físico: 37,5°C, buen estado general, fauces eritematosas, sin exudado, adenomegalias submaxilares bilaterales de 2cm de diámetro.

Usted le solicita un test rápido para estreptococo que fue positivo y cultivo de fauces.

Pregunta: De acuerdo a los datos obtenidos por anamnesis y examen físico, cuáles son las conductas más adecuadas? (Marque hasta 2 opciones)

- A. Indicar antitérmicos y dieta blanda.
- B. Indicar clindamicina vía oral.
- C. Indicar penicilina vía oral.
- D. Indicar penicilina vía oral si el cultivo es positivo para estreptococo alfa hemolítico.
- E. Indicar Penicilina vía oral si el cultivo es positivo para estreptococo beta hemolítico.
- F. Indicar realización de cultivo de fauces a los convivientes para erradicar la portación.
- G. Indicar penicilina benzatínica intramuscular.
- H. Indicar colutorio bucofaríngeo con anestésico y antibiótico local.
- I. Solicitar ASTO.

2. Sabrina es una inquieta niña de 6 meses de edad. Concorre al Centro de salud por su control periódico. Se trata de una RNT de PAEG (38 semanas y 2560 gr al nacer). No tiene antecedentes patológicos y cumple regularmente con los controles de salud. No concurre a la guardería. Al pesarla y medirla la nota conectada y algo decaída, sin compromiso del estado general. Su peso y su talla se encuentran en percentil 50. Se alimenta con pecho y en ocasiones muy excepcionales le administran biberón de leche de fórmula cuando la madre debe realizar un trámite.

Al examen físico presenta: frecuencia respiratoria de 38 respiraciones por minuto con buena entrada de aire bilateral y sin ruidos agregados, frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, ritmo regular, silencios libres. Abdomen globuloso, indoloro, depresible y blando sin aumento de tamaño del hígado, no se palpa el bazo. Se mantiene sentada con trípode inestable, tiene barrida cubital y balbucea. Al examinar las fauces, revela ampollas y vesículas en paladar blando. Las membranas timpánicas se encuentran normo coloreadas y con triángulo luminoso presente.

La madre relata que tuvo fiebre y le administró paracetamol, y que el hermanito de 4 años fue visto en guardia hace 36 horas y medicado por “anginas” con Amoxicilina. Actualmente persiste febril.

Ante este cuadro, ¿Cuáles son las conductas más adecuadas? (Marque hasta 3 opciones)

- 1) Posponer la administración de vacunas que corresponden.
- 2) Solicitar exudado de fauces para estreptococo beta hemolítico del grupo A.
- 3) Indicar nistatina en gotas 4 veces al día
- 4) Colocar al pecho con más frecuencia.
- 5) Suspender el inicio de incorporación de alimentación complementaria.
- 6) Indicar higiene con agua con bicarbonato de chupetes, tetinas y pezones.
- 7) Indicar amoxicilina 50/mg/kg día vía oral.
- 8) Indicar paracetamol 10/mg/kg (2 gotas/kg) vía oral si repite fiebre hasta 4 dosis diarias.

3. Concorre a la consulta Octavio, de 2 años de edad. La madre refiere que su hijo presenta fiebre desde hace 24 horas, con un registro máximo de 38,2°C. Desde el día anterior recibe amoxicilina oral por consejo de una amiga. Entre otros síntomas, informa que Octavio respira con dificultad, tiene la nariz tapada, abundante secreción mucosa, en ocasiones acuosa y en otras más espesa, y tos seca desde hace 48 horas. Presenta regular actitud alimentaria.

Examen físico: buen estado general. Temperatura 37,8 oC. Se observa rinorrea mucosa, fauces moderadamente congestivas, moco claro en cavum, otoscopía poco valorable por cerumen. Auscultación respiratoria. Buena entrada de aire en ambos campos pulmonares. Frecuencia respiratoria: 30 por minuto.

Con los datos presentados, ¿cuáles son las conductas más adecuadas? (Puede marcar hasta tres opciones)

- A. Efectuar cultivo de fauces.
- B. Suspender amoxicilina.
- C. Indicar gotas nasales descongestivas.
- D. Humidificar secreciones nasales.
- E. Efectuar test rápido para estreptococo beta hemolítico grupo A.
- F. Indicar amoxicilina durante 10 días.
- G. Indicar paracetamol.
- H. Indicar jarabe antitusivo

4. Cesar de 10 años es traído a la guardia por fiebre de 38,5°C de 36 hs de evolución acompañado de cefalea frontal, decaimiento y pérdida de apetito. Refiere obstrucción nasal desde hace 7 días y dolor en región malar, acompañado de rinorrea mucopurulenta anterior y sensación de goteo retrorrenal. La madre refiere que también presenta tos seca predominantemente nocturna. Señala que son frecuentes los cuadros de resfriado de su hijo especialmente en otoño y primavera acompañados de mocos claros, estornudos, picazón de nariz y garganta que trata con antihistamínicos y distintos jarabes para la tos pero a diferencia de esos cuadros ahora lo nota muy decaído.

Al momento del examen físico se percibe halitosis. Rinitis mucopurulenta anterior y posterior, con hipertrofia de cornetes bilateral. Fauces levemente congestivas. Auscultación con buena entrada de aire bilateral roncus sin otros ruidos agregados. Auscultación cardíaca normal Frecuencia cardíaca 90/ minuto. El resto del examen físico es normal .

**Además de indicar analgesia, ¿Cuáles son las conductas iniciales más adecuadas?
(Marque hasta 2**

opciones)

- A. Indicar difenhidramina por 14 días.
- B. Indicar corticoides orales durante 7 días
- C. Indicar amoxicilina durante 14 días**
- D. Solicitar hisopado de fauces y cultivo para estreptococo.
- E. Solicitar TAC de senos paranasales
- F. Indicar azitromicina durante 5 días.
- G. Aspirar secreciones nasales para cultivo y antibiograma.
- H. **Indicar fluticasona en spray nasal.**

5. Lisandro de 8 meses concurre a la guardia con sus padres por presentar fiebre 38.5aC de 12 horas de evolución. Su madre refiere que Lisandro pasó toda la noche llorando y no pudo descansar bien. Además lo observa decaído y con rechazo parcial del alimento. Relata que hace una semana presentó tos y rinorrea acuosa.

Antecedentes personales: niño previamente sano, sin antecedentes perinatólogicos ni patológicos de relevancia, alimentado con pecho y leche de fórmula, no usa chupete.

Concurre a la guardería 6 hs diarias. Vacunas completas documentadas

Su familia está integrada por 3 hermanos sanos, madre y padre, ambos fumadores.

Al examen físico se observa que el niño está decaído, con fontanela normotensa, fauces levemente cpngestivas, adenopatías pequeñas cervicales y retroauriculares. A la otoscopia presenta abombamiento de la membrana timpánica y eritema de la misma en oído derecho confirmándose con la otoscopia neumática reducción de la movilidad de la membrana timpánica. El oído izquierdo presenta congestión peritimpánica.

El resto del examen físico es normal. No presenta signos meníngeos.

En relación con su hipótesis diagnóstica, ¿qué conductas adopta? Marque 3 opciones

- A. Promover la lactancia materna y evitar la exposición al humo del cigarrillo
- B. Solicitar interconsulta con ORL
- C. Conducta expectante
- D. Indicar amoxicilina por 10 días y control según evolución clínica
- E. Indicar miringotomía y cultivo de oído medio.
- F. Indicar analgesia con paracetamol las primeras 48 hs
- G. Indicar gotas óticas con Ciprofloxacina e hidrocortisona
- H. Indicar tratamiento con claritromicina vía oral por 7 días

7. Consulta Maximiliano de 6 años de edad por presentar rinorrea seropurulenta de 1 semana de evolución, con halitosis y obstrucción nasal bilateral, en los últimos tres días se agrega tos nocturna, cefalea, malestar general y picos febriles de 39°C . La madre dice que no consultó antes porque pensó que era una gripe mal curada. Antecedentes patológicos: otitis media aguda a los 2 años de vida tratada con amoxicilina por 10 días, niega antecedentes de alergia y asma. Vacunas completas para la edad. Recibió vacuna antigripal 10 días previos a la consulta.

Examen físico: Peso 22.0 kg (pc 50/75) Talla 115.0 cm (pc 25/50). Frecuencia respiratoria: 20 por minuto. Frecuencia cardíaca: 100 por minuto. Temperatura axilar: 38.5° . Presión Arterial 100/60 mmHg. Paciente alerta, consciente, orientado en tiempo y espacio. Nariz: cúmulo de moco purulento que obliga al niño a respirar por la boca, sin desviación del tabique nasal a la inspección. Fauces congestivas. Se visualiza goteo de moco retranasal, discreto edema facial. Dolor a la digito presión en la región de senos maxilares. Cuello: no se palpan adenomegalias en las cadenas laterocervicales. Aparato respiratorio: buena entrada de aire bilateral con rales de transmisión de la vía aérea superior, sin tirajes. Resto del examen físico, sin alteraciones

**¿Cuál de los siguientes conceptos le parece correcto en relación al caso clínico?
(Puede marcar hasta 2 opciones)**

Seleccione una o más de una:

- A. Indicar cefalexina vía oral durante 10 días.
- B. Solicitar tomografía de macizo facial para definir tratamiento.
- C. No es necesario solicitar laboratorio para iniciar tratamiento.
- D. Solicitar radiografía de senos y cavum para definir tratamiento.
- E. Indicar budesonide y descongestivos nasales
- F. Indicar corticoides vía oral durante 4 días.
- G. Indicar amoxicilina vía oral durante 10 días.
- H. Solicitar consulta con ORL.

11. Lorenzo, de 6 meses de edad, ingresa al Servicio de Emergencias con un cuadro de dificultad respiratoria. La presunción clínica inicial indica que se trata de una bronquiolitis. El

médico a cargo le efectúa tratamiento en base a β_2 agonistas y oxígeno por máscara. A las 2 horas del ingreso, Lorenzo presenta los siguientes parámetros:

Frecuencia cardíaca: 160x', Frecuencia respiratoria 70x', saturación de O₂: 86% respirando aire ambiental.

Con los datos disponibles, ¿cuáles serían las conductas más apropiadas en este momento de la atención? Marque 3 opciones

- A. Internarlo en la Sala de Pediatría.
- B. Solicitar gases en sangre.
- C. Colocarle una vía para hidratación parental.
- D. Colocarle una sonda nasogástrica para alimentarlo.
- E. Efectuar interconsulta con Cardiología.
- F. Solicitar de inmediato el ingreso de Lorenzo para asistencia respiratoria mecánica.
- G. Proseguir con alimentación materna para evitar la deshidratación de Lorenzo.
- H. Dejarlo en la guardia en observaciones para realizar una segunda serie con la misma medicación.

12. Malena de 10 años de edad acude al servicio de guardia del Hospital donde Ud. trabaja en una localidad del conurbano bonaerense, por presentar, desde hace aproximadamente 6-7 horas, tos seca de tipo opresiva.

Presenta como antecedentes personales rinitis alérgica y diabetes insulínica dependiente. Concorre al colegio con buen desempeño, practica hockey en el colegio y club del barrio, tiene una vida social activa, el último cumpleaños de un amigo lo tuvo hace dos días. Vive junto a sus padres, dos hermanos con diagnóstico de asma y una abuela con diabetes y patología cardíaca.

Ud. constata palidez cutánea, la nota con dificultad respiratoria, con tiraje supra-esternal, respiración superficial y taquipnea, frecuencia cardíaca 116/min. A la auscultación se aprecian abundantes sibilancias inspiratorias y espiratorias en ambos campos pulmonares, taquicardia rítmica, rinitis acuosa. Saturación de pulso 92% aire ambiental.

Según su hipótesis diagnóstica, ¿qué conductas adopta? Marque 3 opciones

- A. Indicar salbutamol 2 puff cada 4 horas en su domicilio
- B. Indicar Claritromicina vía oral durante 14 días
- C. Solicitar radiografía de tórax
- D. Indicar budesonide inhalatorio cada 12 horas
- E. Solicitar glucemia capilar
- F. Indicar metilprednisona 1 mg/kg/día vía oral.
- G. Solicitar estado ácido-base por punción arterial.
- H. Indicar oxígeno humidificado y salbutamol en puff

13. Yanina de 3 años de edad junto a sus padres y 3 hermanos habitan una vivienda precaria de un barrio humilde del conurbano bonaerense. Carecen de cloacas y asfaltado. Tienen 2 perros y 1 gato que comparten también la casa.

La madre refiere que la niña es sana, pero que en el último tiempo presentó 2 episodios broncoobstructivos. Además, agregó, que en algunas ocasiones tuvo vómitos y disminución del apetito y que una oportunidad registró fiebre.

A la observación llama la atención la existencia de mayor sequedad y prurito cutáneos. Yanina con su mamá concurren al Hospital para mostrarle los resultados de exámenes complementarios solicitados por otro colega hace una semana, fecha en la que Yanina fue llevada por cuadro de dificultad respiratoria y se le administró un tratamiento adecuado. Actualmente ha mejorado de su cuadro bronquial. La vacunación es completa para la edad. Los estudios informan: Hemograma: Leucocitos: 10800/mm³; 46%; L:28%; E:26%; B:0%; M:0%; Hemoglobinemía 10,1g/dl; plaquetas: 236000/mm³. Hepatograma: TGO: 20 UI/L; TPG:48 UI/L. Urea:32 mg/dl. Sedimento urinario: L: 0- 1/cpo; H:0-1/cpo.

De acuerdo a su hipótesis diagnóstica, usted, ¿qué solicita? Marque 3 opciones.

- A. TAC de tórax y abdomen
- B. Interconsulta con Hematología
- C. Coproparasitológico y serología para toxocariasis
- D. RX de abdomen de pie
- E. Pruebas cutáneas para alergia
- F. Fondo de ojo
- G. Ecografía abdominal
- H. RX de tórax

14. Usted se encuentra en la guardia de pediatría del hospital general de su ciudad. Ingresa desesperada una madre con su hijo, Astor, de 4 años de edad en brazos, quien presenta importante compromiso del estado general y dificultad respiratoria con disnea grave, sialorrea, disfonía, estridor, tos y tiraje supraesternal.

La madre refiere que comenzó bruscamente. No refiere antecedentes de importancia. La madre desconoce que estaba haciendo, porque estaba en otro lugar de la casa.

Se comprueba la estabilidad hemodinámica y respiratoria en ese momento, con tensiones arteriales normales, frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto y saturación periférica de oxígeno de 82% con aire ambiente. Afebril. Se administra oxígeno suplementario al 50% con máscara facial, que eleva la saturación periférica al 92%. En la exploración física se destacan sibilancias en hemitórax derecho a la auscultación pulmonar.

Ante esta situación clínica, ¿cuáles son las conductas más apropiadas? Marcar hasta 3 opciones.

- A. Indicar el tratamiento con metilpredisolona cada seis horas y adrenalina nebulizada.
- B. Realizar el barrido digital a ciegas de fauces para retirar cuerpo extraño.
- C. Colocar al niño en posición de olfateo con oxígeno suplementario.
- D. Asumir que se trata de epiglotitis aguda.
- E. Asumir al paciente en insuficiencia respiratoria, indicar intubar y derivar a la terapia, previa colocación de vía periférica.

- F. Realizar la maniobra de Heimlich.
- G. Asumir el cuadro como una crisis asmática.
- H. Indicar tratamiento antibiótico E.V.
- I. Sospechar la presencia de un cuerpo extraño y solicitar radioscopia.
- J. Derivar a centro que cuente con endoscopía respiratoria.

15. Llega a la guardia Rocco, de 6 años de edad, con mielomeningocele. Consulta por fiebre de 48 horas de evolución. Luego de examinarlo, se decide solicitar los siguientes exámenes complementarios: laboratorio de sangre y orina. Mientras esperan los resultados el niño juega con un guante inflado con sus padres en la sala de espera. Comienza con dificultad respiratoria, estridor laríngeo y exantema urticariano.

EXAMEN FÍSICO: frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, saturación 96% con aire ambiente y TA 90/55 mmHg. Se auscultan sibilancias y se observa exantema urticariano en tronco y abdomen.

Frente a este cuadro, ¿cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? Marcar hasta 3 opciones.

- A. Administrar adrenalina intramuscular
- B. Administrar tratamiento tópico con corticoides en las lesiones de piel
- C. Indicar corticoides por vía oral
- D. Indicar antihistamínicos EV e altas dosis
- E. Indicar glucocorticoides EV a altas dosis
- F. Colocar venoclisis y administrar oxígeno
- G. Indicar antihistamínicos por vía oral
- H. Intubar electivamente al paciente
- I. Indicar dopamina EV
- J. Administrar beta2 inhalatorios 2

16. Esteban de 9 años es traído a su consultorio por primera vez, pues hoy por la mañana mientras jugaba al fútbol tuvo sensación de falta de aire y opresión en el pecho por lo que debió abandonar el juego. La madre refiere que tiene tos desde hace 48 hs, sin fiebre pero comenzó con rinitis serosa, cuadros habituales en él, que suelen estar acompañados de prurito nasal y estornudos durante los meses de frío. Niega antecedentes broncoobstructivos, pero reconoce que en otras oportunidades tuvo dolor en el pecho durante el ejercicio por lo que realizó evaluación cardiológica que refiere que fue normal.

Hijo único de padre de 40 años, sano, fumador de 20 cigarrillos por día y madre de 36 años, con rinitis alérgica y fumadora social.

Al examen físico: buen estado general, conversa sin dificultad, afebril, frecuencia cardíaca 100 latidos/min, frecuencia respiratoria 24 respiraciones/min, tiraje intercostal, leve disminución de entrada de aire bilateral con espiración prolongada y sibilancias espiratorias. La medición de SpO2 es 97% AA y durante la evaluación presenta tos seca, persistente.

¿Cuáles considera las conductas iniciales más adecuadas? (Puede marcar hasta tres opciones)

- A. Indicar salbutamol en aerosol hasta la próxima evaluación.
- B. Suspender la actividad física por los próximos 30 días
- C. Solicitar ECG y Ecocardiograma
- D. Derivar al Neumólogo infantil.
- E. Solicitar espirometría basal y postejercicio.
- F. Indicar nebulizaciones con budesonide 3 veces por día hasta la próxima evaluación.
- G. Solicitar Rx de senos paranasales.

17. En la madrugada en la guardia usted recibe a Claudia, de 30 meses, por dificultad respiratoria. La niña se despertó con accesos de tos muy seca y dolor de garganta. La madre le nota agitada. Había jugado durante toda la tarde, cenado muy bien y se había acostado temprano, momento en el cual la madre notó que Claudia estaba disfónica. Vacunación completa para la edad.

Al examen físico: Frecuencia cardíaca: 120 por minuto. Frecuencia respiratoria 24 por minuto. Temperatura axilar 37,5°C. Luce en buen estado general, algo pálida y llanto ronco. Estridor inspiratorio y leve disminución del murmullo vesicular en ambos campos pulmonares, sin otros ruidos agregados.

Ante esta situación decide inicialmente: (Puede marcar hasta 3 opciones).

- A. Indicar nebulización con solución fisiológica fría.
- B. Indicar nebulización con salbutamol en solución fisiológica.
- C. Trasladar a la niña al cuarto de shock.
- D. Solicitar dos hemocultivos y comenzar con antibiótico parenteral
- E. Indicar corticoides vía oral o nebulizado.
- F. Permitir que Claudia adopte la posición de su preferencia.
- G. Intubar al paciente con apoyo de anestesista o terapeuta.
- H. Solicitar hemograma y medio interno.

18. Francisco de 3 años de edad ingresa a la guardia del hospital, derivado de una Unidad Sanitaria, por presentar dificultad respiratoria. Hace 3 días comienza con fiebre de 38°C grados y tos por lo que consulta y le indican salbutamol en puff y antitérmicos para bajar la fiebre. No mejora el cuadro, aumentan los episodios de tos, la curva térmica asciende a 39°C grados y la madre nota que “está agitado” por lo que consulta nuevamente al centro de salud, donde le realizan tratamiento con salbutamol en forma secuencial durante dos horas, por falta de mejoría se decide su traslado al hospital de referencia.

Como antecedentes patológicos presenta 1 internación por bronquiolitis con hipoxemia a los 8 meses de vida. La madre padeció TBC hace 5 años y completó el tratamiento. Actualmente asintomática. Tiene 2 hermanos sanos, sin síntomas respiratorios. La madre niega síntomas de Covid 19 en los convivientes. Vacunas completas para la edad.

Examen físico: Activo, vigil, conectado con el medio, normohidratado. FR: 35 respiraciones/minuto, FC 128 latidos/min, Temperatura axilar 38,4°C°, saturometría de O₂ 92% AA. Regular entrada de aire en ambos campos pulmonares, rales crepitantes en base pulmonar izquierda, espiración prolongada y sibilancias espiratorias diseminadas. Tiraje subcostal e intercostal. Abdomen blando, depresible, indoloro, hígado a 2 cm de reborde costal. Radiografía de tórax: diafragmas a nivel del noveno espacio intercostal, se evidencian infiltrados parahiliales bilaterales, con imagen de consolidación paracardiaca basal izquierda, ángulos costo frénicos libres. Hemograma: hematocrito 36%, hemoglobina 12mg %, glóbulos blancos 23.000, neutrófilos 82% 35-60, linfocitos 15% 25-50, Plaquetas 270.000/mm³. Proteína C Reactiva: 45 mg/dl. PCR COVID 19: pendiente. Hemocultivos x 2: pendientes

De acuerdo a la sospecha diagnóstica, cuáles son las conductas iniciales más apropiadas? (Puede marcar hasta 3 opciones)

- A. Indicar corticoides parenterales.
- B. Seguimiento ambulatorio con amoxicilina vía oral, sin requerimiento de aislamiento.
- C. Indicar salbutamol en puff.
- D. Conducta antibiótica expectante hasta resultado de PCR COVID-19.
- E. Indicar tratamiento con antibiótico y aislamiento.
- F. Administrar oxígeno.
- G. Control ambulatorio e indicar Claritromicina vía oral.
- H. Solicitar PPD y Rx al grupo familiar.

21. Noah de 5 meses de edad es traído a la consulta por su madre, por presentar tos leve y agitación de 2 días de evolución. En las últimas horas se agregó agitación, dificultad para alimentarse, deposiciones abundantes de consistencia disminuida y un vómito con secreciones mucosas postusigenas. Recién nacido de término, peso de nacimiento 3000 gr sin patología perinatal. Recibe pecho materno a demanda Vacunación: completas para la edad.

Examen físico: presenta: peso 7.500 gr (Pc 50), talla 68 cm (Pc 50), FC: 130/min, FR: 40/min. temperatura axilar 37.5, mucosas rosadas y húmedas. Otoscopia ambos tímpanos congestivos, se observa triángulo luminoso. Tos productiva, catarro seromucoso en fauces que asciende con la tos, tiraje subcostal bilateral Auscultación pulmonar espiración prolongada, sibilancias espiratorias diseminadas y leve disminución de entrada de aire en base derecha. Auscultación cardiaca 2 ruidos en 4 focos, silencios difíciles de caracterizar por los ruidos respiratorios y el llanto continuo. Relleno capilar 2 segundos, pulsos periféricos positivos y simétricos, hígado a 3 cm por debajo de reborde costal Diuresis positiva. Signo de pliegue negativo. Resto del examen sin particularidades. Se constata una deposición semilíquida.

Ante el cuadro clínico que presenta Noah. ¿cuáles son las conductas iniciales más correctas? (Marque hasta 3 opciones)

- A. Solicitar teleradiografía de tórax.
- B. Colocar oxígeno por bigotera.

- C. Indicar corticoides vía oral.
- D. Indicar alimentación por sonda nasogastrica.
- E. Indicar hidratación parenteral.
- F. Indicar seguimiento ambulatorio y control en 24hs.
- G. Liberar vía aérea superior con solución fisiológica.
- H. Indicar lactancia materna fraccionada y frecuente

25. Germán de 3 años de edad es traído a la consulta de guardia por presentar impotencia funcional de miembro inferior derecho de 12 horas de evolución. Está cursando un cuadro infeccioso de vías aéreas superiores, con rinitis, tos, sin fiebre ni dificultad respiratoria. Germán es un niño sano, sin antecedentes a destacar, vacunas completas para la edad. Asiste al jardín maternal de donde fue retirado hace dos horas por imposibilidad de caminar.

Al examen físico: se encuentra en buen estado general, afebril. Rinitis serosa, fauces levemente congestivas, otoscopia normal, auscultación pulmonar y examen cardiológico normales. Se evidencia dificultad en la marcha, con limitación en la movilización pasiva de la cadera derecha. Resto del examen sin particularidades.

**Con los datos disponibles, ¿cuáles son las conductas iniciales más adecuadas?
(Marque hasta 3 opciones)**

- A. Solicitar hemograma y reactantes de fase aguda.
- B. Solicitar ecografía de ambas caderas.
- C. Indicar antibióticos EV.
- D. Indicar antiinflamatorios por vía oral y reposo.
- E. Control ambulatorio en 24 horas.
- F. Solicitar punción de articulación de cadera derecha.
- G. Internar para completar estudios diagnósticos.
- H. Solicitar ecografía de cadera y rodilla derechas.

26. Mara de 10 años es traída a la consulta hospitalaria por presentar tos seca irritativa, persistente, sofocante por momentos y que finaliza con un ruido raro. Su padre comenta que el cuadro comenzó hace aproximadamente 15 días con 48 hs de fiebre, resfrió y con tos leve a predominio nocturno. Le administro un jarabe para la tos, pero la misma se fue intensificando y algunos episodios son accesos de tos sofocantes, hasta que en el día de hoy un vómito alimenticio luego de un acceso. Refiere que una hermana mayor, Florencia de 17 años tuvo un cuadro similar de tos y fiebre 15 días antes por lo que fue medicada con antibióticos y mejoró.

Al examen físico se observa una niña delgada de piel morena algo decaída con mucosas rosadas, ojos con inyección conjuntival pero sin secreciones. respiración tranquila, frecuencia respiratoria 20 respiraciones por minuto con buena entrada de aire bilateral, roncus sin otros ruidos agregados. Frecuencia cardiaca 120 latidos por minuto, silencios libres. Cicatriz de BCG en region deltoidea derecha. Abdomen blando depresible indoloro sin visceromegalias.

Ud. decide efectuar por guardia una radiografía de tórax frente que muestra imágenes hiliofugales bilaterales y una pequeña imagen opaca en seno cardiofrénico derecho - (derrame pleural). Presenta carnet de inmunizaciones completo para la edad.

Con los datos disponibles, cuáles son las hipótesis?

- A. Coqueluche.
- B. Neumonía bacteriana aguda.
- C. Neumonía atípica primaria.
- D. Neumonía viral aguda.
- E. Tuberculosis primaria.
- F. Fibrosis quística del páncreas.
- G. Crisis asmática leve persistente.
- H. Bronquitis viral aguda.

27. Jonathan de 3 meses de edad es traído a la guardia por cuadro de tos de 24 horas de evolución. Los padres refieren que comenzó con mocos claros por nariz y tos seca esporádica, con 37,7 oC de temperatura axilar pero les preocupa que está con tendencia al sueño e inapetente. En el día de hoy presentó dos regurgitaciones. Nació a las 35 semanas de edad gestacional, con peso de 2.170 gramos, dado de alta a las 48 hs. Se alimenta con pecho exclusivo con buena progresión de peso. No refiere otros antecedentes de importancia.

Su hermano de 5 años de edad está resfriado desde hace 4 días pero sin fiebre y sin tos. El padre sano de 32 años, empleado fuma 15 cigarrillos por día pero no en el hogar. Madre sana 30 años no fumadora, ama de casa. Viven en un departamento de dos ambientes, con todas las necesidades básicas.

Al examen físico se aprecia aletargado, algo pálido, temperatura axilar 37,4 oC, frecuencia respiratoria: 66 por minuto, frecuencia cardiaca: 148 por minuto, auscultación cardiaca normal. Presenta tiraje intercostal y supraesternal con aleteo nasal intermitente y se auscultan sibilancias inspiratorias y espiratorias con rales subcrepitantes diseminados bilaterales. Abdomen algo globuloso pero depresible e indoloro se palpa borde hepático a 3 cm del reborde costal y se percibe polo de bazo. El resto del examen físico sin particularidades

¿Cuáles son las conductas iniciales más adecuadas frente a este cuadro? (Puede marcar hasta 3 opciones)

- A. Colocar sonda nasogástrica para alimentación.
- B. Desobstruir las narinas y colocar en posición semisentada.
- C. Continuar con pecho en forma frecuente y fraccionada para que tolere mejor
- D. Indicar kinesioterapia respiratoria.
- E. Internar en sala y colocar oxígeno por cánula nasal.
- F. Indicar salbutamol en aerosol cada 20 minutos durante una hora y revalorar.
- G. Solicitar radiografía de tórax.
- H. Enviar al domicilio con salbutamol aerosol y betametasona y citar a las 24 horas.

29. Es traído por sus padres a la guardia externa, Juan de 8 años de edad. Se trata de un niño previamente sano, a quien se le diagnosticó otitis media aguda derecha hace 5 días y fue medicado con amoxicilina 90 mg/kg/día. En el día de hoy consulta por persistencia de la fiebre y dolor retroauricular. Al examen físico encuentra edema y eritema retroauricular con despegamiento y antepulsión del pabellón auricular derecho.

Pregunta: De acuerdo a su hipótesis diagnóstica inicial, ¿cuáles son las conductas prioritarias? (Marque hasta 3 opciones)

- A. Rotar antibiótico a cefalexina vía oral por 10 días.
- B. Solicitar Rx cráneo frente y perfil con foco en mastoides.
- C. Solicitar TAC de cerebro con contraste EV
- D. Rotar el antibiótico a amoxicilina-clavulánico y citar a control en 24hs.
- E. Solicitar internación para tratamiento antibiótico EV.
- F. Indicar gotas óticas con tobramicina.
- G. Indicar lavados de conducto auditivo externo.
- H. Realizar interconsulta con ORL.
- I. Indicar corticoides sistémicos.
- J. Solicitar ecografía de glándula parotídea.

30. Ramiro de 5 años de edad concurre a la consulta con su mamá. A su padre José, de 36 años albañil sin trabajo fijo, le diagnosticaron tuberculosis pulmonar hace tres semanas por lo que permanece internado en un hospital del conurbano con buena respuesta al tratamiento. La madre de 32 años refiere ser sana aunque en la consulta se escucha toser.

La familia vive en González Catán, en una vivienda de material, sin revocar, de los ambientes, piso de cemento, agua de bomba, pozo ciego, gas de garrafa. Conviven con Ramiro, sus padres, un tío paterno de 17 años, una tía materna de 20 años, empleada en una panadería, y la abuela materna.

La madre refiere que realiza esta consulta por recomendación de los médicos de su marido como parte del catastro familiar. El niño tiene tos, desde hace un tiempo, come poco aunque siempre fue inapetente. Al examen físico se lo observa adelgazado, afebril con rinorrea mucosa. No presenta cicatriz de BCG, se ausculta buena entrada de aire bilateral sin ruidos agregados. Dos ruidos cardiacos en cuatro focos silencios libres. Peso en Pc 10 y Talla en Pc 25.

¿Cuáles son las conductas iniciales más correctas? Marque 3 opciones

- A. Iniciar tratamiento con Isoniacida, rifampicina, pirazinamida
- B. Suspender la concurrencia al jardín de infantes hasta completar diagnóstico
- C. Iniciar tratamiento con Isoniacida
- D. Solicitar reacción de PPD 2 UT y control a las 48 horas
- E. Solicitar radiografía de tórax frente y perfil
- F. Internar a Ramiro hasta completar estudios
- G. Realizar tres lavados gástrico en ayunas

31. Damián, de 1 año 10 meses de edad, llega a la consulta con su madre por presentar fiebre de 39° en las ultimas 24 horas. Refiere que comenzó con decaimiento e irritabilidad en las ultimas 48 horas a lo que se agregó rechazo parcial del alimento, abundante babeo y aliento fétido. Sano hasta la enfermedad actual, concurre al jardín maternal por la mañana. Presenta inmunizaciones para la edad.

Al examen se parecía un niño con regular estado general, febril a 39.3°, decaído algo pálido con adenopatías submaxilares bilaterais de 1.5cm y dolorosas a la palpación. Babeo intenso. En la boca se observan encías tumefactas, eritematosas y algo sangrantes, lengua blanquecina, y varias vesículas en paladar blando y duro con lesiones y ulcerativas en lengua, surco gingival y mucosas. Las amígdalas tapizadas con exudado blanquecino y algunas lesiones ulcerativas. La otoscopia bilateral es normal y el resto del examen físico sin particularidades.

En relación con el cuadro clínico, ¿cuáles considera las conductas más adecuadas para transmitir a la madre? Marcar hasta 3 opciones

- A. Indicar paracetamol 2 gotas por kg de peso hasta 4 veces por día
- B. Indicar amoxicilina/acido clavulanico 50mg/kg/día
- C. Administrar líquidos por boca fraccionados
- D. Indicar tropicaciones locales con gel de lidocaína al 1%
- E. Indicar aciclovir oral si la fiebre dura más de 5 días
- F. Solicitar test rápido de fates y cultivo
- G. Internación del paciente para control estrecho y tratamiento
- H. Indicar dieta blanda y fría

32. Pedro de 4 meses y medio de edad es traído a la consulta hospitalaria por su madre Teresa de 26 años, preocupada porque el bebé tose desde hace aproximadamente 20 días cada vez con mayor intensidad en forma de ataques de tos varias veces por día y desde hace 4 días es tan violenta que lo hace vomitar, lo despierta de noche, lo deja agitado, se congestiona la cara y al finalizar el acceso de tos produce un ruido respiratorio raro. El cuadro comenzó con fiebre de 38°C durante los primeros tres días y luego no volvió a repetir pero la tos seca se fue haciendo más intensa. Conserva el apetito y se alimenta con pecho exclusivo. Es un RN de término con PN 3720 gr. Refiere que es sano hasta la enfermedad actual, realiza controles mensuales de salud y exhibe carnet de vacunas completo para la edad.

Convive con el padre, Luis de 26 años, tosedor habitual quien fuma 20 cigarrillos por día, empleado en una droguería, madre sana de 26 años, no fumadora, maestra jardinera y un hermano Rafael de 10 años con antecedentes de alergia respiratoria quien también presenta tos de más de un mes de evolución pero sin fiebre y sin complicaciones. Cursa 5º grado. Viven en un departamento de tres ambientes con todos los servicios.

Al examen físico se aprecia un lactante eutrófico, con cicatriz de BCG en deltoides. Afebril con leve inyección conjuntival bilateral y algunas petequias en la frente y mejillas. Presenta

respiración tranquila, buena entrada de aire bilateral, roncus bilaterales sin otros ruidos agregados, leve disminución del murmullo vesicular en vértice derecho: FC 110 latidos por minuto, FR 40 respiraciones por minuto, SpO2 97% aire ambiental. Bajó 200 gr de peso respecto al control previo.

**De acuerdo a su hipótesis diagnóstica, cuáles son las conductas adecuadas?
(Marque hasta 3 opciones)**

- A. Indicar metoclopramida para evitar los vómitos.
- B. Realizar PPD 2UT a toda la familia.
- C. Solicitar test del sudor.
- D. Realizar Radiografía de Tórax a los padres.
- E. Realizar aspirado nasofaríngeo para inmunofluorescencia de virus respiratorios.
- F. Iniciar tratamiento con claritromicina 15 mg/kg/d hasta obtener resultados.
- G. Iniciar quimioprofilaxis con isoniacida 1 vez por día hasta obtener resultados.
- H. Realizar aspirado nasofaríngeo para Elisa para Bordetella Pertussis.

33. Concorre a la guardia donde usted trabaja, Analía, de 9 meses, por fiebre (38-38,5 oC) que cede transitoriamente con medios físicos y tos durante las últimas 72 horas que interrumpió su sueño durante la última noche. Ha mantenido una buena actitud alimentaria. Antecedentes personales: Vacunas completas. Tuvo un resfrío, dos otitis medias agudas y una gastroenteritis aguda, todos con buena evolución. Su padre, 24 años, albañil, su madre, 27 años, ama de casa, ambos sanos. Viven cerca del hospital.

Al examen físico luce en buen estado general, rosada. Frecuencia cardiaca 136/minuto. Presión arterial 90/56 mm Hg. Frecuencia respiratoria 44 por minuto. Saturometría con aire ambiental 96 %. Temperatura axilar 37,6 °C. Fauces levemente congestivas, ambos tímpanos rosados con triángulo luminoso presente. Sin aleteo nasal, leve tiraje intercostal, murmullo vesicular presente, sibilancias al final de la espiración en ambas bases pulmonares. Resto del examen sin particularidades.

¿Cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? (marque hasta 3 opciones)

- A. Continuar con la alimentación por vía oral.
- B. Solicitar aspirado nasofaríngeo de secreciones respiratorias.
- C. Indicar paracetamol por vía oral si tuviera fiebre.
- D. Indicar ibuprofeno y paracetamol alternados si tuviera fiebre.
- E. Indicar bromuro de ipratropio por aerocámara cada 12 horas.
- F. Citar a control en 24-48 horas.
- G. Indicar nebulizaciones con budesonide cada 8 horas.
- H. Internar al paciente con oxígeno.

34. Ignacio, de 3 años de edad, es traído por sus padres al servicio de Emergencias por presentar fiebre de 3 días de evolución acompañado de tos persistente, astenia y anorexia.

Antecedentes personales: Ignacio nació en una zona rural de la Provincia de Formosa, de parto domiciliario, sin controles perinatales. Broncoespasmos a repetición desde los primeros meses de vida, recibió tratamiento con broncodilatadores de acción corta y corticoide oral y corticoides inhalatorios preventivos con mejoría parcial en la frecuencia e intensidad de los episodios. Neumonía-atelectasia a los 18 meses. Examen físico: Niño en regular estado general. Impresiona moderadamente enfermo. Palidez de piel y mucosas. Dedos en palillo de tambor. Peso: en percentilo 3 para la edad Talla: en percentil 25. Temperatura: 38,7°C. Tensión arterial: 90/50 mmHg. Aparato respiratorio: frecuencia Respiratoria: 50 por minuto. Tiraje sub e intercostal moderado. Hipoventilación alveolar generalizada. Sibilancias aisladas. Saturación de oxígeno a aire ambiental: 86%. Aparato cardiovascular: frecuencia cardiaca: 130 latidos por minuto. Dos ruidos en los cuatro focos. Silencios libres. Abdomen blando, depresible, ligeramente distendido. Depositiones pastosas y fétidas.

Con los datos presentados, además de internar y administrar oxígeno, ¿cuáles son las conductas iniciales más adecuadas para llegar al diagnóstico? (marque hasta 3 opciones):

- A. Solicitar radiografía de tórax frente y perfil
- B. Solicitar espirometría.
- C. Solicitar baciloscopia de esputo.
- D. Solicitar resonancia de tórax y abdomen.
- E. Solicitar test del sudor.
- F. Solicitar ecografía pleural.
- G. Solicitar radiografía de senos paranasales.
- H. Solicitar lavado broncoalveolar.

35. Nicolás de 2 años de edad presenta desde hace 5 días un cuadro clínico de tos irritativa, rinorrea acuosa y fiebre. Recibe en forma ambulatoria desde hace 3 días, tratamiento con prednisona y salbutamol. Ante la persistencia del cuadro clínico, la madre concurre nuevamente a control. Vacunación completa para la edad. Examen físico: peso 12 kg (Pc 50): talla 86 cm (Pc 50): temperatura axilar 39,3°C. Regular estado general, fauces congestivas, otoscopia normal. Hipoventilación en base pulmonar izquierda, sin ruidos agregados, columna vertebral sonora. Frecuencia cardiaca: 120 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria: 30 respiraciones por minuto. Saturación de O₂ (oximetría) 95%, AA. Abdomen blando, depresible, levemente doloroso en flanco izquierdo con ruidos hidroaéreos dentro de la normalidad. Pulsos periféricos presentes con relleno capilar 3 segundos.

Según su diagnóstico presuntivo ¿Que estudios complementarios le solicitaría en este momento? (Marque hasta 3 opciones)

- A. Estudio de Espirometría pre y post administración de salbutamol
- B. Hemograma completo.
- C. Proteína C reactiva o Eritrosedimentación
- D. Dosaje de Inmunoglobulinas G.A.M.Y E.
- E. Radiografía de tórax frente y perfil

- F. Tomografía de tórax simple.
- G. Ecografía abdominal
- H. Estado Ácido base arterial

36. Ernesto de 7 años de edad es traído al consultorio externo, pues a su padre Martin de 36 años le diagnosticaron TBC pulmonar hace tres semanas por lo que permanece internado. Su madre Isabella de 32 años realiza tareas domésticas y no refiere síntomas. Isabella trae a Ernesto por recomendación de los médicos del padre, refiere que tiene tos desde hace un tiempo y que come poco aunque siempre fue inapetente y trae una Rx de tórax (F) del día anterior que muestra un engrosamiento paratraqueal derecho y un infiltrado en vértice derecho.

Al examen físico se observa un niño adelgazado, afebril, decaído con rinorrea mucosa. Presenta cicatriz de BCG, se ausculta buena entrada de aire bilateral sin ruidos agregados, FC 88 latidos/minuto, dos ruidos en cuatro focos, silencios libres. FR 32 respiraciones/minuto. Peso en Pc 10 y Talla en Pc 25.

¿Cuáles de las siguientes son las conductas iniciales más adecuadas ? (Marque hasta 3 opciones):

- A. Indicar profilaxis con isoniacida.
- B. Indicar tratamiento con amoxicilina
- C. Solicitar baciloscopia en esputo.
- D. Realizar Punción Lumbar.
- E. Solicitar reacción de PPD 2 UT**
- F. Diferir tratamiento específico hasta obtener resultados.
- G. Solicitar baciloscopia en lavado gástrico en ayunas.**
- H. Iniciar tratamiento con Isoniacida, rifampicina, pirazinamida**

8. Ciro de 8 años concurre al hospital por decaimiento, fiebre de 39°C y dolor abdominal en hemiabdomen derecho.

No posee antecedentes personales de importancia y su familia es sana. Comenzó hace 24 horas con tos seca y anorexia.

Al examinarlo se constata taquipnea, tos y a la auscultación pulmonar murmullo vesicular disminuido en base derecha, algunos rales crepitantes sin otros ruidos agregados. A la palpación refiere dolor en hemiabdomen derecho, sin signos peritoneales, puñopercusión negativa. Ruidos hidroaéreos conversados. Saturometría 98% con aire ambiental. Rx de tórax: muestra imagen redondeada radiopaca con patrón alveolar en campo inferior derecho.

Cuáles son las conductas más adecuadas que ud, adopta? Marcar hasta 3 opciones

- A. Indicar ceftriaxona parenteral
- B. Solicitar hemocultivos, hemograma y PCR**

- C. Solicitar radiografía de control en 30 días
- D. Indicar penicilina VO**
- E. Citar en 24 o 48hrs con pautas de alarma
- F. Solicitar ecografía pleural
- G. Internar al paciente**
- H. Solicitar TAC de torax

15. CARDIO + FIEBRE REUMÁTICA

1. Brisa, de 5 años de edad, es llevada a control en salud por sus padres. Es una niña que hasta el momento ha crecido y se ha desarrollado sin presentar problemas en su salud. Examen físico: Buen estado general. Peso 18 kg (Pc 25-50). Talla 107 cm (Pc 25-50). Aparato respiratorio. Frecuencia respiratoria: 25 respiraciones por minuto. Buena entrada de aire en ambos campos pulmonares. Aparato cardiovascular. Frecuencia cardíaca 90 latidos por minuto. Se ausculta soplo mesosistólico 2/6, en borde esternal izquierdo, que irradia a punta, pero no a dorso. No se palpa al colocar la mano en el pecho. Se atenúa al pedirle a Brisa que se siente. Abdomen blando, depresible, indoloro. Hígado y bazo no se palpan.

Ud. conversa con los padres acerca de los hallazgos en la evaluación clínica de Brisa. En este sentido, les comenta que: (marque hasta tres opciones)

- A. El soplo que presenta Brisa es frecuente en los niños de su edad.**
- B. Brisa no requiere estudios adicionales y puede desarrollar actividad normal.
- C. El soplo de Brisa es probable que desaparezca al llegar a la pubertad.**
- D. A medida que Brisa crezca, el soplo puede hacerse más intenso.
- E. Es conveniente que Brisa no realice actividad física de competición.
- F. Es aconsejable que Brisa se efectúe controles periódicos hasta la adolescencia.
- G. Le solicitará Tele Rx de tórax y electrocardiograma.**
- H. Brisa debe efectuarse de modo programado un ecocardiograma con Doppler.

2. Fernando, de 3 años concurre a la consulta acompañado por su madre por presentar agitación la cual comenzó luego de haber jugado por más de una hora, en el transcurso del cumpleaños de un compañero del jardín.

Examen físico:

Fernando se encuentra en buen estado general, rubicundo y cursa una rinitis leve.

Frecuencia respiratoria: 20 por minuto Frecuencia cardíaca 100 por minuto. Tensión arterial: 80/40 mm Hg. Pulsos regulares y simétricos. No hay frémito. Soplo sistólico en mesocardio 2/6 que no oculta el primer ruido y desdoblamiento no fijo del 2o ruido en área pulmonar variable con la respiración. El soplo disminuye en intensidad en posición de pie.

De acuerdo a sus hipótesis diagnósticas, ¿qué decide solicitar? Marque 2 opciones

- A. Espirometría
- B. Electrocardiograma**
- C. Rx de tórax perfil con relleno esofágico
- D. Hemograma y eritrosedimentación
- E. Ergometría
- F. Eco Doppler
- G. Rx de tórax**
- H. Ecocardiograma

3. Filomena, de 18 meses llega la guardia donde usted se desempeña acompañada por sus padres. Presenta un comunicación interventricular, fiebre de 48 horas de evolución, que durante las últimas horas se acompaña por cianosis progresiva.

EXAMEN FÍSICO: Peso 10 kilos. FC 175 latidos por minuto, TA 80 / 45 mm Hg 80-105/45-70, FR 40 por minuto, oximetría con aire ambiental 80%, temperatura axilar 38°C. Se evidencia mal estado general, cianosis intensa generalizada, irritable. Dos ruidos en 4 focos, sin tercer ruido, soplo sistólico en mesocardio, pulsos femorales palpables, pulsos pedios disminuidos, manos y pies fríos. Hipoventilación más marcada en hemitórax izquierdo sin crepitantes. Se palpa el borde hepático 3 cm por debajo del reborde costal derecho.

LABORATORIO AL INGRESO: Hemoglobina 12,7 g/dl, hematocrito 39%, leucocitos 5.110 por mm³ (NS 42% 35-60, L 53% 25-50), plaquetas 50.300 por mm. PCR 248 mg/l. Glucemia 168 mg/dl, creatininemia 0,6 mg/dl. Natremia 131 mEq/l, kalemia 3,2 mEq/l, calcemia 6,5 mg/dl. EAB venoso con FiO₂ 0.21; pH 7,2; pCO₂ 68 mm HG, pO₂ 58 mm Hg, HCO₃ 24,8 mEq/l, EB -3,78 mEq/l.

¿Cuál es el diagnóstico inicial y qué tratamiento iniciaría? Marcar hasta tres opciones

- A. Contraindicar las expansiones con solución fisiológica por hepatomegalia
- B. Sepsis de probable origen respiratorio
- C. Indicar insulina corriente intramuscular
- D. Corregir la hipocalcemia
- E. Administrar antibióticos parentales después de estabilizar al paciente**
- F. Administrar O₂ por máscara**
- G. Shock séptico de probable origen respiratorio**
- H. Colocar un acceso vascular central de larga permanencia
- I. Crisis de disnea y cianosis
- J. Endocarditis bacteriana subaguda

4. Marianela, de 11 años de edad, concurre con sus padres al hospital más cercano a su domicilio. Ingresa con cuadro clínico de 48 horas evolución caracterizado por lesiones maculopapulares en ambos miembros inferiores acompañado de dolor abdominal difuso. Antecedentes: presentó un episodio de faringoamigdalitis, dos semanas antes, y fue medicada en dicha oportunidad con amoxicilina e ibuprofeno con evolución favorable.

Examen físico: se evidencian lesiones maculopapulares palpables sobreelevadas en miembros superiores y ambos miembros inferiores extendiéndose a región glútea y petequias. Discreto edema levemente doloroso en ambos tobillos y ambas rodillas, sin evidencia de flogosis. Abdomen blando, depresible con peristaltismo conservado, no doloroso a la palpación profunda.

Durante la evolución clínica, se le efectuaron los siguientes estudios: Leucocitos de 9200/mm³, neutrófilos segmentados 53%, linfocitos 47%, hemoglobina 13,6g/dl, hematocrito 40%, plaquetas 171000/mm³, concentración de protombina de 80%.

Marcar hasta 3 opciones

- a. Debe efectuar controles oftalmológicos a cada 3 meses
- b. Es muy importante el control periódico de la función renal**
- c. Podría requerir un esplenectomía a largo plazo
- d. Marianela podría presentar episodios de melena o hematuria**
- e. Es probable que las manifestaciones articulares produzcan rigidez articular prolongada.
- f. Puede volver a tener otros episodios similares al actual**
- g. Existe un riesgo importante de hemorragia del sistema nervioso central
- h. Marianela no debe recibir corticoides mientras persistan las lesiones cutáneas

5. Usted se encuentra en una guardia de emergencias. Recibe a Rosendo, un niño de 8 meses de edad, oriundo de Paraguay, con la familia recién llegada. Está al cuidado de la tía porque los padres están buscando trabajo. La tía sabe que tiene un soplo en el corazón y que lo estaban estudiando antes de que llegaran a Argentina. Hace 48 hs comenzó con rinorrea serosa y febrícula. Lo trae a la guardia porque comenzó en forma brusca con agitación y coloración azulada de mucosas. Lloro durante el examen y en la guardia usted constata: frecuencia cardíaca: 160 /minuto; frecuencia respiratoria: 68/minuto; Saturación de oxígeno: 70% AA. No ausculta soplo. No se auscultan sibilancias a nivel respiratorio.

De acuerdo a su hipótesis diagnóstica, cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? (Puede marcar hasta 3 opciones)

- A. Indica lorazepam.
- B. Indica tratamiento con salbutamol y corticoides.
- C. Colocar oxígeno**
- D. Colocar al paciente en posición de cuclillas**
- E. Indica diuréticos.
- F. Solicita interconsulta en guardia con neurología infantil.
- G. Ubica al niño en un ambiente tranquilo.**
- H. Tranquiliza a la tía dado que el episodio cederá en pocos minutos.

7. Es traída por sus padres a la guardia donde usted se desempeña Filomena, de 18 meses con comunicación interventricular, por fiebre de 48 horas de evolución, acompañándose en

las últimas horas de cianosis progresiva.

Examen físico: Peso 10.0 kg. FC: 175 latidos por minuto, TA: 80 / 45 mm Hg, FR: 40 por minuto, oximetría con aire ambiental 80 %, temperatura axilar 38 oC. Al ingreso, la niña se encuentra en mal estado general, cianosis intensa generalizada, irritable. Dos ruidos en 4 focos, sin tercer ruido, soplo sistólico en mesocardio, pulsos femorales palpables, pulsos pedios disminuidos, manos y pies fríos. Hipoventilación en hemitórax izquierdo sin ruidos agregados. Se palpa el borde hepático 3 cm por debajo del reborde costal derecho.

Luego de las medidas terapéuticas iniciales y una vez estabilizado el paciente.

¿Cuáles de los siguientes estudios diagnósticos iniciales son los más apropiados? (Marque hasta 3 opciones).

- A. Tomografía de tórax y abdomen.
- B. Ecografía pleural.
- C. Hemograma completo, PCR, ionograma, EAB, glucemia, uremia y creatininemia.
- D. Teleradiografía de tórax.
- E. Determinación de metahemoglobinemia, troponina y factor V.
- F. Hemocultivos (2), orina completa y urocultivo.
- G. Punción lumbar para citoquímico y cultivo de LCR.
- H. Hepatograma completo y ecografía abdominal.

16. NEURO + SEPSIS

1. Concorre a la consulta Juana de 7 años, traída por sus padres por presentar fiebre (38,7oC) de 48 horas de evolución, cefalea frontal intermitente que ha empeorado en las últimas 12 horas, fotofobia y vómitos.

Antecedentes: Desarrollo neuromadurativo acorde, escolaridad cursa segundo grado sin dificultad. Presentó varios episodios broncoobstructivos todos de manejo ambulatorio, utiliza desde los 5 años medicación controladora. Carnet de vacunas: Hepatitis B x , BCG x , Pentavalente xx, Salk x, Antineumocócica conjugada x, Antirotavirus x, Antimeningocócica x.

Examen físico: Peso 27.0 kg, T 37oC. Regular estado general, normohidratada, en suficiencia cardiorrespiratoria. Frecuencia cardíaca 105 latidos/minuto, frecuencia respiratoria 20 respiraciones/minuto. Auscultación respiratoria buena entrada de aire bilateral. Glasgow 15/15, cefalea y fotofobia. Signos de Kernig y Brudzinski positivos. Marcha inestable. Diuresis y catarsis conservada. Durante el examen físico, presenta episodio emético.

De acuerdo a la sospecha diagnóstica, cuáles son las conductas diagnósticas más adecuadas? (Puede marcar hasta 3 opciones):

- A. Resonancia de cerebro.
- B. Antibióticos parenterales empíricos.
- C. EAB, ionograma, urea, creatinina, amilasa, lipasa, hepatograma. Internación.
- D. Prueba de tolerancia oral y observación en guardia.
- E. Antibióticos luego de recibir el resultado de los cultivos.
- F. Hemograma, glucemia, PCR, 2 hemocultivos, punción lumbar.
- G. Seguimiento ambulatorio en 24hs con analgésicos y antieméticos.

2. Maia de 18 meses de vida fue llevada hace 48 horas a una guardia por ambos padres muy angustiados porque presentó un primer episodio de convulsión de aproximadamente 5 minutos de duración. No hay antecedentes familiares.

Al examen físico inicial, se encontraba dormida y febril (38,3°C). Los padres previamente al episodio convulsivo le habían administrado ibuprofeno porque tenía fiebre (39,2°C). Luego de 20 minutos se despertó, en buen estado general, reactiva, conectada. El examen físico fue normal.

Antecedentes: Se trata de una niña previamente sana, como interurrencias solamente presentó una laringitis a los 6 meses de vida. Carnet de vacunación: completo.

En ese momento el pediatra de guardia decidió indicarle antitérmicos, pautas de alarma y control su médico de cabecera.

Los padres de Maia lo consultan a Ud. 2 días después, persiste febril hasta anoche y hoy al mediodía observaron que tenía unas manchitas en la piel.

Al examen físico se encuentra en buen estado general, afebril, vigil, reactiva, conectada, fauces y oídos levemente congestivos. Se observan máculas rosadas generalizadas a predominio de tronco que desaparecen a la vitropresión. Resto del examen físico s/p.

Pregunta: De acuerdo a todos los datos aportados, Ud decide: (Marque hasta 3 opciones)

- A. Realizar hemograma, eritrosedimentación, proteína C reactiva.
- B. Realizar 2 hemocultivos y punción lumbar para citoquímico, cultivo y virológico.
- C. Luego de la toma de cultivos, iniciar tratamiento con Ceftriaxone 100 mg/kg EV.
- D. Internación hasta obtener resultados de cultivos.
- E. Solicitar imagen de cerebro.
- F. Explicar a los padres que impresiona una infección banal posiblemente causada por el virus Herpes 6.
- G. Solicitar electroencefalograma.
- H. Indicar diazepam para prevención de próximos episodios convulsivos.
- I. Dar pautas de alarma y seguimiento ambulatorio.
- J. Explicar a los padres que el episodio convulsivo que presentó no generará secuelas neurológicas.

3. Ud. recibe en la guardia de un hospital provincial a Pascual, de 3 meses de edad, quien ha presentado en su domicilio un episodio convulsivo de aproximadamente 20 minutos de duración, según refiere la mamá.

Pascual está con fiebre desde ayer y hoy, antes de la convulsión, tenía 39°C.

Al examinarlo, Ud. constata que Pascual persiste febril, está letárgico y responde escasamente a los estímulos.

La mamá le informa que un hermano de Pascual, de 18 meses, recibe tratamiento con anticonvulsivantes por haber presentado una convulsión febril a los 8 meses de edad.

Pascual ha sido hasta el momento un bebé sano y tiene las vacunas correspondientes a su edad.

Con los datos hasta aquí mencionados, usted, ¿qué decide? Marque 3 opciones

- A. Indicarle a la mamá diazepam para que se lo administre en los próximos episodios febriles.
- B. Efectuar en forma inmediata una punción lumbar.
- C. Internar a Pascual
- D. Considerar que Pascual ha tenido una convulsión febril típica
- E. Dejarlo en observaciones en guardia para bajarle la fiebre y enviarlo a su domicilio cuando la misma ceda.
- F. Tramitar de urgencia un electroencefalograma
- G. Administrar lo antes posible una dosis de ampicilina por vía endovenosa
- H. Administrar lo antes posible una dosis de ceftriaxona por vía endovenosa.

4. Facundo de 18 meses de edad llega a la consulta con sus padres, tras haber presentado en su domicilio, un episodio de convulsión generalizada de dos minutos de duración con desconexión del medio y recuperación posterior de la conciencia. Los padres comentan que Facundo tenía temblores, se agitaba y ponía los ojos en blanco. Llevaba 12 horas con fiebre 38°C, tos y congestión nasal.

La gestación y el parto fueron normales. Apgar 9/10, peso al nacer, 3300g, talla 50cm. Test de pesquisa neonatal normal. Desarrollo psicomotor normal.

Se alimentó con leche materna exclusiva hasta los 5 meses. Actualmente, tiene una alimentación variada, sin inconvenientes. Inmunizaciones completas según calendario.

Antecedentes familiares. El padre refiere convulsiones en la infancia y epilepsia en un tío paterno. Examen físico: peso 11kg. Talla 82cm. Temperatura 38.2°C

Regular estado general ojeroso, decaído, mucosa oral pastosa, color normal de piel y de mucosas, sin exantemas ni petequias. Buena nutrición y perfusión. ORL: faringe algo congestiva. Otoscopia: ambos tímpanos congestivos. No se visualiza triángulo luminoso. Examen cardiopulmonar. Abdomen blando. Depresible. No es doloroso. No se palpan masas ni visceromegalias. Examen neurológico: Facundo se encuentra consciente, reactivo. El tono y fuerza musculares, marcha, reflejos osteotendinosos, pares craneales, son

normales. Signos meníngeos negativos. Los padres se muestran muy angustiados y preguntan si su hijo ha tenido una crisis epiléptica y cual es su tratamiento.

Con relación al problema de Facundo, Ud, ¿qué conductas considera mas apropiada? Marcar hasta 3 opciones.

- A. Administrar con urgencia una dosis de ceftriaxona EV
- B. Internar a Facundo
- C. Informar a los padres que la aparición de una convulsión, ocurre solo con temperaturas elevadas.
- D. Controlar a Facundo en forma ambulatoria**
- E. Efectuar lo antes posible un estudio de imagen cerebrales
- F. Informar a los padres que la resolución espontanea es la evolución habitual**
- G. Informar a los padres que Facundo ha presentado una crisis epiléptica
- H. Informar a los padres que el desarrollo neurológico e intelectual de Facundo será normal**

5. Usted es pediatra de guardia de un hospital general del conurbano bonaerense. Consultan Laura y Martin con su hijo Bautista de 4 meses y medio de vida. Motivo de consulta: fiebre de 39°, vómitos, rechazo del alimento y somnolencia de 24 horas de evolución.

Bautista es el primer hijo de la pareja, sin antecedentes personales ni familiares a destacar. Se alimenta con lactancia materna y complemento con fórmula de inicio.

Vacunas: BCG, Hepatitis B, 2 dosis de vacuna conjugada 13 valente para neumococo, 2 dosis pentavalente, 2 dosis de polio (IPV) y 2 dosis de rotavirus, 1 dosis de meningococo ACYW135.

Examen físico: temperatura axilar 40°, en mal estado general, depresión del sensorio marcada, relleno capilar 5 segundos, frecuencia cardiaca 150 por minuto, tensión arterial 60/30 mmHg . Examen neurológico: hiporreflexia osteotendinosa, letargo, estrabismo derecho, anisocoria y fontanela anterior bombé. Durante la evaluación presenta una convulsión tonico-clónica generalizada que cede con medicación y aparecen lesiones máculas rojizas que no desaparecen a la vitropresión.

Ante esta situación, cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? Marcar hasta 3 opciones.

- B. Solicitar en este momento, TAC de cerebro
- C. Solicitar inmediatamente dos hemocultivos, y hemograma, coagulograma, glucemia interno y PCR
- D. Indicar impregnación con difenilhidantoína
- E. Solicitar derivación urgente a un hospital especializado en atención pediátrica
- F. Colocar oxígeno**
- G. Dexametasona EV y antibioticos EV**
- H. Realizar en este momento punción lumbar para diagnóstico y tratamiento
- I. Realizar expansión con solución fisiológica**

7. Alexis de 18 meses es traído a la guardia presentando una convulsión tónico clónica generalizada. Usted implementa las primeras medidas y la convulsión cede en 2 minutos aproximadamente. Los padres están muy asustados y relatan que su hijo es sano, y nunca había presentado un cuadro así. Le cuentan que hace unas 6 horas comenzó con fiebre, y que lleva unos 5 minutos con la crisis.

Usted realiza un examen físico minucioso y encuentra: temperatura axilar 38,3°C, rinitis serosa, fauces congestivas, en la otoscopia se ven los tímpanos congestivos, el resto del examen físico es normal Alexis evoluciona bien, y tras permanecer en observación un par de horas es dado de alta.

¿Cuáles son las indicaciones más adecuadas? (Marque hasta 3 opciones)

- A. Solicita EEG y evaluación por neurología durante la semana próxima.
- B. Indica diazepam vía oral mientras dure la fiebre.
- C. Indica paracetamol a 10 mg/kg/dosis si continua con fiebre o tiene otalgia.
- D. Explica que este episodio no deja secuelas neurológicas.
- E. Indica combinar paracetamol e ibuprofeno cada 4 horas.
- F. Indica tratamiento de la otitis con amoxicilina vía oral a razón de 80-90 mg/kg/día.
- G. Indica tratamiento con fenobarbital.
- H. Explica que en general este episodio no requiere estudios complementarios.

8. Mariana de 15 meses de edad es traída a la guardia por su madre muy preocupada dado que la niña mientras estaba durmiendo, grito y presentó sacudidas de brazos y piernas, con desviación de los ojos hacia arriba. Este episodio según refiere la mama tuvo una duración de aproximadamente de 10 minutos. Al ingreso la niña se encontraba dormida, pálida, hipotónica, con escasa respuesta a estímulos y febril (38,5 °C) con catarro de vías aéreas superiores sin otros signos relevantes al examen físico.

¿Cuáles son las conductas iniciales más correctas? (Marque hasta 3 opciones)

- A. Asegurar vía aérea permeable y administrar oxígeno.
- B. Indicar tratamiento con diazepam vía rectal.
- C. Colocar una vía venosa y administrar lorazepam endovenoso
- D. Indicar antitérmicos.
- E. Realizar una prueba rápida para glucemia capilar.
- F. Indicar antibióticos empíricos parenterales.
- G. Colocar una vía venosa periférica de buen calibre.
- H. Realizar 2 hemocultivos y punción lumbar.

9. Ud. recibe a Leonel de 2 meses en la guardia, traído por su madre. Hace unas horas Leonel comienza con fiebre de 38° C que su madre intenta disminuir con un baño. Es la segunda hija de Claudia y Marcelo, ambos de 25 años que trabajan en un taller de costura,

cercano a su domicilio. Leonel y su otro hijo de 3 años permanecen junto a sus padres, en el mismo taller donde trabajan por 12 hs. Antecedentes perinatólogicos: recién nacido de término, EG 38 semanas con peso de nacimiento de 3000 grs. Serologías maternas: negativas. Antecedentes patológicos no refiere. El hermano y el padre se encuentran con catarro de vías aéreas superiores desde hace 3 días.

El último control del paciente fue hace un mes y estaba todo bien, refiere Alicia. Vacunas: BCG y Hepatitis B. Presentaba peso 4250 (Pc 25-50), talla 53,5 (Pc 25-50) y PC 37,5 (Pc 50) según consta en la libreta de salud.

Examen físico: llanto por intervalos, falta de fijeza en la mirada, mucosas semihúmedas, no sonríe, se duerme por momentos, pálido. Relleno capilar menor a dos segundos.

Frecuencia respiratoria 40 por minuto, sin tiraje. Buena entrada de aire bilateral sin ruidos agregados. Frecuencia cardíaca 136 por minuto. Se auscultan 2 ruidos en 4 focos, silencios libres. Abdomen depresible, blando, no se palpan visceromegalias. Temperatura axilar 37,6°C. La madre lo coloca al pecho a su pedido y se observa succión algo débil.

Con los datos que tiene hasta el momento, ¿cuáles de las siguientes conductas iniciales son las más adecuadas? (Marque hasta 3 opciones).

- A. Realizar orina completa, urocultivo, hemograma, Proteína C reactiva, 2 hemocultivos, punción lumbar.
- B. Indicar tratamiento antibiótico vía oral.
- C. Solicitar urgente resonancia magnética de cerebro.
- D. Internar al paciente.
- E. Con resultados de bajo riesgo de los estudios, indicar control ambulatorio en 24 hs.
- F. Solicitar en forma ambulatoria sedimento urinario y urocultivo y control en 24hs.
- G. Indicar antibioticoterapia endovenosa.
- H. Realizar urgente radiografía de tórax.

17. FIEBRE SIN FOCO

2. Nicolás tiene 42 días de vida. Concorre con sus padres a la consulta debido a que presenta un cuadro febril de 24 horas de evolución. Ellos se encuentran muy preocupados y refieren que Nicolás se alimenta con lactancia materna exclusiva cada 3hrs, viven a 3 cuadras del hospital. Usted realiza la anamnesis completa y el examen físico de Nicolás. No presenta antecedentes del embarazo ni perinatólogicos de importancia. Nació de término, con un peso de 3200gs. Regurgita ocasionalmente. Al momento del examen físico, Nicolás presenta 38.6°C, no presentando otros datos positivos ni foco infeccioso evidente. Se le realiza por guardia un laboratorio inicial con los siguientes resultados. Glóbulos blancos

21.000/mm³, NS 70%), L 30%, Hb 9.5gr/dl, plaquetas 240000/mm³. Proteína C reactiva 50 mg/l. Sedimento urinario normal Hemocultivos e urocultivos : pendiente resultados.

De acuerdo a su interpretación diagnóstica, cuales de las siguientes son las conductas inmediatas más adecuadas. Marcar hasta 3 opciones

- A. Indica cefalexina vía oral hasta recibir la lectura del urocultivo
- B. Realizar punción lumbar y medicar empíricamente con antibióticos por vía endovenosa**
- C. Indicar antitérmicos y antibiótico por vía oral
- D. Solicitar RX de tórax**
- E. Internar a Nicolás**
- F. Posponer punción lumbar de no mediar signos neurológicos y medicar urgente con antibióticos por vía endovenosa
- G. Dar pautas de alarma y enviar al domicilio regresando a control en 24 horas
- H. Medicar por vía intramuscular con antibióticos y control en 24hrs

18. PPB + EXANTEMÁTICAS

1. Concorre a la consulta Milena, una niña de 7 meses con tumefacción en el glúteo izquierdo de 6 días de evolución y fiebre desde hace 48-72 horas. Al revisar el carnet de vacunación se evidenció esquema incompleto, ya que faltaban las vacunas del sexto mes. No hay antecedentes de lesiones dermatológicas en convivientes.

En el examen físico la niña se encuentra lúcida, febril, eutrófica, con tumoración roja caliente de bordes difusos y centro fluctuante en la región superior del glúteo izquierdo. El resto del examen es normal. Se solicita hemograma con recuento de leucocitos, 29.600/mm³ (neutrófilos, 73%; linfocitos, 24%; eosinófilos, 1%; monocitos 2%), hematocrito 32%; velocidad de sedimentación globular (VSG) de 60 mm/h y proteína C reactiva de 48 mg/l.

Ante este cuadro clínico, ¿cuáles son los enunciados más adecuados? (Marque hasta 3 opciones).

- A. Está recomendado la decolonización del paciente.
- B. Se debe indicar antibioticoterapia EV con penicilina.
- C. El cuadro clínico de la niña es compatible con erisipela.
- D. Está recomendado la decolonización familiar.
- E. Se debe indicar antibioticoterapia E.V. con clindamicina.**
- F. El tratamiento primario es la incisión y el drenaje.**

G. El agente posible de este cuadro es el estreptococo pyogenes y/o estafilococo aureus.

H. El agente etiológico más frecuente es el Haemophilus tipo B.

2. Consultan a la guardia los padres de un niño de 5 años, Jerónimo, por lesiones cutáneas de reciente aparición, pruriginosas y que desaparecen después de unos minutos y aparecen nuevamente en otros lugares del cuerpo. Es la primera vez que le ocurre. En la cena comió fideos con crema y manzana de postre. Antes había concurrido a la escuela donde jugó con plastilinas y realizó clase de educación física.

Al examen físico usted ve lesiones eritematosas, maculopapulares en tronco extremidades y cara. Se auscultan sibilancias bilaterales sin otros ruidos agregados. La TA es de 95/60 mm/Hg y la frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto. Temperatura axilar 36,7 grados.

Ante este cuadro, ¿cuáles de las siguientes conductas son las más apropiadas en este primer momento (primeros 5 minutos)? (Marque hasta 3 opciones)

- A. Colocar oxígeno y venoclisis.
- B. Indicar corticoides por vía oral.
- C. Indicar serie de salbutamol inhalatorio.
- D. Realizar control ambulatorio en 24 horas.
- E. Indicar adrenalina intramuscular.
- F. Indicar corticoides endovenosos.
- G. Dejar en observación al paciente para control clínico.
- H. Indicar antihistamínicos por vía oral.

3. Concorre a la guardia José de 12 años de edad que consulta por dolor exquisito y puntual en una zona ubicada en el 1/3 inferior del muslo derecho e impotencia funcional y fiebre durante las últimas 48 horas. Como antecedente refiere haber sufrido un traumatismo hace 7 días jugando al fútbol. En el examen físico se observa área de tumefacción con una lesión en piel del 1/3 inferior del muslo derecho, cubierta actualmente por una costra hemática, evaluación de la articulación de la rodilla normal. Laboratorio: Hemograma: 16800/mm³ leucocitos (80% NS 35-60, 3% NC 0-5%, 10% L, 7% M), hemoglobina 12,4 gr/dl, plaquetas 550.000/mm³, eritrosedimentación 80 mm/h, PCR 60 mg/l. Radiografía de ambos miembros inferiores comparativa sin lesiones óseas.

Pregunta: Además de indicar analgesia, de acuerdo a su diagnóstico presuntivo, cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? (Marque hasta 3 opciones)

- A. Intención, 2 hemocultivos y tratamiento antibiótico endovenoso
- B. Control ambulatorio en 48 hs y tratamiento con cefalexina, vía oral
- C. Inmovilización, analgesia y control ambulatorio en 48 horas
- D. Solicitar resonancia magnética de miembro.
- E. Solicitar ecografía de partes blandas.

- F. Solicitar tomografía computada del miembro.
- G. Toma de cultivo por piel sana de la costra.
- H. Solicitar centellograma corporal total.
- I. Exploración quirúrgica de urgencia.
- J. Solicitar CPK y Aldolasa

4. Santino, de 5 años, es traído al consultorio debido a haber presentado manchas en la piel que comenzaron 24hs antes de la consulta. La madre relata que las “manchas” comenzaron súbitamente como máculas rosadas y pruriginosas, distribuyéndose de manera asimétrica y generalizada. Estas lesiones tienen tendencia a confluir y formar placas eritematosas. Además se acompaña de intenso prurito. El niño se encuentra afebril y en buen estado general. Diuresis conservada de características normales.

Como antecedentes personales importantes se destacan los siguientes: Dermatitis atópica. Gastroenteritis aguda en 2 oportunidades de manejo ambulatorio. Broncoespasmos frecuentes (un episodio con internación). Vacunas completas para la edad. Actualmente se encuentra en tratamiento con amoxicilina en 7o día, por episodio de otitis media aguda (ya ha tenido en otra oportunidad en el invierno pasado tratada con el mismo antibiótico). Y en el día de hoy presenta otoscopia normal.

Pregunta: Teniendo en cuenta su hipótesis diagnóstica, cuáles son las conductas más apropiadas? (Marque hasta 3 opciones)

- A. Solicitar serología para rubéola.
- B. Indicar talco mentolado 2 veces por día.
- C. Tranquilizar a la madre explicando que es una situación transitoria y benigna.
- D. Solicitar hemograma y dosaje de inmunoglobulinas (GAME).
- E. Indicar antihistamínicos.
- F. Excluir al niño del jardín hasta la desaparición total de las lesiones.
- G. Realizar denuncia epidemiológica a la autoridad sanitaria local.
- H. Suspender tratamiento antibiótico.
- I. Solicitar hisopado de fauces.
- J. Indicar aciclovir crema y vía oral.

5. Isabel concurre a la consulta con su hijo Mauricio de 5 años de edad quien presenta lesiones compatibles con varicela desde hace 24 hs. Ella le comenta que en el jardín donde asiste se han presentado varios casos. La madre de Mauricio está sorprendida porque su hijo había recibido una dosis de vacuna antivariola a los 3 años. Además está muy preocupada porque ella no sabe si tuvo varicela y está embarazada de término. Tiene otro hijo, Nicolás, de 7 años, que no recibió dicha vacuna y se encuentra en remisión de una LLA (Leucemia Linfoblástica aguda) hace 18 meses.

**Pregunta: Con los datos presentados, ¿cuáles son las opciones más apropiadas?
(Marque hasta 3 opciones)**

- A. Indicar cultivo del contenido de las lesiones.
- B. Mauricio seguramente cursará una varicela leve , ya que recibió vacuna.**
- C. La madre debe recibir la vacuna antivariola como profilaxis post exposición.
- D. Si Isabel padeciera varicela perinatal, el recién nacido deberá recibir gammaglobulina específica.**
- E. De haber recibido la vacuna a los 15 meses, se hubiera evitado que Mateo se enfermara de varicela.
- F. Nicolás debe recibir vacuna como profilaxis post exposición.
- G. Nicolás debe recibir gammaglobulina por ser un inmunodeprimido.**
- H. solicitar serologías específicas para varicela.
- I. Excluir al niño del hogar.
- J. Es de suma importancia, informar al colegio la necesidad de proceder al cierre del jardín para efectuar la desinfección y evitar nuevos casos.

6. Ud. se encuentra de guardia en un Hospital cuando Celeste, de 8 meses de edad, llega a la consulta por fiebre y una tumefacción en el muslo izquierdo de 6 días de evolución. Según refiere la madre, 12 días antes de la consulta, la niña presentaba rinorrea serosa y fiebre, por lo que consultó en un centro de atención primaria, donde se le indicó dipirona intramuscular.

Tres días después, como continuaba con fiebre y tos, realizó una nueva consulta. En esa ocasión, se le iniciaron nebulizaciones con solución fisiológica, ibuprofeno y amoxicilina a dosis habituales. Luego permaneció afebril hasta el día de ayer. No refiere antecedentes personales ni familiares de importancia. Carnet de vacunas completo. Examen físico: regular estado general, temperatura axilar 39°C, pálida, mucosas semi-húmedas. Buena entrada de aire bilateral, sin ruidos agregados,

- A. Solicitar hemocultivos y toma para cultivo de la lesión**
- B. Indicar Trimetoprima-Sulfametoxazol vía oral y control en 24hs
- C. Solicitar hepatograma, glucemia, urea y creatinina.
- D. Solicitar interconsulta con Cirugía para drenaje**
- E. Solicitar radiografía de miembro inferior izquierdo
- F. Indicar internación y tratamiento con Ceftriaxone endovenoso
- G. Indicar internación y tratamiento con Clindamicina Endovenosa**
- H. Indicar Cefalexina VO y control según evolución clínica.

7. Julián de 15 meses de vida es el primer hijo de la pareja de Gimena y Marcelo. Nació por cesárea con 3.550 gramos a las 39 semanas de gestación.

Gimena, tiene 23 años y es ama de casa. Refiere que tiene rinitis alérgica y no fuma. Tiene ambos padres vivos y un hermano mayor con diagnóstico de psoriasis. Marcelo, tiene 30 años, refiere ser sano, fuma 15 cigarrillos diarios de tabaco y trabaja como empleado en una aseguradora. Viven en un departamento de 2 ambientes en el barrio de Pompeya.

Julián ha tenido exantema súbito a los 6 meses de edad y varicela a los 9 meses con buena evolución en ambas enfermedades. Los padres refieren que Julián tiene las vacunas del calendario oficial completas.

El niño presenta exantema priginoso en miembros. Al examen físico usted constata lesiones eritematoescamosas en piel de la región de extensión de miembros superiores, inferiores y en mejillas (ver imagen). No hay lesiones en la zona del pañal. Presenta lesiones de rascado en las áreas afectadas. La piel del tronco es seca con descamación fina.

Ante este cuadro, ¿cuáles son las indicaciones más adecuadas? Marque 3 opciones

- A. Antihistamínicos vía oral
- B. Permetrina crema al 5% a toda la familia
- C. Tratamiento tópico con Micomazol
- D. Tratamiento tópico con corticoides
- E. Humectación diaria de la piel
- F. Realizar pruebas cutáneas con alérgenos
- G. Suspender tomates, frutilla, chocolates y pescados de la dieta
- H. Metilprednisolona 1mg/kg/día vía oral

8. Consultan en la guardia los padres de Juan de 5 años, por lesiones cutáneas de reciente aparición, pruriginosas y que desaparecen después de unos minutos y aparecen nuevamente en otros lugares del cuerpo.

Es la primera vez que le ocurre. En la cena comió fideos con crema y manzana de postre. Antes había concurrido a la escuela. Jugó con plastilinas y realizó clase de educación física.

EXAMEN FÍSICO se observan lesiones en eritematosas, maculopapulares en tronco extremidades y cara. No se auscultan sibilancias, ni otros ruidos respiratorios. La TA es de 90/55 (80-120/50-80)mm/Hg y la frecuencia cardíaca de 80 latidos por minutos (90 - 120). Temperatura axilar 36,7 grados.

Ante este cuadro, ¿cuáles son las conductas más apropiadas? Marcar hasta 3 opciones.

- A. Realizar control ambulatorio
- B. Indicar corticoides endovenosos
- C. Indicar adrenalina intramuscular
- D. Contraindicar chocolates, frutillas, naranja y quesos hasta solución del cuadro.
- E. Indicar corticoides por vía oral durante 4 días
- F. Explicar que es el comienzo de una enfermedad recurrente que requerirá de estudios.
- G. Indicar antihistamínicos por vía oral
- H. Internar al paciente para control durante al menos 24 horas
- I. Explicar que es una enfermedad en general autolimitada
- J. Colocar venoclisis

11. Concorre a la consulta Rita con su hija Ornella de 7 meses que asiste a un jardín maternal y debió ausentarse al mismo por presentar fiebre alta de 39-40°C en las últimas 72 hs. Fue tratada con Ibuprofeno y medios físicos.

Refiere estar preocupada porque si bien la fiebre ha desaparecido totalmente, y se encuentra en mejor estado general, en la mañana presentó una erupción que comenzó en tórax y se fue extendiendo a cara, abdomen y en menor intensidad en extremidades.

Examen físico: Peso 6.700 grs. (Pc 25). Talla: 65.0 cm (Pc 25-50). Buen estado general, afebril. Fauces ligeramente congestivas. Aparato respiratorio: Escasa secreciones serosas en fosas nasales. Frecuencia respiratoria 40 por minuto, murmullo vesicular conservado, no se auscultan ruidos agregados. Aparato cardiovascular: Frecuencia cardíaca 120 latidos por minuto, 2 ruidos en cuatro focos, silencios libres. Otoscopía: tímpanos congestivos, triángulo luminoso conservado. Presenta un exantema micropapular diseminado rosado, no pruriginoso, que desaparece a la vitropresión.

De acuerdo a su/sus diagnósticos presuntivos, indique las conductas más adecuadas. (Marque hasta 3 opciones)

- A. Indicar Aciclovir por vía oral durante 7 días.
- B. Indicar Penicilina oral 50.000 U/Kg peso/día durante 10 días.
- C. Indicar pautas de alarma y eventual control clínico en 48hs.
- D. Indicar qué puede asistir al jardín al desaparecer el exantema.
- E. Solicitar exudado de fauces.
- F. Indicar antihistamínicos vía oral por 3 días.
- G. Indicar reposo, hidratación adecuada y baño habitual.
- H. Indicar Corticoides vía oral durante 72 horas.

14. Concorre a la consulta Carla con su hija Matilda de 5 años de edad, porque la niña presenta una erupción cutánea. El cuadro comenzó hace 72 hs con rinitis serosa, febrícula, cefalea y posteriormente se agrega un exantema en cara, miembros, tronco y abdomen. Matilda es una niña sana, con inmunizaciones completas. Concorre a preescolar con adecuado rendimiento e integración al grupo de compañeros. Refiere la madre que informó al colegio acerca del estado de su hija y la maestra le comenta que hace 1 semana una compañerita de la sala no asiste por una enfermedad eruptiva. Examen físico: niña eutrófica, en buen estado general, afebril, que presenta exantema eritematoso máculo papular en tronco y abdomen. En la región de la cara presenta marcado eritema en ambas mejillas que se exacerba por las noches en la cama y con el baño diario. En ambos miembros superiores presenta eritema reticulado 'en encaje que remite y reaparece por brotes. Resto del examen, sin datos a destacar.

De acuerdo a los datos disponibles, indique las conductas más adecuadas. (Marque hasta 3 opciones)

- A. Indicar penicilina vía oral hasta el resultado del exudado.

- B. Comunicar que se trata de un megaloeritema o quinta enfermedad.
- C. Comunicar que en este momento ya no contagia.
- D. Interrogar y asesorar acerca del contacto de Matilda con embarazadas.
- E. Informar a la madre que se trata de una alergia e indicar dieta hipoalergenica
- F. Comunicar que se trata de una escarlatina
- G. Comunicar que se trata de la sexta enfermedad
- H. Solicitar exudado de fauces (cultivo y test rápido).

19. GINECO INFANTOJUVENIL

1. Niña de 3 años que consulta acompañada por su madre alarmada por la presencia recurrente de prurito vulvar y flujo que mancha la ropa interior de la pequeña, con rascado muy frecuente del área vulvar y anal. Recibió tratamiento local en dos oportunidades. La niña no presenta antecedentes personales de importancia. La madre fue tratada recientemente con óvulos vaginales. La niña concurre al jardín desde este año con buena adaptación y realiza colecho eventual con los padres.

Al examen presenta: Enrojecimiento de labios mayores, hiperemia de labios menores e introito, himen íntegro y se observa flujo vaginal blanco-amarillento. Además, se observan lesiones de rascado en el área perianal.

**De acuerdo con su diagnóstico presuntivo, ¿cuáles son las conductas correctas?
(Puede marcar hasta 3 opciones)**

- A. Solicitar evaluación por servicio social.
- B. Realizar vaginoscopía.
- C. Solicitar Test de Graham.
- D. Indicar baños de asiento con Malva.
- E. Recomendar uso de ropa interior de algodón y dar pautas de higiene.
- F. Toma de muestra para Gonococo y Chlamydia.
- G. Indicar crema local con clotrimazol.
- H. Solicitar evaluación por psicología.

2. Juliana de 15 años concurre a la consulta acompañada por una amiga de la misma edad, está de novia hace unos meses e inicio relaciones sexuales con su novio de 17 años. Usa preservativo como método anticonceptivo y quiere saber cómo cuidarse mejor. Concorre a la escuela secundaria, practica hockey. Sus padres están separados y vive con su mamá y su hermana menor.

En cuanto a los antecedentes personales, refiere consumo de alcohol sólo los fines de semana en fiestas. Alimentación variada. Ocasionalmente presenta cefaleas tensionales y

padece de asma intermitente leve.

Antecedentes ginecológicos, menarca a los 12 años, duración de ciclos: 30 días, duración del periodo menstrual 5 días, acompañado de dismenorrea leve. FUM hace 15 días. Como antecedentes familiares, refiere que su madre es hipotiroidea, su padre tiene colesterol aumentado y la abuela materna fue operada por cáncer de mama.

Examen físico: normal. IMC: 20,86. TA 100/60 mmHg. Examen mamario normal. Examen genital: escaso flujo vaginal blanquecino.

¿Cuáles son las recomendaciones más adecuadas? (Marque hasta 3 opciones)

- A. **Indicar a Juliana ACO de etinilestradiol + gestágeno.**
- B. Contraindicar ACO por el antecedente de cefaleas.
- C. Solicitar hemograma, hepatograma, lipidograma, coagulograma y ecografía ginecológica.
- D. Recitar a Juliana acompañada de un adulto responsable para brindarle asesoramiento sobre MAC.
- E. **Reforzar que Juliana continúe con el uso de preservativo.**
- F. Indicarle ACO de progestágenos solos.
- G. Contraindicar el uso de ACO debido al antecedente de cáncer de mama de su abuela.
- H. **Explicar a Juliana anticoncepción de emergencia.**

Con respecto a la administración de anticonceptivos orales (ACO) en esta paciente, ¿qué le indica a Sabrina? Marcar hasta 3 opciones.

- A. Recitar a Sabrina acompañada de un adulto responsable para brindarle asesoramiento sobre ACO.
- B. Las cefaleas que padece son contradicción para el uso de ACO.
- C. Solicitar hemograma, hepatograma, lipidograma, coagulograma y ecografía ginecológica antes de iniciar ACO.
- D. **Advertirle que existe riesgo de embarazo en la primera semana de uso, y aumenta con el número de pastillas olvidadas.**
- E. Anticiparle que los ACO pueden interferir en su crecimiento e provocar acné.
- F. Indicarle ACO de progestágenos solos para evitar el desarrollo de hipertensión arterial.
- G. Aconsejarle interrumpir por uno o varios meses la toma de ACO a modo de descanso, luego de un año de uso
- H. **Indicarle ACO con 30 mcgr de etinilestradiol + gestágeno y refuerza continuar con el uso de preservativo.**
- I. No considera que Sabrina inicie con ACO como primera opción debido al antecedente de cáncer de mama de su abuela.
- J. **Advertirle a Sabrina sobre la posible presencia de mastalgia, sangrado intermenstrual leve y ligero incremento de la tensión arterial como efectos colaterales reversibles de los ACO.**

6. Marcela de 14 años concurre a la consulta para obtener su certificado de aptitud física escolar. Como concurre sola no se pudo contar sus antecedentes perinatológicos, ni de su período de primera infancia. Cuenta que siempre fue sana y nunca estuvo internada. Es buena alumna aunque le aburre ir a la escuela. Participa en el equipo de Vóley del colegio con el que realiza además de actividad escolar, actividad física de entrenamiento (tres horas semanales) y partidos los fines de semana.

Tuvo su menarca hace 10 meses y aún no ha regularizado sus ciclos. Hizo una consulta con ginecología en esa oportunidad. Su última menstruación fue hace 52 días y eso la inquieta. No tiene pareja, se identifica como “mujer” y “cree que es heterosexual”. Tuvo relaciones sexuales dos veces con un compañero de clase. Usaron preservativo, aunque dice que una de las veces él se lo puso “antes de acabar”. Al día siguiente de esa relación realizó un test de embarazo que fue negativo y se tranquilizó “un poco”.

Tiene un peso en PC 50 y una talla en Pc 25-50. Trae carnet de vacunas completo. Tiene una discreta desviación de la columna que corrige cuando se le pide que se ponga en posición erguida. El resto del examen físico no presenta alteraciones.

Para este caso, ¿Cuáles son las conductas iniciales más adecuada? Marcar hasta 3 opciones

- A. Solicitar ecografía transvaginal
- B. Citar a la madre lo antes posible
- C. Indicar suplemento de Vitamina ACD y hierro
- D. Realizar hemograma, hepatograma, serología para VIH, Hepatitis B y C, VDRL
- E. Solicitar interconsulta con ginecología infanto-juvenil
- F. Solicitar dosaje de hormonas tiroideas
- G. Solicitar FSH, LH estradiol, DHEA
- H. Solicitar Rx de columna espinal frente y perfil
- I. Realizar dosaje de B-HCG
- J. Solicitar ECG, ecocardiograma y ergometría

20. FAMILIA, ABUSO, ACCIDENTES, ALCOHOL Y SALUD MENTAL

1. Milo, de 8 años, es traído por sus padres a la consulta por presentar dolor abdominal intermitente, de localización periumbilical, difuso, de 3 meses de evolución. Interfiere con sus actividades escolares, debiendo ser retirado en varias ocasiones de la escuela. Ha consultado en dos oportunidades a la guardia, donde le indican inicialmente dieta, fórmula con bajo contenido en lactosa y grasas. Como no mejoró le han indicado omeprazol y domperidona, sin resolución de los síntomas.

Milo se alimenta bien, las deposiciones son normales y está asintomático entre los episodios de dolor. Examen Físico: Peso: Pc 50-75; Talla: Pc 50-75, TA 90/60 mm/Hg. Abdomen blando, depresible, no doloroso en el momento del examen. No se palpan visceromegalias, ni masas abdominales. El resto del examen físico es normal.

Con los datos disponibles, ¿cuáles son las conductas iniciales más apropiadas? (Marque hasta 3 opciones)

- A. Solicitar ecografía abdominal.
- B. Es importante sostener la presencia de Milo en la escuela.
- C. Planificar una endoscopía digestiva.
- D. Solicitar interconsulta con salud mental.
- E. Solicitar interconsulta con gastroenterología infantil.
- F. Suspender la medicación.
- G. Citar a una entrevista con ambos padres en ausencia de Milo.
- H. Es conveniente que Milo no concurra a la escuela hasta establecer el diagnóstico.

2. Usted atiende en el sector de emergencias a Alan de 13 años, acompañado de su madre. Estando en una fiesta con amigos, le avisaron que se cayó porque se “descompuso”. Alan aparenta estar confundido y cuando lo quiere interrogar se torna agresivo y no colabora. Impresiona adelgazado, en regular estado general, sudoroso, con pupilas midriáticas. To axilar: 37.2 oC, Frecuencia cardíaca: 100 / minuto 70 -100, Frecuencia respiratoria: 20 por minuto. 13-15

Antecedentes: La madre refiere que desde hace 3 meses lo encuentra apático, no comparte charlas con sus hermanos, cambió de grupos de amigos y se torna agresivo cuando le ponen algún límite o quieren hablar con él por el bajo rendimiento en la escuela. Pasa muchas horas al día con la computadora y el teléfono.

Sociofamiliar: Sus padres están separados desde que él tenía 2 años y no tiene contacto con el padre. Su madre trabaja 8 hs al día en un negocio, y comenta que siempre le pide dinero para comprar comida y útiles. Tiene 2 hermanos, de 10 y 17 años, ambos escolarizados.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada? (Marque hasta 4 opciones)

- A. Solicitar intervención policial.
- B. Realizar punción lumbar.

- C. Indicar hidratación endovenosa.
- D. Inducir el vómito.
- E. Solicitar tóxicos en orina.
- F. Indicar lavado gástrico.
- G. Solicitar TAC de cerebro con contraste
- H. Solicitar EEG.
- I. Solicitar hemograma, urea, creatinina, EAB, ionograma, hepatograma, CPK.
- J. Realizar ECG / monitoreo cardíaco.

3. Inés concurre al centro de salud con su hija Lucía de 15 meses de edad. La mamá refiere que la niña come poco, es poco activa, llora mucho y desde hace 48hs presenta deposiciones desligadas.

Lucía es única hija, nacida de término, parto normal con peso de nacimiento de 2,300 Kg. Inés tiene 16 años, escolaridad primaria incompleta, vive con sus padres y 5 hermanos menores. El padre de Lucía está ausente. Vivienda: único ambiente, baño externo, colecho con la madre, agua de bomba, gas de garrafa. Lactancia materna hasta los 6 meses. La suspendió al enfermarse de gripe, luego leche de vaca. Lucía come poco del mismo plato de la mamá. Antecedentes: impétigo en 2 oportunidades, otitis y cuadros catarrales a repetición y 1 episodio de síndrome bronco obstructivo de tratamiento ambulatorio. Vacunación completa por referencia sin carnet. Neurológico: se para con apoyo, no da pasos con sostén ni camina sola.

Examen físico: Frecuencia cardíaca 110 latidos/min. Frecuencia respiratoria 28 respiraciones/min. Regular estado general, mirada triste, apática, irritable al examen, normohidratada en suficiencia cardio-respiratoria, eupneica, pulsos periféricos presentes, relleno capilar menor a 2 segundos. Se constata diuresis conservada y catarsis desligada.

Peso actual: 8,100 kg Pc 10, y Score Z: -1,3 ; Talla: 68 cm Pc < 3 y Score Z: -3,4.

Datos positivos: palidez cutáneo-mucosa, pelo escaso y fino con alopecia en la nuca, adenomegalias submaxilares pequeñas y móviles, escaso tejido celular subcutáneo, cicatrices residuales de impétigo en ambos miembros inferiores, abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, sin visceromegalias, ruidos hidroaéreos presentes. Laxitud ligamentaria y menor trofismo muscular. Resto del examen s/p.

¿Cuál sería su conducta inicial? Marque 3 opciones

- A. Citar a control ambulatorio con resultado de estudios solicitados
- B. Indicar suplementos alimentarios para recuperar peso
- C. Solicitar evacuación por servicio social
- D. Indicar dieta hiperhidrocarbonada
- E. Conectar a la mamá con el servicio de adolescencia
- F. Realizar la denuncia a consejo de niñas, niños y adolescentes
- G. Internar Lucía para realizar estudio
- H. Evaluar riesgo ambiental por convivientes fumadores en ausencia de la niña

4. Ingresa al servicio de emergencia, Josefina de 15 años, acompañada por una amiga desde “La Previa” de una fiesta de graduación. Ya avisó a la madre. La paciente presenta un discurso incoherente, aliento etílico, marcha tambaleante con aumento de la base de sustentación y resto de vómito alimentario en sus prendas. Signos vitales FC 100 latidos/minuto, TA 90/60 mmHg, T 35.7o C, Glucemia 60 mg/dl.

Al llegar la madre, nos cuenta que Josefina cursa 3er año de la secundaria con buen rendimiento escolar, hace deportes, tiene amigos y es una joven alegre. Refiere que nunca “hizo algo así”, y eso la angustia.

En este caso, ¿cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? Marcar hasta 3 opciones.

- A. Indicar plan de hidratación con suero dextrosado.
- B. Monitorear signos vitales, control de glucemia y solicitar tóxicos en orina.
- C. Solicitar resonancia magnética de cerebro.
- D. Solicitar la intervención del Servicio Social, por ser menor.
- E. Indicar carbón activado.
- F. solicitar eab, ionograma, glucemia, urea, creatinina, hepatograma.
- G. Solicitar interconsulta con Salud Mental.
- H. Indicar O2, realizar lavado gástrico y sonda nasogástrica abierta.
- I. Indicar expansión con solución fisiológica.
- J. Tranquilizar a la madre, explicando que todos los adolescentes tienen este tipo de conductas.

5. La mamá de Mariana, de 16 años, consulta preocupada porque ve a su hija muy delgada. “Dejó de hacer las actividades que solía hacer, no ve a sus amigas, no quiere hablar”. Mariana dice que le gustaría subir de peso pero no tiene hambre, se siente triste la mayor parte del tiempo y duerme mucho.
EXAMEN FÍSICO : se constata descenso de 6 kg con respecto al peso del año anterior. IMC 17. Menstruaciones regulares.

¿Cuáles de las siguientes son las conductas iniciales más apropiadas? Marcar hasta 3 opciones.

- A. Indicar tratamiento con paroxetina.
- B. Indicar suplemento polivitamínico
- C. Indagar sobre ideación suicida
- D. Solicitar interconsulta con nutrición.
- E. Indicar dieta hipercalórica.
- F. Solicitar laboratorio con hemograma, hepatograma, función renal, medio interno.
- G. Solicitar ecografía abdominal
- H. Solicitar internación en institución monovalente
- I. Solicitar interconsulta con salud mental
- J. Solicitar resonancia de cerebro.

6. Gastón de 18 meses de edad es traído a la guardia del hospital donde usted trabaja, porque fue encontrado en la habitación de su abuelo con varios frascos de pastillas abiertos. La madre refiere que le quitaron dos comprimidos, no identificables de la boca y hallaron 25 más desparramados por el piso. Al examen físico el niño se encuentra somnoliento, pero se puede despertar. Su temperatura es de 37 °C, la frecuencia cardíaca es de 160 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria es de 24 respiraciones por minuto. Tensión arterial de 66/34 mm de Hg, el resto del examen físico es normal.

Frente a esta situación, ¿cuál es la conducta inicial más adecuada? (Marque hasta 3 opciones)

- A. Indicar jarabe de Ipeca para rescatar los tóxicos.
- B. Solicitar tomografía de cerebro.
- C. Indicar pasar solución fisiológica hasta revertir la situación.
- D. Estabilizar la vía aérea colocando oxígeno con máscara al 100%.
- E. Colocar una vía periférica de buen calibre.
- F. Indicar una dosis de carbón activado.
- G. Indicar sulfato de Magnesio
- H. Realizar lavado gástrico para rescatar los tóxicos

8. La mamá de Marcela consulta preocupada porque ve a su hija, de 16 años, muy delgada. La nota más nerviosa, con algunos cambios de carácter. Marcela dice que le gustaría subir de peso a pesar de que come como siempre o más, se siente ansiosa y por momentos siente palpitaciones, calor y sudoración profusa. Le cuesta dormir. Menstruaciones regulares hasta hace 3 meses desde entonces no ha menstruado.

Al examen físico se constata descenso de 4 kg con respecto al peso del año anterior. IMC 17. Frecuencia cardíaca: 120 por minuto, presión arterial 135/65 mmHg. Pulso regular. Piel caliente, temperatura axilar 37,1 grados. Examen neurológico normal, se detecta temblor fino en ambas manos. Resto del examen físico sin particularidades.

¿Cuáles de las siguientes son las conductas iniciales más apropiadas? (Marque hasta 3 opciones)

- A. Solicitar laboratorio con TSH, T3 y T4 libre y anticuerpos antitiroideos.
- B. Solicitar interconsulta con nutrición.
- C. Solicitar consulta urgente con salud mental.
- D. Solicitar interconsulta urgente con endocrinología.
- E. Solicitar internación.
- F. Indagar sobre consumo de sustancias psicoactivas.
- G. Indicar dieta hipercalórica.
- H. Solicitar ecg y ecocardiograma.

9. Mirko, de 8 años, es traído por sus padres a la consulta por presentar dolor abdominal intermitente, localizado en hemiabdomen derecho, de 3 meses de evolución. Interfiere con sus actividades escolares, debiendo ser retirado en varias ocasiones de la escuela. Ha consultado en dos oportunidades a la guardia, donde le indican inicialmente dieta, fórmula con bajo contenido en lactosa y grasas. Mirko se alimenta bien a pesar de que lo notan más delgado, las deposiciones han presentado moco y sangre en algunas oportunidades.

Examen Físico: Peso: Pc 50 (pc 75 hace 4 meses); Talla: Pc 50-75 (igual que hace 4 meses), TA 90/60 mm/Hg. Abdomen blando, depresible, doloroso en el momento del examen en hemiabdomen derecho. No se palpan visceromegalias, ni masas abdominales. El resto del examen físico es normal.

Con los datos disponibles, ¿cuáles son las conductas iniciales más apropiadas? (Marque hasta 3 opciones)

- A. Indicar omeprazol y domperidona.
- B. Planificar una endoscopia digestiva.
- C. Solicitar hemograma, eritrosedimentación y PCR.
- D. Citar a una entrevista con ambos padres en ausencia de Mirko.
- E. Solicitar interconsulta con salud mental.
- F. Solicitar ecografía abdominal.
- G. Indicar internación.
- H. Solicitar interconsulta con gastroenterología infantil.

21. TEMAS VARIOS

Consulta por guardia Natalia quien trae a su hija Olivia de 4 años por presentar fiebre (38°C) de 24 hora de evolución y dolor que refiere en codo y hombro izquierdo desde hace aproximadamente una semana y cede con ibuprofeno a 10mg/kg/dosis. Sin antecedentes de importancia. Vacunas completas para la edad según calendario oficial. Concorre a jardín de infantes sala de 4 sin ninguna dificultad.

Examen físico: Buen estado general, febril (38.3°C), normo hidratada, palidez de mucosas, frecuencia cardiaca 125 lpm, frecuencia respiratoria 20 irpm, Saturación O2 97%. Diuresis conservada. Auscultación cardiaca: 2 ruidos en 4 focos, silencios libres, pulsos periféricos presente y conservados. Semiología cardiopulmonar y normal. Abdomen: blando depresivo indoloro, ruidos hidroareos positivos. Altura hepática 8cm, bazo palpable por debajo del reborde costal. Presenta en ambos miembros inferiores varias lesiones equimóticas y dolor en la articulación del codo y hombro izquierdo, sin signos de flogosis.

Teniendo en cuenta la anamnesis y el examen físico. Cuales son las hipótesis diagnósticas más adecuadas? Marcar hasta 3 opciones:

- A. Hemofilia
- B. Fiebre reumática
- C. Trombocitopenia inmune**
- D. Hepatitis autoinmune
- E. Osteomielitis
- F. Mononucleosis aguda**
- G. Leucemia linfoide aguda**
- H. Lupus eritematoso sistémico

Horacio y Ana traen a su consultorio por primera vez a su hijo Mario, de 3 años y medio de edad, para control. Mario es el primer hijo de un embarazo controlado. Nació a las 40 semanas de edad gestacional con 3500 gramos por parto vaginal con presentación cefálica. Lloró enseguida. Alta conjunta a las 48 horas con lactancia materna. Fue internado a la semana por mal progreso de peso y succión débil. Completó 10 días de tratamiento antibiótico parenteral con hemocultivos, urocultivo y cultivo de LCR negativos. Egresó a los 21 días de internación con alimentación enteral por sonda nasogástrica, que mantuvo durante tres meses.

Mario sostuvo la cabeza al 3° mes, se sentó a los 8 meses, no gateó y caminó a los 17 meses. No controla esfínteres.

Actualmente asiste a una sala de 3 años; los padres fueron citados porque hace muchos berrinches y habla muy poco.

Inmunizaciones: 1 dosis vacuna hepatitis B, 1 dosis vacuna BCG, 2 dosis vacuna inactivada para la polio, 2 dosis vacuna oral para la polio, 4 dosis vacuna DPT-HB-Hib, 3 dosis vacuna neumococo, 3 dosis vacuna meningococo, 1 dosis vacuna triple viral, 1 dosis hepatitis A y 1 dosis vacuna para la varicela.

Entre los antecedentes familiares: Horacio 41 años con aorta bicúspide, Ana 27 años con hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto diagnosticada después del nacimiento de Mario. Antropométricamente: Peso 20 kilos (>pc 97), talla 104 cm (pc 97), IMC mayor a pc 97 obesidad, perímetro cefálico 51 cm (pc 50). Signos vitales: Frecuencia cardíaca 120 por minuto, TA 90/60 mm/Hg, frecuencia respiratoria 16 por minuto, oximetría 97 % a aire ambiental.

Al examen físico: Buen estado general, pálido, muy poco colaborador. Abundante tejido celular subcutáneo con distribución central, sin acantosis. Boca con numerosas caries. Cifosis dorsal alta leve. No cicatriz de BCG. Cúbito valgo bilateral, lesiones por rascado en dorso antebrazo izquierdo, manos y pies pequeños. Pene 4 cm de longitud, ambos testículos pequeños en bolsas. Examen neurológico: pares craneales sin particularidades; trofismo, tono y fuerza muscular conservada en los cuatro miembros; reflejos osteo-tendinosos presentes; sin signos de foco ni meníngeos.

Pregunta: ¿Cuáles son sus conductas iniciales con este paciente? (Marque hasta 3 opciones).

- K. Indicar la BCG.
- L. Indicar primer dosis de vacuna oral atenuada contra rotavirus.
- M. Tranquilizar a los padres porque asume que el retraso madurativo está relacionado con la reciente mudanza e incorporación al jardín.
- N. Solicitar glucemia, perfil lipídico**
- O. Profundizar la anamnesis sobre el sueño de Mario**
- P. Solicitar una resonancia magnética de encéfalo
- Q. Solicitar interconsulta con servicio de Genética**
- R. Interconsulta a dermatología
- S. Interconsulta con ortopedia
- T. Indicar 100mg de metformina por vía oral cada 12hs

Mariana, paciente de 13 años, sin antecedentes patológicos relevantes, convive junto a sus padres y una hermana de 16 años en el Conurbano Bonaerense.

Concurre a la consulta, en el centro de atención primaria donde Ud. trabaja, acompañada por Sol, su tía. Sol manifiesta que, desde hace 6 meses, Mariana comenzó con alteraciones de conducta. Describe que su sobrina come compulsivamente, vomita al poco tiempo, se aísla, llora, y cree que estaría ingiriendo, por su propia voluntad diuréticos. Le encontraron esta medicación en su habitación. Mariana no se alimenta ni ingiere líquidos desde la tarde previa a la consulta.

Al momento de la consulta se nota débil, con poca colaboración, habla muy poco, por momento llora, tendiendo a dormirse. No presentó fiebre.

El examen físico muestra: enoftalmos, lengua seca y saburral, gingivitis, frecuencia cardíaca 139 latidos/min, frecuencia respiratoria 21 respiraciones/min, TA: 80/40 mmHg, pulsos débiles, relleno capilar 3 segundos. Sin signos meníngeos. Se observan petequias en cara. Abdomen sin características para destacar. Se encuentra oligoanúrica.

Frente a esta situación y en el contexto donde Ud. está trabajando, ¿cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? Marque 3 opciones.

- A. Solicitar dos hemocultivos
- B. Expandir con solución fisiológica**
- C. Solicitar su internación**
- D. Solicitar hemoglucotest (glucemia capilar)**
- E. Indicar metoclopramida
- F. Indicar Ceftriaxone y Aciclovir EV
- G. Expandir con solución dextrosada al 5%
- H. Indicar líquidos fraccionados y controlar en 6 horas

Marina, de 6 años de edad, llega a la consulta del servicio de emergencias, por presentar desde hace 5 días, intenso dolor abdominal periumbilical de 48 horas de evolución. Durante los últimos tres días se ha quejado de dolor en las rodillas y los tobillos. Desde la mañana de hoy, presenta dificultades para caminar.

La mamá de Marina, refiere que su hija se ha alimentado normalmente y no ha tenido episodios de vómitos. Las deposiciones son normales. La diuresis está conservada. Examen físico: Fauces discretamente congestivas, Abdomen blando, depresible. Discreto dolor a la palpación. No se palpan visceromegalias, Se encuentra afebril, Frecuencia cardíaca de 80 latidos/minuto, Frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, Tensión arterial 108/60 mm Hg, Se observa tumefacción en ambos tobillos y exantema eritematoso que no desaparece a la vitropresión, sobre elevado, en las extremidades inferiores.

No refiere otros antecedentes de importancia Presenta vacunas completas para la edad.

Con la información disponible, ¿qué exámenes complementarios son los más apropiados para indicar? Marque 3 opciones:

- A. Interconsulta con el Servicio de Ortopedia y Rraumatología
- B. Función renal y orina completa
- C. Hemograma con recuento de plaquetas
- D. Colagenograma
- E. Punción de medula ósea
- F. Exudado de fauces
- G. Coagulograma
- H. Anticuerpos antinucleares

Bruno de 5 años de edad, concurre con su mamá al Centro de atención primaria de su barrio porque según ella refiere, no le entran los zapatos de uso habitual. Comenzó 8 días antes con falta de apetito, malestar general, deposiciones desligadas y estornudos, por lo cual le administró ibuprofeno, sin una periodicidad fija. Nos cuenta que tiene los ojos un poco hinchados desde ayer, dolor alrededor del ombligo y que orina poco. Al examen físico presenta un peso en Pc 25 y talla en Pc 10, TA 85/60 mm/Hg (Pc 95 = 105/65), frecuencia cardíaca 88 latidos/minuto, frecuencia respiratoria 32 respiraciones/minuto y T° 36 oC, edema bpalpebral y pretibial con godet ++ y abdomen globuloso.

Actualmente se alimenta a predominio de carbohidratos, con poca ingesta de proteínas. Las vacunas refiere que están completas. Antecedentes familiares: 2 hermanos menores en tratamiento para escabiosis.

Exámenes complementarios iniciales: Hematocrito 28% , hemoglobinemia 9,3g/dl, Leucocitos 6500/mm³ (NS 42% E 3% B 0% L 55 %), Plaquetas 254.000/mm³, Urea: 75 mg/dl, Creatinina: 0,5 mg/dL, Proteínas Totales: 4,2 g/dL, Albúmina 2,3 g/dL, Colesterol 360 mg/dL hasta 200, TGP. 48 UI/l, .TGO. 32 UI/l., Bilirrubina total: 0,5 mg/dl, Bilirrubina directa: 0,2 mg/dl.

La ecografía abdominal es informada como normal. ECG sin particularidades. Radiografía de tórax dentro de límites normales. En orina: Proteinuria ++++ (+ de 500 mg/dL), hemoglobina +. El sedimento urinario: 0-3 leucocitos/campo hasta ,7-9 hematíes /campo . Hormonas tiroideas, cuyo resultado está pendiente. Pendientes también estudios para descartar enfermedad celíaca y síndrome de malabsorción.

Pregunta: Ante estos resultados, los razonamientos clínicos más adecuados son:
(Marque hasta 4 opciones)

- A. La hipoalbuminemia e hipercolesterolemia se deben a un déficit de síntesis hepática.
- B. La hipoalbuminemia se debe a un síndrome de malabsorción.
- C. El mixedema y urea elevada se deben a hipotiroidismo.
- D. La elevación de la urea se debe a un síndrome nefrítico secundario a la escabiosis de ambos hermanos.
- E. La eosinofilia confirma edema de etiología alérgica secundaria al antitérmico suministrado.
- F. La proteinuria asociada a hipoalbuminemia explica edemas
- G. La ecografía abdominal aleja la posibilidad de peritonitis primaria como causa del dolor abdominal
- H. El aumento de la urea se debe a concentración del volumen total
- I. La elevación de la urea se debe a disminución del volumen arterial efectivo circulante
- J. El laboratorio confirma una anemia

Concurre a su consultorio Elisa, madre primeriza de 20 años, con su hijo Tomás de 7 meses de edad. Antecedentes: recién nacido prematuro, de 32 semanas de edad gestacional. Permaneció en neonatología 45 días. No tuvo grandes complicaciones, inició alimentación con leche materna a los 7 días de vida, que hubo que cambiar a fórmula para prematuros por hipogalactia. En neonatología recibió vitaminas ACD, hierro y complemento.

Actualmente Elisa refiere que le cuesta que coma semisólidos por lo cual refuerza su alimentación con leche de vaca ya que no le alcanza el dinero para comprar la fórmula indicada. Al evaluar al paciente lo nota pálido, algo apático y levemente hipotónico. La curva de peso con respecto a controles realizados en otro centro muestran detención de la curva, encontrándose actualmente en percentilo 3.

Decide realizar un laboratorio ya que desde el alta de la unidad de neonatología no se le realizó ningún control. Recibe el laboratorio y en él observa en el hemograma ferritina sérica disminuida, glóbulos blancos normales, plaquetas normales, sideremia disminuida, porcentaje de saturación de la transferrina disminuido, capacidad total de saturación de hierro aumentada, hematocrito disminuido, reticulocitos normales.

Pregunta: Según estos resultados, cuáles son las conductas iniciales prioritarias?
(Marque hasta 3 opciones)

- A. Solicitar interconsulta con hematología.
- B. Recabar más datos sobre aporte de alimentos, hierro y vitaminas, dosis y duración.

- C. Indicar leche fortificada con hierro.
- D. Asumir el cuadro como anemia ferropénica por prematurez, hipoaporte y alimentación deficiente.
- E. Solicitar hemograma a la madre.
- F. Realizar medulograma.
- G. Solicitar sangre oculta en materia fecal.
- H. Indicar hierro en forma intramuscular hasta evaluar causa.
- I. Indicar hierro 3 a 6 mg/kg/día y reforzar cambios en la alimentación.
- J. Asumir la hipotonía, apatía y detención de la curva de peso como cuadro relacionado a su prematurez y que deberá esperar a que realice su catch up.

Manuel, de 16 años, concurre con su papá al consultorio de Pediatría por una tumoración en la axila derecha, de 30 días de evolución, en ocasiones levemente dolorosa. Nunca tuvo fiebre. El padre le comenta que hace 15 días consultaron a un centro de salud cercano, donde le indicaron tratamiento oral con antibióticos que cumplió durante 10 días, pero que al no notar cambios, decidió volver a consultar.

Ellos viven en el conurbano, alquilan una habitación en un hotel familiar, baño y cocina compartidos. No tienen cloacas y agua de bomba. Tienen en la casa un gato. El padre refiere notar que bajó mucho de peso en los últimos 4-5 meses. Antecedentes de vacunación completa con cicatriz de BCG.

EXAMEN FÍSICO: buen estado general, afebril, en suficiencia cardiorrespiratoria; Peso: 50 kg (Pc 10), Talla: 166 cm (Pc 25-50). Se constata una tumoración axilar derecha, dura, algo dolorosa a la palpación, de 4 x 4 cm de diámetro aproximado, adherida a planos profundos, lo que limita moderadamente la movilidad del miembro superior derecho. No presenta otras adenomegalias, sí se palpan microadenopatías submaxilares e inguinales. Resto de examen físico sin otras particularidades.

Usted decide realizar estudios para la aproximación diagnóstica del cuadro de Manuel,

¿cuáles son los que solicita en un primer momento? Marcar hasta 4 opciones

- A. Centellograma corporal con tecnecio 99
- B. Punción – aspiración del ganglio axilar
- C. Radiografía de tórax de frente y perfil
- D. Radiografía comparativa de miembros superiores
- E. Centellograma con Galio
- F. Tomografía de tórax y abdomen
- G. Hemograma con frotis, eritrosedimentación, hepatograma
- H. Ecografía-doppler de axila derecha y abdomen
- I. Hemograma, urea, creatinina, ionograma

Thiago de 3 años de edad, reside en una zona periférica a un barrio privado del conurbano de la provincia de Buenos Aires, vivienda familiar precaria de un solo ambiente con agua de pozo y baño con descarga, sin antecedentes patológicos de importancia, con vacunas completas para la edad. Es el 6to hijo de 7 hermanos, el padre Cartonero, recoge desechos de los barrios lindantes y a veces Thiago lo acompaña.

Thiago, sin antecedentes patológicos de importancia y con las vacunas completas para la edad, en el último mes, ha comenzado con un cuadro clínico de distensión y dolor abdominal asociado al hábito de geofagia con vómitos alimentarios esporádicos y tos. En las últimas 72 horas el dolor abdominal se hizo más intenso. Llega a la consulta por guardia.

Al momento de su ingreso, el paciente presentaba los siguientes signos vitales: Presión arterial 96/71 mm Hg; frecuencia cardíaca 110 latidos/minuto; frecuencia respiratoria 25 respiraciones/minuto 15-25; temperatura 36,2°C; SpO2 95% AA. Datos antropométricos: peso 13kg; talla 95 cm; IMC 14kg/m2. Valoración nutricional según parámetros de la OMS: T/E= entre 0 y -1 ok DE; P/T = -1 DE; IMC = -1 DE.

Palidez mucocutánea, BEAB, se auscultan algunos rales subcrepitantes bibasales, abdomen globoso, doloroso a la palpación profunda, a la predominio de la región periumbilical, sin reacción peritoneal, hígado a 1 cm de reborde costal, se palpa polo de bazo.

Se realizó: radiografía de tórax con infiltrado intersticial inespecífico y radiografía de abdomen de pie con asas intestinales distendidas y niveles hidroaéreos.

Los análisis de laboratorio evidenciaron: glóbulos blancos 18000/mm3, NS 40%, 15% Eo, M 5%, Hb 9.8 gr/dl, VCM 65 fl, albúmina de 3,1 g/dl, transaminasas normales, fosfatasa alcalina (FAL) normal.

Sedimento urinario: ph 6, densidad 1020, Leucocitos 2-3/cpo.

¿Cuál de las siguientes conductas iniciales considera las más correctas? Marcar hasta 3 opciones.

- A. Indicar tratamiento antibiótico empírico parenteral
- B. Solicitar tomografía de abdomen con doble contraste
- C. Realizar endoscopia digestiva
- D. Indicar enemas con solución fisiológica
- E. Comenzar con ayuno y colocar sonda nasogástrica abierta**
- F. Comenzar con líquidos vía oral fraccionados
- G. Indicar tratamiento antiparasitario urgente
- H. Indicar hidratación por sonda nasogástrica
- I. Realizar interconsulta con Servicio de Cirugía Infantil**
- J. Indicar hidratación parental**

Valentin de 3 meses de edad, es traído a la consulta por sus padres por presentar vómitos desde la primera semana de vida. Los vómitos son generalmente postprandiales, sin

esfuerzo, abundantes, intercalados con regurgitaciones de menor volumen. En ocasiones, vomita hasta 4 o 5 veces después de haber finalizado la ingesta. La mamá se encuentra preocupada y afirma que, a veces, “vomita toda la toma”.

Valentín se alimenta con lactancia materna exclusiva a demanda, toma 6-10 veces al día y descansa bien después de cada toma.

Antecedentes personales: Embarazo controlado de curso normal. Parto por cesárea por falta de progresión. Cribado neonatal de enfermedades metabólicas congénitas negativos. Peso al nacer: 3450 gramos. Talla: 49cm

Antecedentes familiares: madre alérgica a polenes de gramíneas con asma estacional tratada con corticoides durante la primavera. Padre con rinitis alérgica. Hermano de 6 años diagnosticado de enfermedad celíaca hace 2 años.

Examen físico: Peso actual: 6.100kg. talla: 61,0 cm. Buen estado general. Mucosas húmedas. Conjuntivas rosadas. Aparato cardiovascular: se auscultan 2 ruidos en los cuatro focos, sin ruidos agregados. Frecuencia cardíaca: 130 latidos por minuto. Aparato respiratorio: buena entrada de aire en ambos pulmones. Frecuencia respiratoria: 35 respiraciones por minuto. Abdomen blando, depresible. Hígado: altura 6.5cm, se palpa borde inferior en línea mamilar a 2cm bajo el reborde costal.

En consideración al problema de Valentín, ¿cuáles son las conductas más apropiadas?

- A. Solicitar una seriada gastroduodenal.
- B. Controlar la curva ponderoestatural sin indicar medicación.**
- C. Indicar a los padres que Valentín debe dormir en decúbito supino.
- D. Solicitar la realización de una pHmetría.
- E. Explicar a los padres acerca del riesgo potencial de desarrollar una esofagitis.**
- F. Solicitar una ecografía del canal pilórico.
- G. Explicar a los padres que los síntomas se atenuarán con el inicio de la alimentación semisólida.**
- H. Iniciar tratamiento con antieméticos previo a cada toma de alimento.

Patricio, de 3 años, es llevado a consulta por sus padres. Refieren que notaron que su hijo despertó por la mañana con la cara hinchada y creen que presenta una reacción alérgica. Asimismo, relatan que les costó ponerle los zapatos. No tiene antecedentes de infecciones previas.

Examen físico: Peso actual 20,100 Kg. Talla 98 cm. Estable, afebril. Se observa edema de ambos párpados y de miembros en los cuales deja fovea. No se observan edemas a nivel de los genitales. Presión arterial 108/70 mm/Hg. La auscultación pulmonar impresiona normal. Abdomen distendido, globuloso, levemente doloroso a la palpación. Borde hepático a 2 cm bajo el reborde costal. Orina normocoloreada, con espuma.

Con los datos disponibles, ¿cuáles son las conductas iniciales más apropiadas? (Puede marcar hasta 3 opciones)

- A. Indicar furosemida hasta la desaparición de los edemas.
- B. Internar a Patricio e indicar dieta hiposódica y normoproteica.
- C. Solicitar biopsia renal lo antes posible.
- D. Indicar dieta normosódica e hiperproteica.
- E. Solicitar PPD y Teleradiografía de tórax.
- F. Solicitar orina completa, hisopado de fauces, C3, C4, ASTO, Streptozyme.
- G. Citar a Patricio para control ambulatorio.
- H. Solicitar orina completa, proteinograma, lipidograma

Acompañado por su madre y tía materna concurre a la guardia Ariel, de 10 años, por decaimiento durante la última semana, sumando tos y agitación al caminar desde hace 48 horas. El niño comenta que la orina ha adquirido un color oscuro desde hace varios días. Un compañero de su grado está cursando una hepatitis hace un mes. Vacunación completa.

Al examen físico: frecuencia cardíaca 146 latidos por minuto. Presión arterial 140/100 mm. Frecuencia respiratoria 36 por minuto. Temperatura axilar 36,7 °C. Aspecto agudamente enfermo, pálido, edema bipalpebral, bilateral. Sin aleteo nasal ni estridor inspiratorio, ligero tiraje subcostal, buena entrada de aire bilateral, sibilancias aisladas, estertores crepitantes en ambas bases pulmonares. Segundo ruido cardíaco ligeramente aumentado de intensidad, silencios libres. Pulsos periféricos presentes. Abdomen levemente doloroso en hipocondrio derecho, sin esplenomegalia. Puño percusión negativa. En miembros inferiores numerosas máculas hiperpigmentadas cicatrizales y algunas lesiones con costras melicéricas.

¿Cuáles son las conductas diagnósticas iniciales más adecuadas? (Puede marcar hasta 3 opciones)

- A. Solicitar urocultivo al acecho y comenzar tratamiento antibiótico vía oral.
- B. Solicitar hepatograma y anticuerpos IgM para hepatitis A.
- C. Solicitar ecografía de hígado y vías biliares
- D. Solicitar teleradiografía de tórax frente.
- E. Solicitar uremia, creatininemia y examen de orina completo.
- F. Solicitar C3 y C4, anticuerpos anti estreptocócicos.
- G. Solicitar ecocardiograma urgente.
- H. Indicar prueba de respuesta a broncodilatadores.

Concurre a la guardia donde usted trabaja, Amalia, de 9 meses, por fiebre (38-38,5 °C) que cede transitoriamente con medios físicos y tos durante las últimas 72 horas que interrumpió su sueño durante la última noche. Ha mantenido una buena actitud alimentaria.

Antecedentes personales: Vacunas completas. Tuvo un resfrío, dos otitis medias agudas y una gastroenteritis aguda, todos con buena evolución. Su padre, 24 años, albañil, su madre, 27 años, ama de casa, ambos sanos. Viven a 12 cuadras del hospital.

Al examen físico luce en buen estado general, rosada. Frecuencia cardíaca 136/minuto. Presión arterial 90/56 mm Hg. Frecuencia respiratoria 44 por minuto. Saturometría con aire ambiental 96 %. Temperatura axilar 37,6 °C. Fauces levemente congestivas, ambos tímpanos rosados con triángulo luminoso presente. Sin aleteo nasal, leve tiraje intercostal, murmullo vesicular presente, sibilancias al final de la espiración en ambas bases pulmonares. Resto del examen sin particularidades.

¿Cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? (Puede marcar hasta 3 opciones)

- A. Solicitar aspirado nasofaríngeo de secreciones respiratorias.
- B. Indicar nebulizaciones con budesonide cada 8 horas.
- C. Internar al paciente con oxígeno
- D. Indicar paracetamol por vía oral si tuviera fiebre.**
- E. Continuar con la alimentación por vía oral.**
- F. Citar a control en 24-48 horas.**
- G. Indicar ibuprofeno y paracetamol alternados si tuviera fiebre.
- H. Indicar bromuro de ipratropio por aerocámara cada 12 horas.

Manuel, de 16 años, concurre con su papá al consultorio de Pediatría debido a que presenta una tumoración en la axila derecha, de 30 días de evolución, en ocasiones levemente dolorosa. Nunca tuvo fiebre. Refieren que hace 15 días consultaron a un centro de salud cercano, donde le indicaron tratamiento oral con cefalexina que cumplió durante 14 días, pero que al no notar cambios luego del mismo, deciden consultar nuevamente. En la anamnesis el padre dice que nota que Manuel bajó mucho de peso en el último tiempo. Viven en el conurbano, alquilan una habitación en un hotel familiar, baño y cocina compartidos, tienen un gato. Cloacas: no, agua de pozo. Antecedentes de vacunación completa con cicatriz de BCG.

Al examen físico Manuel se encuentra en buen estado general, afebril, en suficiencia cardiorrespiratoria; Peso: 50.0 kg (Pc 10), Talla: 166.0 cm (Pc 25-50). Se constata una tumoración axilar derecha, dura, algo dolorosa a la palpación, de 4 x 4 cm de diámetro aproximado, adherida a planos profundos, lo que limita moderadamente la movilidad del miembro superior derecho. No presenta otras adenomegalias, sí se palpan microadenopatías submaxilares e inguinales. Resto de examen físico sin otras particularidades.

En relación a lo previamente mencionado, cuáles son sus hipótesis diagnósticas mas probables? (Puede marcar hasta 3 opciones)

- A. Infección por Citomegalovirus.
- B. Tuberculosis.**
- C. Infección por Epstein-Barr.
- D. Adenitis abscedada.
- E. Rabdomiosarcoma.
- F. Toxoplasmosis.
- G. Linfoma**

H. Enfermedad por arañazo de gato

Usted se encuentra en un centro de atención primaria y recibe a Bautista, de tres meses de edad. La mamá, Mariana, lo trae a la consulta porque lo nota agitado y presenta sudoración al alimentarse. Según cuenta Mariana ella nota que Bautista se cansa cuando lleva unos minutos succionando el pecho. Mariana no controló el embarazo porque tenía miedo de concurrir a la salita por la pandemia de COVID-19. No hay antecedentes patológicos familiares. Bautista nació a las 38 semanas, por parto vaginal, con un peso de nacimiento de 2.950 gramos. Tiene pesquisa endocrino-metabólica normal y OEA normales. Recibió las vacunas de acuerdo al calendario nacional. Se alimenta con pecho exclusivo. Usted constata en el examen físico: Palidez cutáneo-mucosa leve. Peso actual: 4100 gr. FC: 140 latidos/minuto, FR: 54 respiraciones/minuto, Sat 98% AA. Afebril. Leve tiraje subcostal. Auscultación cardíaca: soplo pansistólico, intensidad 3/6, audible en múltiples focos, con mayor intensidad en 3er y 4to espacio intercostal izquierdo. Pulsos periféricos simétricos. Abdomen: blando, depresible, se palpa borde hepático 3 cm debajo del reborde costal.

Según su hipótesis diagnóstica, cuáles son las conductas iniciales mas adecuadas? (Puede marcar hasta 3 opciones)

- A. Solicita ecografía abdominal.
- B. Solicita evaluación en un centro de mayor complejidad.**
- C. Indica corticoides por vía oral.
- D. Solicita ECG y ecocardiograma.**
- E. Indica serie de salbutamol inhalado y observa respuesta clínica.
- F. Indica corticoides inhalados.
- G. Solicita urgente hemograma con frotis y hepatograma.
- H. Indica ofrecer el pecho de forma fraccionada**

Concurre a la guardia del hospital, Pedro, de 5 años de edad, acompañado por sus padres que se muestran preocupados porque su hijo presentó emisión de orinas oscuras en dos oportunidades. Hasta la mañana de ese día el niño había concurrido al jardín sin haber presentado ninguna sintomatología previa. Exámen físico: Peso: 16.200kg. Talla: 106.0 cm. Tensión arterial: 120/80 mmHg. To axilar: 36.4oC.Frecuencia respiratoria: 20 respiraciones/minuto. Frecuencia cardíaca: 100 latidos/minuto. Rinitis serosa moderada. Rales subcrepitantes bibasales. Discreta palidez de piel y mucosas. Lesión costrosa residual de 2 cm de diámetro en su rodilla izquierda de 15 días de evolución. Ganglio palpable en región inguinal derecha de 1 cm de diámetro y otro de 1.5 cm de diámetro ligeramente doloroso en región inguinal izquierda. Hígado a 1 cm del reborde costal, indoloro. Bazo no palpable. Signo de Godet positivo (+) en miembros inferiores. Resto del examen físico sin particularidades.

Los estudios complementarios son los siguientes: Hemograma: hematocrito: 36%, hemoglobinemia 11 gr/dl, leucocitos: 9.800/mm³ (neutrófilos 55%, linfocitos 40%, eosinófilos 3%, monocitos 2%). Plaquetas: 220.000/mm³. Uremia: 86 mg/dl. Ionograma: 132 mEq/l de sodio y potasio 3,8 mEq/l. Creatininemia: 0,8 mg/dl. Orina completa: densidad: 1015, pH 6, proteínas +, leucocitos 10-15/campo, hematíes 10-15 por campo. Se observan cilindros

hialinos y granulosos. Teleradiografía de tórax: índice cardiorácico 0,55, leve infiltrado bibasal.

¿Cuál de las siguientes son las conductas iniciales más adecuadas? (Marque hasta 3 opciones)

- A. Hidratación parenteral a necesidades basales más diuresis.
- B. Control ambulatorio en 24 horas.
- C. Internar al paciente**
- D. Indicar furosemida**
- E. Restricción hídrica**
- F. Indicar metilprednisona.
- G. Indicar inotrópicos.
- H. Indicar ceftriaxona.